

Bunga Rampai

ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DAN MENYUSUI

Nana Usnawati • Febrina Dwi Nurcahyanti • Ratna Diana Fransiska
Septa Dwi Insani • Ima Candra Kusuma • Wilda Rezki Pratiwi

Editor: Uliyatul Laili



BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DAN MENYUSUI

Penulis:

Bdn. Nana Usnawati, S.ST., M.Keb.
Febrina Dwi Nurcahyanti, S.ST., MPH.
Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.
Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.
Ima Candra Kusuma, S.ST., M.Tr.Keb.
Bdn. Wilda Rezki Pratiwi, S.ST., M.Kes.

Editor:

Uliyatul Laili, S.ST., Bdn., M.Keb.

BUNGA RAMPAI: ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS DAN MENYUSUI

Penulis:

Bdn. Nana Usnawati, S.ST., M.Keb.
Febrina Dwi Nurcahyanti, S.ST., MPH.
Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.
Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.
Ima Candra Kusuma, S.ST., M.Tr.Keb.
Bdn. Wilda Rezki Pratiwi, S.ST., M.Kes.

Editor: Uliyatul Laili, S.ST., Bdn., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-59-6

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Rights Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

TikTok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga berjudul *Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memperkaya referensi ilmiah dan praktis bagi mahasiswa, pendidik, serta praktisi kebidanan dalam memberikan asuhan yang komprehensif pada ibu masa nifas dan menyusui.

Masa nifas merupakan periode penting setelah persalinan yang ditandai dengan proses pemulihan fisiologis, adaptasi psikologis, serta penyesuaian peran ibu dalam keluarga. Pada fase ini, berbagai perubahan terjadi secara cepat dan kompleks sehingga memerlukan pemantauan serta asuhan kebidanan yang tepat untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu. Di sisi lain, menyusui menjadi aspek krusial yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan nutrisi bayi, tetapi juga berdampak pada kesehatan ibu, ikatan ibu-bayi, serta keberhasilan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui harus dilaksanakan secara holistik, berkesinambungan, dan berbasis bukti.

Bunga rampai ini memuat rangkaian pembahasan yang disusun sistematis untuk menggambarkan cakupan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Bab 1 mengulas konsep dasar masa nifas dan laktasi sebagai landasan pemahaman dalam pemberian asuhan. Bab 2 membahas perubahan fisiologis dan psikologis yang dialami ibu nifas, termasuk proses involusi, adaptasi hormonal, hingga respons emosional pascapersalinan. Bab 3 berfokus pada pengkajian kebidanan pada ibu postpartum, sebagai langkah awal dalam menentukan kebutuhan dan perencanaan asuhan yang tepat. Selanjutnya, Bab 4 menyajikan perawatan ibu nifas sekaligus penekanan pada deteksi dini komplikasi, sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Bab 5 menguraikan dukungan pemberian ASI, termasuk teknik menyusui yang benar serta strategi mengatasi hambatan menyusui. Terakhir, Bab 6 menekankan peran keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam pemulihan ibu dan keberhasilan menyusui, mengingat keterlibatan keluarga dapat meningkatkan kenyamanan, kepatuhan, dan keberlanjutan praktik menyusui.

Kami menyadari bahwa keberhasilan asuhan kebidanan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan klinis, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi, edukasi, empati, dan kolaborasi dengan keluarga serta tenaga kesehatan lainnya. Karena itu, buku ini diharapkan mampu menjadi rujukan yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas

pelayanan kebidanan, khususnya pada masa nifas dan menyusui, serta mendorong terwujudnya ibu dan bayi yang sehat secara fisik maupun psikososial.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini pada edisi berikutnya. Semoga bunga rampai ini memberikan manfaat yang luas dan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan dan praktik kebidanan di Indonesia.

Juni, 2026

Penulis



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR MASA NIFAS DAN LAKTASI	
Bdn. Nana Usnawati, S.ST., M.Keb.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Masa Nifas	2
C. Proses Laktasi	6
D. Simpulan	13
Referensi	14
Glosarium.....	16

CHAPTER 2 PERUBAHAN FISILOGI DAN PSIKOLOGIS PADA IBU NIFAS	
Febrina Dwi Nurcahyanti, S.ST., MPH.	18
A. Pendahuluan.....	18
B. Materi.....	18
C. Simpulan	33
Referensi	35
Glosarium.....	36

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEBIDANAN PADA IBU POSTPARTUM	
Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.	37
A. Konsep Dasar Pengkajian Postpartum	37
B. Pengkajian Data Subjektif (Anamnesis)	37
C. Pengkajian Data Objektif (Pemeriksaan Fisik dan Penunjang)	43
Referensi	53
Glosarium.....	55

CHAPTER 4 PERAWATAN IBU NIFAS DAN DETEKSI DINI KOMPLIKASI	
Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.....	56
A. Pendahuluan.....	56
B. Konsep Dasar Masa Nifas	57
C. Tujuan Perawatan Ibu Nifas	59
D. Perubahan Fisiologi pada Ibu Nifas	60

E. Perubahan Psikologi pada Ibu Nifas.....	65
F. Simpulan	68
Referensi	70

CHAPTER 5 DUKUNGAN PEMBERIAN ASI DAN TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR

Ima Candra Kusuma, S.ST., M.Tr.Keb.....	73
A. Pendahuluan.....	73
B. Dukungan Pemberian ASI.....	75
C. Peran Keluarga dalam Dukungan Pemberian ASI.....	77
D. Posisi menyusui yang benar.....	79
E. Teknik Menyusui yang Benar.....	83
F. Perlekatan Menyusui	84
Referensi	89
Glosarium.....	92

CHAPTER 6 PERAN KELUARGA DALAM PEMULIHAN IBU DAN KEBERHASILAN MENYUSUI

Bdn. Wilda Rezki Pratiwi, S.ST., M.Kes.	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Dinamika Peran Keluarga dalam Kesehatan Ibu Nifas	94
C. Peran Keluarga dalam Pemulihan Fisik Ibu	98
D. Peran Keluarga Dalam Kesehatan Mental Ibu.....	99
E. Peran Keluarga dalam Keberhasilan Menyusui.....	102
F. Hambatan dalam Dukungan Keluarga terhadap Ibu Nifas dan Menyusui	104
G. Simpulan	105
Referensi	107

PROFIL PENULIS	113
-----------------------------	------------



CHAPTER 1



KONSEP DASAR MASA NIFAS DAN LAKTASI

Bdn. Nana Usnawati, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Masa pascapersalinan, juga dikenal sebagai masa nifas dan "trimester keempat," mengacu pada minggu-minggu setelah kelahiran ketika perubahan fisiologis yang berkaitan dengan kehamilan kembali ke keadaan tidak hamil. Selain perubahan fisiologis dan masalah medis yang mungkin timbul selama periode ini, penyedia layanan kesehatan obstetri harus menyadari kebutuhan kesehatan mental ibu pascapersalinan dan peka terhadap praktik budaya yang berbeda terkait dengan persalinan, yang mungkin melibatkan konsumsi makanan tertentu dan pembatasan aktivitas tertentu.

Masa nifas (*puerperium*) adalah periode sejak lahirnya plasenta hingga pulihnya organ reproduksi ke keadaan sebelum hamil, yang berlangsung sekitar enam minggu atau 42 hari. Masa ini merupakan fase transisi yang kompleks, melibatkan perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial. Pada saat yang sama, laktasi sebagai proses produksi dan pengeluaran air susu ibu (ASI) menjadi fondasi utama kesehatan bayi dan ibu (Berens Pamela, M.D., 2026).

Hari-hari dan minggu-minggu setelah melahirkan (periode pascapersalinan) adalah fase kritis dalam kehidupan ibu dan bayi yang baru lahir. Sebagian besar kematian ibu dan bayi terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran: hampir setengah dari kematian ibu pascapersalinan terjadi dalam 24 jam pertama dan 66% terjadi selama minggu pertama. Pada tahun 2013, 2,8 juta bayi baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupan mereka—1 juta dari bayi baru lahir ini meninggal pada hari pertama. Kemajuan yang cukup besar telah dicapai secara global dalam meningkatkan kesehatan ibu. Di seluruh dunia, 72% wanita melahirkan didampingi oleh tenaga terampil dan rasio kematian ibu telah menurun dari 380 menjadi 210 per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2000 dan 2013. Namun, di Asia Tenggara dan Afrika sub-Sahara hanya 67% dan 48% wanita yang melahirkan dengan bantuan personel terampil. Perawatan pascapersalinan menjangkau lebih sedikit wanita dan bayi baru lahir: kurang dari setengah wanita menerima kunjungan perawatan pascapersalinan dalam waktu 2 hari setelah melahirkan. Analisis data Survei Demografi dan Kesehatan dari 23 negara Afrika sub-Sahara menemukan bahwa

hanya 13% wanita yang melahirkan di rumah menerima perawatan pascapersalinan dalam waktu 2 hari setelah melahirkan Kelahiran (WHO, 2015).

Sejalan dengan *SDGs* dan Strategi Global untuk Kesehatan Perempuan, Anak dan Remaja, dan sesuai dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, upaya perawatan pascapersalinan harus diperluas melampaui cakupan dan kelangsungan hidup saja untuk mencakup kualitas perawatan. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan pascapersalinan rutin yang penting untuk wanita dan bayi baru lahir dengan tujuan akhir meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Ini mengakui "pengalaman pascapersalinan yang positif" sebagai titik akhir yang signifikan bagi semua wanita yang melahirkan dan bayi mereka yang baru lahir, meletakkan platform untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan jangka pendek dan panjang (WHO, 2022).

Signifikansi masa nifas dan laktasi tidak hanya terletak pada pemulihan fisik ibu, tetapi juga pada keberhasilan menyusui yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang bayi. WHO (2023) menekankan bahwa periode postnatal adalah salah satu fase paling kritis dalam siklus hidup reproduksi, dengan risiko tinggi morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal.

Pengalaman pascapersalinan yang positif didefinisikan sebagai pengalaman di mana wanita, bayi baru lahir, pasangan, orang tua, pengasuh, dan keluarga menerima informasi, kepastian, dan dukungan secara konsisten dari petugas kesehatan yang termotivasi; di mana sistem kesehatan yang memiliki sumber daya dan fleksibel mengakui kebutuhan perempuan dan bayi, dan menghormati konteks budaya mereka (WHO, 2022).

B. Konsep Dasar Masa Nifas

1. Pengertian Masa Nifas

Terdapat konsensus bahwa periode pascapersalinan dimulai setelah kelahiran bayi. Akhir periode ini kurang jelas definisinya, tetapi sering dianggap enam hingga delapan minggu setelah kelahiran karena efek kehamilan pada banyak sistem sebagian besar telah kembali ke keadaan sebelum kehamilan pada saat ini. Namun, tidak semua sistem organ kembali ke kondisi semula dalam periode ini, dan kembalinya ke kondisi semula tidak selalu linier dari waktu ke waktu. Karena alasan ini, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) menganggap perawatan pascapersalinan berlangsung hingga 12 minggu setelah melahirkan dan menyebut 12 minggu ini sebagai "trimester keempat." Beberapa peneliti menganggap individu berada dalam periode pascapersalinan hingga 12 bulan setelah melahirkan (Berens Pamela, M.D., 2026).

Masa nifas (puerperium) adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan Kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu, akan tetapi, seluruh alat genital baru pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 3 bulan (Prawirohardjo, 2009).

Masa nifas adalah masa segera setelah kelahiran sampai 6 minggu. Selama masa ini, fisiologi saluran reproduktif kembali pada keadaan yang normal (Cunningham, 2007).

Masa nifas (puerperium) adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan Kembali seperti prahamil. Lama masa nifas 6-8 minggu (Mochtar, 2010).

2. Periode Masa Nifas

Masa pascapersalinan adalah periode setelah kelahiran janin ketika perubahan fisiologis dan anatomi ibu kembali ke keadaan tidak hamil. Masa pascapersalinan, juga dikenal sebagai masa nifas, dimulai setelah keluarnya plasenta hingga pemulihan fisiologis lengkap dari berbagai sistem organ.

Masa pascapersalinan dibagi menjadi 3 fase, yaitu: fase akut – 24 jam pertama setelah keluarnya plasenta; awal – hingga 7 hari; dan akhir – hingga 6 minggu sampai 6 bulan. Setiap fase memiliki pertimbangan dan tantangan klinis yang unik (Gaurav Chauhan; Prasanna Tadi., 2022).

Tahapan yang terjadi pada masa nifas sebagai berikut :

a. Periode *Immediate Postpartum*

Berlangsung dalam 24 jam pertama setelah lahirnya plasenta, di mana risiko perdarahan akibat atonia uteri harus diantisipasi melalui pemantauan kontraksi, lokia, tekanan darah, dan suhu tubuh.

b. Periode *Early Postpartum* (24 jam-1 minggu). Pada fase ini menekankan pada pemeriksaan involusi uterus, pencegahan perdarahan dan infeksi, kecukupan nutrisi serta cairan, serta keberhasilan menyusui.

c. Periode *Late Postpartum* (>1 Minggu-6 Minggu)

Berfokus pada perawatan rutin, evaluasi kesehatan ibu, dan konseling keluarga berencana.

d. *Remote Puerperium*

Menggambarkan periode pemulihan lebih panjang, terutama bagi ibu dengan komplikasi selama hamil atau persalinan.

Tahapan masa nifas yaitu:

a. Puerperium dini: Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari.

- b. *Puerperium intermedia*: Kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 minggu.
 - c. *Remote puerperium*: Tahap pemulihan sempurna, waktu lebih lama bila ada penyulit/komplikasi.
3. Tujuan Asuhan Masa Nifas
- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis dimana dalam asuhan pada masa ini peranan keluarga sangat penting, dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologi maka kesehatan ibu dan bayi selalu terjaga.
 - b. Melaksanakan skrining yang komprehensif (menyeluruh), proses ini mencakup tahapan pengkajian kondisi ibu dan bayi, interpretasi data serta analisis masalah yang ditemukan, dilanjutkan dengan perencanaan intervensi yang sesuai, penatalaksanaan tindakan kebidanan, dan evaluasi hasil asuhan. Dengan pendekatan menyeluruh tersebut, bidan dapat mendeteksi secara dini adanya penyulit maupun komplikasi, sehingga intervensi dapat dilakukan tepat waktu dan risiko kesehatan ibu serta bayi dapat diminimalkan.
 - c. Melakukan rujukan secara aman dan tepat waktu Jika terjadi penyulit atau komplikasi, rujukan dilakukan secara aman ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai.
 - d. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan nifas dan menyusui, kebutuhan nutrisi, perencanaan pengaturan jarak kelahiran, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, perawatan bayi sehat serta memberikan pelayanan keluarga berencana, sesuai dengan pilihan ibu.

4. Pentingnya Asuhan Masa Nifas

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi 42 hari pertama (6 minggu) setelah kelahiran sebagai waktu yang sangat kritis bagi ibu dan anak, karena sebagian besar komplikasi pascapersalinan terjadi selama periode ini. Perawatan pascapersalinan yang tepat sangat penting untuk mencegah dan mengelola komplikasi melalui deteksi dini masalah seperti perdarahan pascapersalinan, infeksi, atau penyakit kuning pada bayi baru lahir. Pemulihan Ibu dengan membantu pemulihan fisik dan hormonal tubuh setelah persalinan. Perkembangan Bayi dengan membimbing praktik tidur yang aman, vaksinasi, dan nutrisi. Kesejahteraan Emosional dengan melakukan skrining dan mengelola fluktuasi suasana hati, seperti depresi pascapersalinan. (Wojcieszek AM, Bonet M, Portela A, Althabe F, Bahl R, Chowdhary N, et al., 2023)

Asuhan masa nifas sangat penting karena beberapa alasan:

- a. Transisi yang Lancar: Peralihan dari kehamilan ke peran sebagai orang tua bisa sangat melelahkan. Bidan memberikan bimbingan dan bantuan untuk membantu ibu nifas melewati transisi ini dengan lancar.
 - b. Deteksi Dini Masalah Kesehatan: Pemeriksaan rutin memberikan kepastian tetapi juga bertujuan untuk menyoroti potensi masalah kesehatan bagi ibu nifas dan bayi serta memungkinkan intervensi tepat waktu untuk memastikan pemulihan yang lancar.
 - c. Kesejahteraan Emosional: Perubahan hormon dan kurang tidur dapat menyebabkan fluktuasi suasana hati. Bidan memberikan dukungan emosional, membantu mengelola stres dan mengurangi risiko gangguan suasana hati pascapersalinan, serta memberikan bantuan yang tepat bila ibu nifas membutuhkannya.
 - d. Membangun Ikatan dan Memberi Makan: Bidan akan mendorong terjalinnya ikatan antara ibu dan bayi, menawarkan panduan berharga tentang pemberian makan (ASI atau susu formula), perawatan bayi dan ibu.
5. Asuhan yang Diterima pada Masa Nifas

Asuhan masa nifas mencakup serangkaian layanan penting yang memenuhi kebutuhan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis. Pada beberapa hari pertama, baik di rumah sakit maupun di rumah, pemulihan fisik ibu nifas akan dipantau, dan panduan tentang perawatan diri masa nifas akan diberikan. Ibu nifas dan bayi periksa ke fasilitas kesehatan setidaknya 4 kali kunjungan, yaitu pada 6-48 jam pertama, 3-7 hari, 8-28 hari dan 29-42 hari (Kementerian Kesehatan R.I., 2024)

Kunjungan nifas bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesinambungan asuhan.
Hal ini akan meningkatkan keamanan asuhan dan meningkatkan hasil spesifik (seperti tingkat keberhasilan menyusui), serta kepuasan perawatan secara keseluruhan.
- b. Mendukung Pemulihan Fisik
- c. Bidan memastikan tubuh ibu nifas pulih dengan baik setelah melahirkan, dengan pemeriksaan fisik yang menyeluruh dan teratur, serta merespons setiap kekhawatiran yang mungkin dialami ibu nifas.
- d. Dukungan Emosional: Perawatan pascapersalinan mencakup dukungan kesehatan mental. Bidan memberikan dukungan emosional untuk membantu ibu nifas menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama bayi baru.
- e. Bantuan Menyusui: Bidan memberikan edukasi tentang teknik menyusui, pelekatan puting, dan mengatasi masalah menyusui. Bayi baru lahir yang perlu menyusu setiap 2-3 jam.

- f. Pemeriksaan dan Skrining Kesehatan Bayi Baru Lahir: Kesejahteraan bayi menjadi prioritas. Pemeriksaan rutin akan menilai pertumbuhan, pemberian makan, dan kesehatan bayi secara keseluruhan. Baru Lahir), dan tes pendengaran.
- g. Saran dan Edukasi tentang Pengasuhan Anak: Bidan memberikan tips berharga tentang asuhan bayi baru lahir, praktik tidur yang aman, dan teknik untuk menenangkan dan merawat bayi.
- h. Kontrasepsi dan Perencanaan Keluarga: Diskusi tentang pilihan kontrasepsi yang aman dan perencanaan keluarga diberikan sebelum diijinkan pulang.
- i. Akses ke Dukungan Multidisiplin: Terkadang, tantangan pemberian makan memerlukan keahlian Konsultan Laktasi.

C. Proses Laktasi

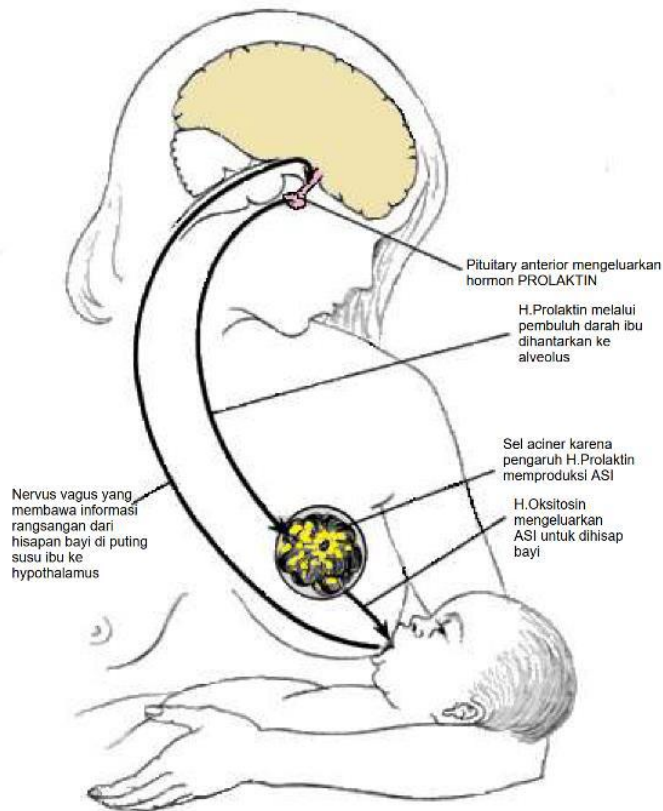
1. Pengertian laktasi

Laktasi atau proses menyusui merupakan mekanisme yang kompleks, mencakup dua aspek utama yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Selama kehamilan, payudara mengalami perkembangan untuk mempersiapkan diri mengambil alih fungsi nutrisi bayi dari plasenta, dengan perubahan mulai tampak sejak usia kehamilan 16 minggu. Aktivitas produksi ASI pada masa ini masih dihambat oleh keseimbangan hormon tertentu, namun hambatan tersebut menurun beberapa jam hingga hari-hari awal setelah persalinan sehingga payudara mulai mampu menghasilkan ASI. Perubahan hormonal, khususnya peningkatan estrogen dan progesteron, menyebabkan pembesaran payudara dan pematangan kelenjar. Pada usia kehamilan sekitar lima bulan, pengaruh hormon prolaktin dan laktogen mulai merangsang keluarnya kolostrum dalam jumlah kecil sebagai tahap awal proses laktasi.

2. Fisiologi Laktasi

a. Produksi (pembuatan) ASI

Produksi ASI merupakan proses fisiologis yang dipengaruhi oleh perubahan hormonal setelah persalinan. Selama kehamilan, kadar hormon prolaktin meningkat, namun produksi ASI belum terjadi karena masih dihambat oleh tingginya kadar estrogen dalam darah. Setelah bayi lahir, tepatnya pada hari kedua hingga ketiga, kadar estrogen dan progesteron menurun drastis sehingga efek prolaktin menjadi dominan. Kondisi ini merangsang alveoli di payudara untuk mulai menghasilkan ASI. Dengan mekanisme tersebut, produksi ASI biasanya mencapai tingkat optimal sekitar 72 jam pascapersalinan.

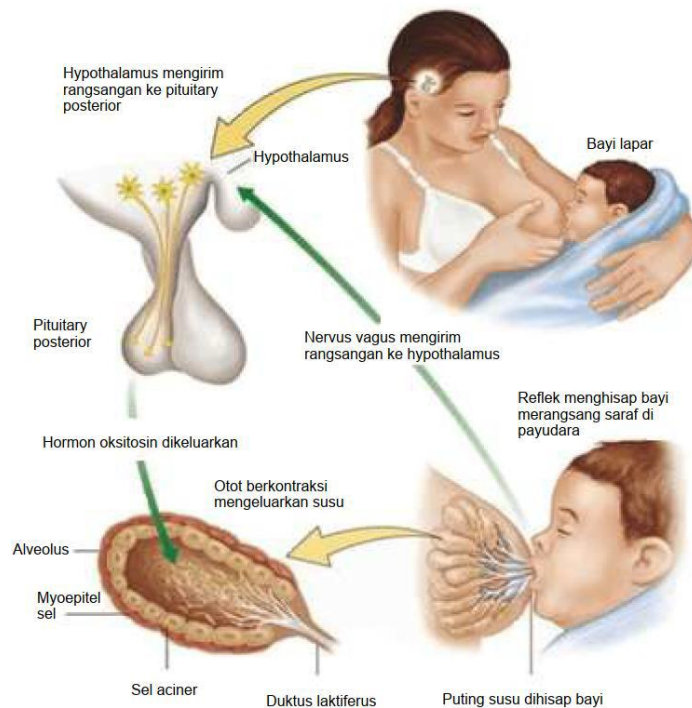


Gambar 1. 1 Reflek Prolaktin

Menyusui segera setelah bayi lahir memiliki peran penting karena stimulasi pada puting akan memicu refleksi prolaktin. Isapan bayi mengaktifkan serabut saraf yang kemudian merangsang hipofisis anterior di otak untuk melepaskan hormon prolaktin ke dalam aliran darah. Hormon ini bekerja pada sel-sel kelenjar payudara sehingga produksi ASI meningkat. Mekanisme ini dikenal sebagai refleksi prolaktin. Semakin sering bayi menyusui, semakin banyak prolaktin yang dilepaskan dan semakin optimal produksi ASI. Sebaliknya, jika frekuensi menyusui berkurang, maka produksi ASI juga akan menurun.

b. Pengeluaran ASI

Ketika bayi mengisap langsung puting ibu, rangsangan tersebut memicu serabut saraf yang kemudian mengaktifkan hipofisis posterior di otak untuk melepaskan hormon oksitosin ke dalam aliran darah. Oksitosin bekerja pada sel-sel mioepitel di sekitar alveoli payudara, menyebabkan kontraksi yang mendorong ASI keluar dari kantong alveoli menuju saluran susu hingga ke puting. Mekanisme ini dikenal sebagai refleksi letdown. Pada beberapa kondisi, kontraksi otot dapat begitu kuat sehingga aliran ASI keluar dengan deras hingga menyembur, yang berpotensi membuat bayi tersedak bila tidak diantisipasi dengan baik.



Gambar 1. 2 Reflek Letdown

Pada bayi yang telah berusia lebih dari enam bulan dan mulai mendapatkan makanan pendamping, refleks letdown maupun refleks prolaktin secara bertahap akan berkurang sehingga produksi ASI pun menurun hingga akhirnya berhenti. Alveoli di payudara mengalami peluruhan, kemudian terbentuk kembali seiring siklus menstruasi berikutnya. Mekanisme ini berfungsi mencegah penumpukan ASI ketika bayi berhenti menyusui. Proses menyusui langsung maupun pemerasan ASI tetap menjadi faktor penting dalam mempertahankan produksi, di mana semakin sering bayi menyusui maka semakin banyak ASI yang dihasilkan, sedangkan frekuensi menyusui yang jarang akan menurunkan produksi.

Selain perubahan hormonal pada ibu, bayi juga menunjukkan tiga refleks utama dalam proses menyusui, yaitu *rooting* (mencari puting), *suckling* (mengisap), dan *swallowing* (menelan).

- 1) *Refleks Rooting* adalah respons bayi untuk mencari puting ketika pipinya disentuh, ia akan menoleh ke arah rangsangan. Jika bibirnya disentuh, bayi membuka mulut dan berusaha menemukan puting untuk menyusui, dengan lidah yang keluar serta melengkung guna menangkap puting dan areola.
- 2) *Refleks Suckling* merupakan refleks mengisap yang terjadi saat areola masuk ke dalam mulut bayi. Rangsangan pada puting mengenai langit-

langit keras (palatum durum), sehingga areola dan puting tertekan oleh gusi, lidah, dan langit-langit. Tekanan ini memengaruhi sinus laktiferus di bawah areola, lalu memicu gerakan peristaltik yang mengalirkan ASI ke mulut bayi.

- 3) *Refleks Swallowing* adalah refleks menelan ASI yang sudah berada di dalam mulut bayi, ditandai dengan gerakan otot menelan. Pada akhir masa kehamilan, payudara ibu sering mengeluarkan kolostrum, dan setelah persalinan ketika bayi mulai menyusu, produksi ASI meningkat dengan cepat.

Menyusui adalah salah satu cara paling efektif untuk memastikan kesehatan dan kelangsungan hidup anak. Namun, bertentangan dengan rekomendasi WHO, kurang dari setengah bayi di bawah usia 6 bulan hanya diberi ASI eksklusif. ASI adalah makanan ideal untuk bayi. ASI aman, bersih, dan mengandung antibodi yang membantu melindungi dari banyak penyakit umum pada anak-anak. ASI menyediakan semua energi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi selama beberapa bulan pertama kehidupan, dan terus menyediakan hingga setengah atau lebih dari kebutuhan nutrisi anak selama paruh kedua tahun pertama, dan hingga sepertiga selama tahun kedua kehidupan. Anak-anak yang disusui memiliki kinerja yang lebih baik dalam tes kecerdasan, cenderung tidak kelebihan berat badan atau obesitas, dan kurang rentan terhadap diabetes di kemudian hari. Wanita yang menyusui juga memiliki risiko kanker payudara dan ovarium yang lebih rendah. Pemasaran pengganti ASI yang tidak tepat terus merusak upaya untuk meningkatkan angka dan durasi menyusui di seluruh dunia (WHO, 2022)

WHO dan UNICEF merekomendasikan agar bayi mulai disusui dalam satu jam pertama setelah lahir dan disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, artinya tidak ada makanan atau cairan lain yang diberikan, termasuk air. Bayi harus disusui sesuai permintaan, yaitu sesering yang diinginkan bayi, siang dan malam. Botol, dot, atau empeng tidak boleh digunakan. Sejak usia 6 bulan, anak-anak sebaiknya mulai mengonsumsi makanan pendamping yang aman dan memadai sambil tetap menyusui hingga usia dua tahun atau lebih. WHO secara aktif mempromosikan pemberian ASI sebagai sumber nutrisi terbaik untuk bayi dan anak kecil, dan berupaya meningkatkan angka pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama hingga setidaknya 50% pada tahun 2025.

Pemberian ASI direkomendasikan sampai dua tahun atau lebih. Alasan ASI tetap diberikan setelah bayi berusia 6 bulan, karena 65% kebutuhan energi seorang bayi pada umur 6-8 bulan masih terpenuhi dari ASI. Pada umur 9-12

bulan sekitar 50% kebutuhannya dari ASI dan umur 1-2 tahun hanya sekitar 20% dari ASI. Banyak bukti ilmiah yang memperlihatkan bahwa ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa contoh di antaranya, kolostrum (ASI pada hari 1-5) kaya protein, laktosa ASI sebagai sumber karbohidrat diserap lebih baik dibanding yang terdapat di dalam susu formula.

Produksi ASI tidak selalu sama setiap harinya yaitu: antara 450-1200 ml per hari, sehingga bila dalam 1 hari dirasakan produksinya berkurang, maka belum tentu akan begitu seterusnya. Bahkan pada 1-2 hari kemudian jumlahnya akan melebihi rata-rata sehingga secara kumulatif akan mencukupi kebutuhan bayi.

3. Kandungan ASI

Nutrisi yang terkandung di dalam ASI cukup banyak dan bersifat spesifik pada setiap ibu. Komposisi ASI dapat berubah dan berbeda dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kebutuhan bayi sesuai usianya. Berdasarkan waktunya, ASI dibedakan menjadi 3 (tiga) stadium, yaitu:

a. Kolostrum (ASI hari 1-3)

Kolostrum merupakan susu pertama keluar, berbentuk cairan kekuningan yang diproduksi beberapa hari setelah kelahiran dan berbeda dengan ASI transisi dan ASI matur. Kolostrum mengandung protein tinggi 8,5%, sedikit karbohidrat 3,5%, lemak 2,5%, garam dan mineral 0,4%, air 85,1%, dan vitamin larut lemak. Kandungan protein kolostrum lebih tinggi, sedangkan kandungan laktosanya lebih rendah dibandingkan ASI matang. Selain itu, kolostrum juga tinggi *immunoglobulin A (IgA)* sekretori, laktoferin, leukosit, serta factor perkembangan seper faktor pertumbuhan epidermal. Kolostrum juga dapat berfungsi sebagai pencakar yang dapat membersihkan saluran pencernaan bayi baru lahir. Jumlah kolostrum yang diproduksi ibu hanya sekitar 7,4 sendok teh atau 36,23 mL per hari. Pada hari pertama bayi, kapasitas perut bayi $\approx$ 5-7 mL (atau sebesar kelereng kecil), pada hari kedua $\approx$ 12-13 mL, dan pada hari ke $\approx$ 22-27 mL (atau sebesar kelereng besar/gundu). Karenanya, meskipun jumlah kolostrum sedikit tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi baru lahir.

b. ASI masa transisi (ASI hari 4-10)

ASI ini merupakan transisi dari kolostrum ke ASI matur. Kandungan protein makin menurun, namun ASI eksklusif kandungan lemak, laktosa, vitamin larut air, dan volume ASI akan semakin meningkat. Peningkatan

volume ASI dipengaruhi oleh lamanya menyusui yang kemudian akan digantikan oleh ASI matur.

c. ASI matur

ASI matur merupakan ASI yang disekresi dari hari ke-10 seterusnya dan komposisinya relative konstan. ASI matur, dibedakan menjadi dua, yaitu susu awal atau susu primer, dan susu akhir atau susu sekunder. Susu awal (*fore milk*) adalah ASI yang keluar pada setiap awal menyusui, sedangkan susu akhir adalah ASI yang keluar pada setiap akhir menyusui. Susu awal, menyediakan pemenuhan kebutuhan bayi akan air. Jika bayi memperoleh susu awal dalam jumlah banyak, semua kebutuhan air akan terpenuhi. Susu akhir (*hind milk*) memiliki lebih banyak lemak daripada susu awal, menyebabkan susu akhir kelihatan lebih putih dibandingkan dengan susu awal. Lemak memberikan banyak energi; oleh karena itu bayi harus diberi kesempatan menyusui lebih lama agar bisa memperoleh susu akhir yang kaya lemak dengan maksimal. Komponen nutrisi ASI berasal dari 3 sumber, beberapa nutrisi berasal dari sintesis di leukosit, beberapa berasal dari makanan, dan beberapa dari bawaan ibu.

4. Manfaat ASI

- a. Air susu ibu memberikan nutrisi ideal untuk bayi. ASI lebih mudah dicerna daripada susu formula.
- b. ASI mengandung kolostrum yang kaya antibodi, SigA untuk proteksi lokal pada permukaan saluran cerna.
- c. Membantu ikatan batin ibu dengan bayi. d. Meningkatkan kecerdasan anak. ASI eksklusif selama 6 bulan akan menjamin tercapainya pengembangan potensi kecerdasan anak secara optimal. Hal ini karena ASI mengandung nutrisi khusus yang diperlukan otak.
- d. Bayi yang diberi ASI lebih berpotensi mendapatkan berat badan ideal.
- e. Menyusui dapat mencegah *sudden infant death syndrome (SIDS)*; dapat menurunkan risiko diabetes, obesitas, dan kanker tertentu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014; Maya Cobalt Angio Septianingtyas et al., 2018; Yanti et al., 2022).

5. Manajemen Penyimpanan ASI

a. Cara Menyimpan ASIP

ASI perah sebaiknya di tempatkan di dalam botol kaca atau plastik yang bebas *Bisphenol-A (BPA)* yang berisiko bagi bayi. Botol tersebut dikenal dengan *BPA free*. Botol yang dipergunakan untuk menyimpan ASI perah harus sudah disterilkan atau minimal dicuci dengan air hangat bersih. Botol khusus penyimpan ASI tersedia toko perlengkapan bayi. Botol yang sudah terisi ASIP

diberi label pada botol yang bertuliskan jam dan tanggal ASI diperah. Apabila ASIP ditempatkan bersamaan dengan botol ASIP balita lain, misalnya di tempat penitipan bayi atau bersama teman sekantor, sebaiknya diberikan nama pada labelnya. Untuk membawa ASIP ke tempat tujuan, botol yang berisi ASIP dapat ditempatkan di dalam tas isolasi khusus atau *cooler bag*. Ibu-ibu pekerja dapat memeras ASI di tempat kerja dan membawa botol-botol ASI perah pulang ke rumah dalam tas *cooler*. Apabila ditempatkan dalam lemari pendingin, botol-botol ASIP sebaiknya diletakkan pada bagian paling dingin, yaitu di bagian paling belakang *freezer*. Persediaan ASIP yang paling dulu diperas sebaiknya diberikan terlebih dahulu.

b. Daya Tahan ASIP

Daya tahan ASIP bergantung kepada letak ASI perah tersebut disimpan.

- 1) ASI yang baru saja diperah dapat bertahan dalam suhu ruang hingga empat jam.
- 2) Apabila disimpan dalam wadah tertutup dengan kantong es, ASIP dapat bertahan hingga 24 jam.
- 3) ASIP yang disimpan dalam lemari pendingin dapat bertahan hingga tiga hari.
- 4) Sementara jika disimpan dalam *freezer*, ASIP dapat bertahan hingga enam bulan. ASI mengandung banyak vitamin, salah satu di antaranya vitamin C. ASIP yang disimpan lama, maka makin banyak vitamin C yang hilang dari susu. ASI perah yang
- 5) sudah melewati batas waktu penyimpanan sebaiknya dibuang untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.

c. Cara Menghangatkan

ASIP Persiapan pemberian ASIP dilakukan dengan mengeluarkan botol yang berisi ASIP dari freezer ke lemari es yang bersuhu lebih besar. Selanjutnya botol ASIP yang disimpan dalam lemari pendingin dapat ditempatkan dalam mangkok bersih berisi air hangat sebelum diberikan pada bayi. Perlu dihindari memasukkannya kembali ke dalam lemari es setelah dihangatkan. Selain itu pemanasan ASIP dengan *microwave* atau merebus ASIP juga perlu dihindari karena dapat merusak vitamin dalam ASIP dan akan terasa terlalu panas untuk mulut bayi.

d. Jumlah ASIP yang Harus Disiapkan

Jumlah ASI perah bergantung pada kebutuhan bayi. Semakin bertambah usia bayi ASI yang disiapkan juga meningkat. Pada usia enam bulan ke atas bayi sudah mengonsumsi makanan pendamping ASI (MPASI), maka jumlah ASI yang harus disiapkan akan berangsur menurun. Memberikan ASI perah

pada bayi dapat dilakukan baik dengan botol maupun cangkir khusus bayi (cup feeder). Namun jika sang ibu sudah berada bersama bayi, sebaiknya tetap kondisikan bayi untuk langsung menyusui untuk merangsang kelancaran produksi air susu ibu. ASI perah yang dikelola dengan baik dapat menjadi solusi bagi ibu pekerja yang ingin terus memberikan ASI pada buah hati. ASI yang akan diberikan pada Balita akan lebih baik apabila mengetahui langkah agar ASI berkualitas.

6. Delapan Langkah Agar ASI Berkualitas

- a. Percaya diri.
- b. Menyusui dengan benar.
- c. Menghindari penggunaan dot atau empeng.
- d. Tidak memberikan susu formula.
- e. Menghindari stres.
- f. Ibu mengkonsumsi makanan bergizi.
- g. Pijat punggung.
- h. Menyimpan ASI bagi ibu pekerja (Purwidi Asri, 2018).

D. Simpulan

Masa nifas dan laktasi merupakan periode transisi yang sangat penting bagi ibu dan bayi, dimulai sejak lahirnya plasenta hingga pemulihan organ reproduksi sekitar enam minggu, dengan tantangan fisiologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Pada masa ini, asuhan kebidanan berperan menjaga kesehatan ibu dan bayi melalui deteksi dini komplikasi, dukungan emosional, edukasi nutrisi, serta konseling keluarga berencana. Laktasi sebagai proses produksi dan pengeluaran ASI menjadi fondasi utama tumbuh kembang bayi, dengan kandungan nutrisi dan antibodi yang tidak tergantikan, serta manfaat jangka panjang bagi kesehatan ibu. WHO dan UNICEF menekankan pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan dilanjutkan hingga usia dua tahun atau lebih, karena dapat meningkatkan imunitas, kecerdasan, dan menurunkan risiko penyakit kronis. Dengan demikian, keberhasilan masa nifas dan laktasi tidak hanya menentukan keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga kualitas hidup keluarga dan pencapaian tujuan kesehatan global.

Referensi

- Allen Paige. (2023). What is Postnatal Care?. Tersedia di: <https://privatemidwives.com/blog/2023/10/03/what-is-postnatal-care/>
- Berens Pamela, M.D. (2026). Overview of the postpartum period: Normal physiology and routine maternal care. Tersedia di: <https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-postpartum-period-normal-physiology-and-routine-maternal-care>
- Gaurav Chauhan; Prasanna Tadi. (2022). Physiology, Postpartum Changes. Tersedia di: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555904/>
- Hanifah, AN, Purwanto, TS, Usnawati, N. (2020). Modul Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan Pendampingan Menyusui. Bandung: Media Sains Indonesia
- Kementerian Kesehatan R.I. (2024). Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan R.I.
- Maya Cobalt Angio Septianingtyas, Anggorowati, Artika Nurrahima. (2018). *Modul Paket Sukses Menyusui "Manajemen Laktasi & Positive Self Talk."*
- Purwidi Asri, A. Z. A. B. M. R. A. M. (2018). Manajemen ASI Perah Untuk Kesehatan Balita. *Jurnal Cakrawala Maritim*, 1(1), 29–35.
- Saleha. (2009). Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas. Jakarta: Salemba Medika.
- Sulistyawati. (2009). Buku *Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas*. Yogyakarta: C. V Andi offset
- WHO. (2020). Breastfeeding. Tersedia di: https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
- WHO. (). Postnatal care. Tersedia di: [https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-\(srh\)/areas-of-work/maternal-and-perinatal-health/postnatal-care](https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/areas-of-work/maternal-and-perinatal-health/postnatal-care)
- WHO. (2015). Postnatal Care for Mothers and Newborns Highlights from the World Health Organization 2013 Guidelines. Tersedia di: <https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/nbh/brief-postnatal-care-for-mothers-and-newborns-highlights-from-the-who-2013-guidelines.pdf>

WHO. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. Tersedia di: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>

Wojcieszek AM, Bonet M, Portela A, Althabe F, Bahl R, Chowdhary N, et al. WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience: strengthening the maternal and newborn care continuum. *BMJ Global Health*. 2023;8:e010992. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-010992>

Glosarium

ASI	= Cairan bernutrisi lengkap yang diproduksi secara alami oleh kelenjar payudara wanita. ASI merupakan sumber gizi utama dan terbaik bagi bayi yang baru lahir, mengandung kombinasi seimbang antara protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan antibodi.
<i>SIDS</i>	= <i>Sudden infant death syndrome</i> atau Sindrom Kematian Mendadak pada Bayi adalah kematian mendadak dan tidak terduga pada bayi sehat yang berusia di bawah satu tahun. Kondisi ini paling sering terjadi saat bayi sedang tidur dan penyebab pastinya belum diketahui secara pasti.
<i>SDGs</i>	= <i>Sustainable Development Goals</i> atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Berisi 17 tujuan dan 169 target, SDGs dirancang sebagai cetak biru universal untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan.
WHO	= <i>World Health Organization</i> (Organisasi Kesehatan Dunia). Ini adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertindak sebagai koordinator utama untuk masalah kesehatan masyarakat dan keselamatan global.
ACOG	= <i>American College of Obstetricians and Gynecologists</i> adalah organisasi profesional nirlaba terkemuka di Amerika Serikat untuk dokter spesialis kandungan dan kebidanan (obgyn). Organisasi ini menetapkan standar perawatan pasien, menyediakan panduan klinis berbasis bukti, serta menerbitkan materi edukasi kesehatan wanita.
Nifas	= Nifas adalah masa segera setelah kelahiran sampai 6 minggu
Laktasi	= keseluruhan proses alami pembentukan, produksi, dan pengeluaran Air Susu Ibu (ASI) dari kelenjar payudara. Proses ini dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut hingga bayi lahir, mencakup tahap saat bayi mulai mengisap hingga menelan ASI.
Oksitosin	= Hormon sekaligus neurotransmitter yang diproduksi di hipotalamus dan dilepaskan oleh kelenjar pituitari. Hormon ini sering dijuluki "hormon cinta" karena memicu perasaan bahagia, ikatan emosional (afeksi), dan rasa percaya.
Prolaktin	= Hormon yang diproduksi terutama oleh kelenjar pituitari (hipofisis) di otak. Fungsi utamanya adalah merangsang produksi Air Susu Ibu (ASI) selama masa kehamilan dan menyusui.

Foremilk	= ASI yang pertama kali keluar di awal sesi menyusui atau memompa. Teksturnya lebih encer dan tampak bening karena tinggi air dan laktosa. Fungsi utamanya adalah untuk memuaskan dahaga (menghidrasi) dan memberi bayi energi cepat.
Hindmilk	= Air Susu Ibu (ASI) yang keluar di akhir sesi menyusui dan kaya akan lemak. Berbeda dengan <i>foremilk</i> (ASI awal yang lebih encer dan tinggi gula untuk energi cepat), <i>hindmilk</i> lebih kental dan berfungsi memberikan kalori tinggi, membuat bayi kenyang lebih lama, serta mendukung tumbuh kembang bayi.
BPA	= Bisphenol A adalah bahan kimia sintetis yang umum digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat (plastik keras dan bening) serta resin epoksi. Senyawa ini sering ditemukan pada botol minuman, wadah makanan, dan lapisan dalam kaleng kemasan.
Cooler bag	= tas yang dirancang khusus dengan lapisan insulasi termal untuk mempertahankan suhu makanan, minuman, atau Air Susu Ibu (ASI) perah agar tetap dingin atau hangat dalam jangka waktu tertentu.
ASIP	= Air Susu Ibu Perah, ASI yang dikeluarkan dari payudara, baik secara manual maupun menggunakan pompa, lalu disimpan untuk diberikan kepada bayi.
sIgA	= Sekretori Immunoglobulin A adalah antibodi utama yang melimpah di dalam Air Susu Ibu (ASI). Komponen ini sering disebut sebagai "vaksin pertama" bagi bayi.
Kolostrum	= Merupakan susu pertama keluar, berbentuk cairan kekuningan yang diproduksi beberapa hari setelah kelahiran
MPASI	= Makanan Pendamping ASI adalah makanan atau minuman pendamping yang diberikan untuk melengkapi asupan nutrisi ASI yang sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi bayi yang terus bertambah. MPASI bukan pengganti ASI.



CHAPTER 2



PERUBAHAN FISILOGI DAN PSIKOLOGIS PADA IBU NIFAS

Febrina Dwi Nurcahyanti, S.ST., MPH.

A. Pendahuluan

Periode 42 hari setelah melahirkan, yang biasa disebut sebagai masa nifas, adalah merupakan masa transisi kritis di mana organ reproduksi kembali ke kondisi semula. Di balik proses normal ini, terdapat risiko medis besar yang menyumbang angka kematian ibu secara global, terutama akibat infeksi dan perdarahan pascasalinan. Namun, pemulihan tidak hanya terbatas pada aspek fisik saja, namun juga melibatkan stabilitas mental atau psikososial. Ibu nifas sering kali mengalami tekanan emosional akibat perubahan hormon dan tanggung jawab yang baru sebagai orang tua.

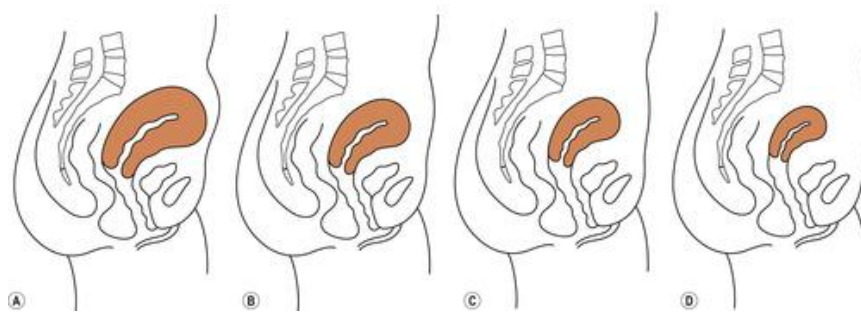
Kurangnya pemahaman mengenai perubahan normal selama masa nifas kerap memicu kecemasan yang menghambat pemulihan dan proses bonding dengan bayi. Dalam hal ini, peran bidan sangat strategis untuk memberikan asuhan yang menyeluruh. Tenaga kesehatan tidak hanya bertugas memantau pemulihan fisik, tetapi juga harus peka terhadap kondisi psikologis ibu guna mencegah komplikasi lebih lanjut dan memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi ibu dan buah hatinya.

B. Materi

1. Perubahan Fisiologis Pada Ibu Nifas

Perubahan fisik secara umum pada ibu nifas setelah persalinan wajib diperhatikan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan atau penolong persalinan agar apabila terjadi kondisi yang abnormal/patologis bisa segera terdeteksi sehingga tidak terjadi kegawatdaruratan pada ibu nifas.

Perubahan fisik pada ibu nifas terbagi menjadi 2 fase, yaitu 1. *Fase Puerperium dini* dan 2. *Fase Puerperium Intermedial*.



Gambar 2. 1 Perubahan uterus pada masa postpartum

Ada beberapa perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu nifas antara lain, yaitu:

a. Perubahan sistem reproduksi

1) Involusi uterus

Involusi uterus adalah proses dimana uterus kembali ke kondisi semula sebelum hamil dengan berat kurang lebih 60 gram.

Involusi uterus melibatkan reorganisasi dan penanggalan decidua atau endometrium dan pengelupasan lapisan tempat implantasi plasenta sebagai tanda penurunan ukuran dan berat serta perubahan tempat uterus, warna dan jumlah lochia.

Setelah bayi dilahirkan uterus akan mengalami kontraksi dan retraksi dan menjadi keras sehingga mengakibatkan pembuluh darah besar yang bermuara pada bekas implantasi plasenta.

Ukuran uterus yang normal selama postpartum adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Involusi Uterus Normal Selama Masa Postpartum

Involusi Uterus	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus	Diameter Uterus
Plasenta Lahir	Setinggi Pusat	1000 gram	12,5 cm
7 hari (minggu 1)	Pertengahan pusat dan simpisis	500 gram	7,5 cm
14 hari (minggu 2)	Tidak teraba	350 gram	5 cm
6 minggu	Normal	60 gram	2,5 cm

Perubahan involusi uterus dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. 2 Perubahan TFU (Involusi Uterus)

Involusi uterus terjadi melalui beberapa proses, antara lain yaitu :

a) Iskemia Miometrium

Disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang terus menerus dari uterus setelah pengeluaran plasenta membuat uterus relative anemi dan menyebabkan serat otot atrofi.

b) Atrofi Jaringan

Merupakan penyusutan, pengecilan atau hilangnya massa sel, jaringan atau organ tubuh yang disebabkan karena berkurangnya ukuran sel sel penyusun jaringan atau hilangnya substansi seluler.

c) Autolysis

Autolysis merupakan proses penghancuran sel karena enzim, nya sendiri yang terjadi di dalam otot urine.

Penurunan hormon esterogen dan progesteron mengakibatkan rusaknya jaringan yang mengalami hipertropi yang berlebihan yang disebabkan karena kehamilan.

d) Efek Oksitosin

Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot uterin sehingga menekan pembuluh darah yang mengakibatkan berkurangnya suplay darah ke uterus.

Proses ini membantu mengurangi perdarahan pada tempat implantasi plasenta.

2) Involusi tempat plasenta

Setelah proses persalinan berlangsung, tempat permukaan implantasi plasenta menjadi kasar, tidak rata dan besarnya sebesar telapak tangan dan proses pengecilan luka berlangsung cepat, pada akhir minggu ke 2 sekitar 3 – 4 cm kemudian pada akhir masa nifas 1 – 2 cm.

Luka pada bekas tumbuhnya plasenta tidak menjadi luka parut karena luka ini sembuh dengan cara melepaskan dari dasar dan diikuti dengan tumbuhnya endometrium baru dibawah permukaan luka, dimana endometrium yang baru tumbuh dari pinggir luka dan juga dari sisa-sisa kelenjar pada dasar luka.

Regenerasi endometrium berlangsung sekitar 6 minggu. epitel berproliferasi meluas ke dalam dari sisi tempat ini dan dari lapisan sekitar uterus serta di bawah tempat implantasi plasenta dari sisa-sisa kelenjar basilar endometrial di dalam deciduas basalis. pertumbuhan kelenjar tersebut mengikis pembuluh darah yang beku pada tempat implantasi plasenta dan terkelupas serta ikut terbawa bersama keluarnya lochia.

3) Perubahan ligamen

Struktur pendukung panggul—seperti ligamen, diafragma pelvis, dan jaringan ikat (fasia)—secara alami akan menyusut kembali ke ukuran semula setelah proses persalinan selesai. Namun, jika ligamentum rotundum kehilangan elastisitasnya, rahim dapat bergeser ke posisi retrofleksi atau menghadap ke belakang. Efek peregangan ini juga sering menyebabkan keluhan "turun peranakan" karena melemahnya daya sokong jaringan terhadap organ reproduksi..

4) Perubahan pada serviks

Selama masa nifas, serviks mengalami involusi yang mengubah bentuknya menjadi menyerupai corong dengan batas serupa cincin. Kondisi ini dipicu oleh intensitas kontraksi yang berbeda dengan badan rahim. Secara visual, serviks tampak sangat gelap akibat kepadatan pembuluh darah, bertekstur lunak, serta sering kali menunjukkan jejak trauma persalinan berupa lecet.

Lacerasi yang terjadi selama tahap pembukaan (dilatasi) menyebabkan perubahan anatomi yang menetap, sehingga serviks tidak akan kembali ke bentuk semula sebelum hamil. Pemulihannya berlangsung perlahan: dari kondisi terbuka selebar dua jari pada dua jam pertama, menyempit menjadi seukuran satu jari di akhir minggu pertama, hingga akhirnya menutup sempurna pada minggu keenam.

5) Lokia

Setelah rahim mulai mengecil (involusi), lapisan pelindung di tempat menempelnya plasenta akan mati dan terlepas. Sisa-sisa jaringan ini keluar bersama darah dalam bentuk cairan yang disebut lokia. Cairan ini biasanya berwarna pucat atau merah muda dan memiliki bau amis yang tidak terlalu menyengat. Perlu diperhatikan bahwa lokia bersifat basa, sehingga bakteri lebih mudah berkembang biak di dalamnya dibandingkan dalam kondisi vagina yang biasanya asam. Secara mikroskopis, lokia mengandung sel darah merah, sisa jaringan rahim, dan sel kulit. Perubahan warna dan jumlah lokia ini merupakan bagian alami dari pemulihan rahim setelah melahirkan. Klasifikasi Pengeluaran Lokia Pasca Persalinan :

a) Lokia Rubra (Kruenta) :

Cairan ini keluar pada hari ke-1 hingga ke-3 setelah melahirkan. Didominasi oleh warna merah segar karena mengandung darah dalam jumlah besar yang berasal dari luka bekas menempelnya plasenta, sisa jaringan desidua, serta serabut jaringan penyangga.

b) Lokia Sanguinolenta :

Terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-7 masa nifas. Cairan ini memiliki tekstur berlendir dengan warna merah kecokelatan yang dipengaruhi oleh adanya komponen plasma darah.

c) Lokia Serosa :

Muncul pada rentang waktu hari ke-7 hingga hari ke-14 pascasalin. Warnanya cenderung berubah menjadi kekuningan atau coklat muda. Secara komposisi, kandungan darahnya mulai berkurang dan didominasi oleh serum, leukosit (sel darah putih), serta sisa-sisa kecil jaringan plasenta.

d) Lokia Alba :

Merupakan tahap akhir yang terjadi pada minggu ke-2 hingga minggu ke-6 pascapersalinan. Warnanya tampak jauh lebih pucat atau putih kekuningan. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi leukosit, sel epitel, sisa sel desidua, serta peluruhan jaringan mati lainnya.

Pengamatan terhadap lokia sangat penting karena pengeluaran yang tidak normal dapat menandakan masalah kesehatan seperti infeksi atau perdarahan postpartum sekunder. Sebagai contoh, lokia yang tidak kunjung berubah warna dari merah setelah dua minggu pascasalin sering kali dikaitkan dengan kegagalan rahim kembali ke ukuran semula (subinvolusi) atau adanya jaringan plasenta yang tertinggal.

Secara alami, urutan pengeluaran dimulai dari lokia rubra, kemudian serosa, dan diakhiri oleh lokia alba dengan total cairan mencapai kurang lebih 8–9 ons. Ibu mungkin merasa lokia lebih banyak keluar saat baru bangun dari posisi berbaring; hal ini wajar karena cairan yang sebelumnya mengumpul di vagina akan terdorong keluar saat posisi berdiri. Lokia juga memiliki aroma khas yang berbeda dengan bau darah menstruasi maupun bau menyengat akibat infeksi.

6) Perubahan pada Vulva, Vagina dan Perineum

Proses melahirkan memberikan beban peregangan yang besar pada vulva dan vagina, yang mengakibatkan elastisitas jaringan tersebut berkurang sementara waktu. Rendahnya hormon estrogen setelah bayi lahir membuat dinding vagina menipis dan lipatnya (rugae) menghilang. Meskipun awalnya sangat meregang, ukuran vagina akan menyusut kembali ke kondisi mendekati semula dalam waktu 6–8 minggu. Lipatan vagina biasanya akan muncul kembali pada minggu keempat, meski sering kali tidak sejelas saat sebelum melahirkan pertama kali. Bagi ibu yang menyusui, lapisan vagina mungkin tetap tipis hingga masa menyusui selesai dan fungsi hormon ovarium kembali bekerja untuk menebalkan kembali mukosa tersebut.

Perineum menjadi kendur setelah melahirkan karena tekanan besar dari tubuh bayi. Secara bertahap, kekuatan otot perineum akan mulai membaik pada hari kelima pascalin. Di area pintu vagina (introitus), biasanya akan terlihat pembengkakan dan kemerahan, terutama jika terdapat luka jahitan akibat episiotomi atau robekan alami. Luka ini umumnya membutuhkan waktu 2–3 minggu untuk sembuh total. Jika luka tidak dirawat dengan baik, dapat muncul tanda-tanda infeksi seperti rasa panas, nyeri, dan bengkak. Infeksi yang tidak tertangani pada luka jahitan sangat berbahaya karena bisa menyebar menjadi selulitis atau bahkan masuk ke aliran darah (sepsis).

b. Perubahan sistem pencernaan

Konstipasi pada masa persalinan dipicu oleh faktor mekanis berupa tekanan pada saluran cerna, dehidrasi, serta kurangnya aktivitas tubuh. Intervensi yang efektif untuk kondisi ini meliputi diet tinggi serat, hidrasi yang adekuat, dan ambulasi dini. Di sisi lain, perubahan sekresi kelenjar pencernaan dan penurunan kebutuhan metabolisme energi sering kali menyebabkan anoreksia pada ibu bersalin.

c. Perubahan sistem perkemihan

Pada waktu pascapersalinan, ibu sering kali mengalami kesulitan miksi dalam 24 jam pertama akibat *spasme sfingter* dan *edema* pada leher kandung kemih yang terkompresi oleh kepala janin selama proses persalinan.

Fenomena *diuresis* kemudian terjadi antara 12 hingga 36 jam pascapersalinan, dipicu oleh penurunan drastis kadar hormon estrogen yang sebelumnya bersifat retensi air. Meskipun ureter akan kembali normal dalam waktu enam minggu, kondisi kandung kemih yang edema dan hiperemia (terutama pada area trigonum) dapat menyebabkan obstruksi uretra hingga retensi urine.

Selain itu, penurunan sensitivitas dan peningkatan kapasitas kandung kemih selama masa nifas sering kali menyisakan urine residual, yang jika dikombinasikan dengan trauma persalinan, berisiko tinggi memicu infeksi saluran kemih.

d. Perubahan sistem Muskuloskeletal atau Diastasis Rectus Abdominkus

Segara setelah persalinan, kontraksi otot uterus berfungsi menjepit pembuluh darah di antara anyaman miometrium guna menghentikan perdarahan pasca-lepasnya plasenta. Sementara itu, struktur penyokong seperti ligamen, diafragma pelvis, dan fasia yang meregang akan mengalami involusi secara bertahap. Namun, kekenduran pada ligamentum rotundum dan jaringan penunjang genitalia lainnya sering kali menyebabkan posisi uterus menjadi retrofleksi atau memicu keluhan prolapsus uteri ("kandungan turun").

Stabilisasi anatomi ini umumnya baru tercapai sempurna dalam 6 hingga 8 minggu. Selain itu, dinding abdomen cenderung tetap lunak akibat distensi selama kehamilan dan putusnya serat elastik kulit. Oleh karena itu, fisioterapi atau latihan fisik tertentu sangat dianjurkan sejak dua hari pascapersalinan untuk memulihkan tonus otot perut dan dasar panggul.

e. Perubahan Sistem Endokrin

1) Penurunan Hormon Plasenta

Pascapersalinan, kadar hormon-hormon plasenta seperti hPL, hCG, estrogen, serta progesteron mengalami penurunan signifikan dalam hitungan hari. Secara khusus, berkurangnya kadar progesteron secara cepat berperan sebagai pemicu dimulainya laktogenesis (produksi ASI) sekaligus mengeliminasi resistensi insulin yang terjadi selama kehamilan, sehingga kadar glukosa darah kembali menurun.

2) Hormon Pituitary

Pada saat masa nifas kadar prolaktin mengalami lonjakan signifikan, namun pada ibu yang tidak menyusui, hormon ini akan kembali menurun

dalam kurun waktu dua minggu. Sementara itu, hormon pengatur siklus reproduksi seperti *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH) mulai meningkat pada fase folikuler di minggu ketiga, meskipun kadar LH akan tetap rendah hingga mendekati masa ovulasi.

3) Hypotalamik pituitary ovarium

Interval kembalinya siklus menstruasi pascapersalinan sangat dipengaruhi oleh aktivitas laktasi atau menyusui. Umumnya, siklus menstruasi perdana setelah melahirkan tidak disertai dengan pelepasan sel telur (anovulasi), yang disebabkan oleh masih rendahnya konsentrasi hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh.

4) Kadar Esterogen

Pascapersalinan, konsentrasi estrogen di dalam tubuh mengalami penurunan yang sangat tajam. Di saat yang bersamaan, peningkatan aktivitas hormon prolaktin berperan secara spesifik dalam menstimulasi kelenjar mamaria untuk memproduksi ASI.

f. Perubahan Tanda Vital

Pascapersalinan, parameter tanda-tanda vital akan mengalami penyesuaian dari kondisi gestasi ke kondisi fisiologis normal. Hal ini ditandai dengan kenaikan tekanan darah sistolik dan diastolik yang bersifat moderat serta sementara selama kurang lebih empat hari. Pemulihan fungsi respirasi hingga mencapai level sebelum kehamilan umumnya memerlukan waktu sekitar enam bulan. Selain itu, pengosongan uterus mengakibatkan kembalinya posisi diafragma ke letak semula, yang diikuti dengan normalisasi aksis jantung, impuls, serta gambaran EKG.

1) Suhu

Pada 24 jam pertama pascapersalinan, suhu tubuh cenderung mengalami peningkatan ringan (sekitar 37,5–38°C) sebagai respons fisiologis terhadap dehidrasi dan kelelahan fisik selama proses persalinan. Meskipun suhu umumnya akan kembali stabil, kenaikan suhu sekunder sering terjadi pada hari ketiga yang berkaitan dengan proses laktogenesis serta pembengkakan payudara (*engorgement*). Perlu diwaspadai apabila hipertermia menetap, karena hal tersebut dapat mengindikasikan adanya komplikasi infeksi seperti endometritis, mastitis, ataupun infeksi pada traktus genitalis.

2) Nadi

Frekuensi nadi normal pada orang dewasa berada dalam rentang 60–80 detak per menit. Namun, pada periode pascapersalinan, frekuensi

tersebut cenderung mengalami peningkatan atau menjadi lebih cepat dari batas normal tersebut.

3) Tekanan Darah

Pada umumnya, tekanan darah pascapersalinan cenderung stabil. Namun, hipotensi atau tekanan darah rendah dapat terjadi sebagai konsekuensi dari kehilangan darah (perdarahan). Sebaliknya, kenaikan tekanan darah yang signifikan setelah melahirkan harus diwaspadai sebagai indikasi klinis dari preeklamsia postpartum.

4) Pernafasan

Parameter pernapasan memiliki korelasi linear dengan fluktuasi suhu tubuh dan denyut nadi. Ketidaknormalan pada suhu serta nadi umumnya akan diikuti oleh perubahan pola napas, selama tidak terdapat patologi primer atau gangguan spesifik pada sistem pernapasan.

g. Perubahan Sistem Kardiovaskular

1) Volume Darah

Fluktuasi volume darah pascapersalinan dipengaruhi oleh perdarahan selama persalinan, tingkat mobilisasi, serta pengeluaran cairan ekstrasvaskular. Penurunan volume darah total berlangsung cepat namun terbatas, diikuti oleh redistribusi cairan tubuh yang mengembalikan volume darah ke kondisi sebelum hamil dalam waktu 3 hingga 4 minggu. Secara klinis, rata-rata kehilangan darah pada persalinan pervaginam berkisar antara 300–400 cc, sedangkan pada tindakan *Seksio Sesarea* (SC) volumenya bisa mencapai dua kali lipat. Fenomena ini juga memengaruhi nilai hematokrit; pada persalinan normal terjadi hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit), sedangkan pada SC cenderung lebih stabil dan baru kembali normal dalam rentang 4 hingga 6 minggu.

Terdapat tiga poin perubahan fisiologis pada wanita pascapersalinan :

- a) Penyusutan Sirkulasi Uteroplasenta: Terhentinya aliran darah ke plasenta menyebabkan volume pembuluh darah ibu berkurang secara nyata, yakni sekitar 10% hingga 15%.
- b) Penghentian Fungsi Hormonal Plasenta: Hilangnya peran plasenta sebagai kelenjar endokrin menghapus rangsangan yang sebelumnya berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah (vasodilatasi).
- c) Redistribusi Cairan Tubuh: Terjadi proses penarikan atau mobilisasi kembali cairan yang menumpuk di luar pembuluh darah (cairan ekstrasvaskular) yang tersimpan selama masa kehamilan.

2) Curah Jantung

Selama masa kehamilan, terjadi peningkatan bertahap pada denyut jantung, volume sekuncup, dan curah jantung. Namun, dalam waktu 30–60 menit pascapersalinan, parameter tersebut mengalami lonjakan yang lebih drastis. Hal ini dipicu oleh kembalinya volume darah dari sirkulasi uteroplasenta ke sirkulasi sistemik secara mendadak. Fenomena hemodinamik ini terjadi pada seluruh metode persalinan, baik pervaginam maupun operasi.

h. Perubahan Sistem Hematologi

Sepanjang masa kehamilan, tubuh mengalami peningkatan kadar plasma, fibrinogen, serta faktor koagulasi. Memasuki hari pertama postpartum, meski kadar plasma dan fibrinogen sedikit menyusut, viskositas darah justru meningkat yang memperkuat mekanisme pembekuan. Dari sisi imunologi, terjadi leukositosis fisiologis di mana jumlah sel darah putih dapat mencapai 15.000 sel, bahkan menyentuh 25.000–30.000 sel pada persalinan lama tanpa adanya indikasi patologis.

Sementara itu, parameter hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht), dan eritrosit menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh redistribusi volume darah serta status gizi ibu. Setelah kehilangan darah sekitar 200–500 ml selama proses persalinan, kadar Hb dan Ht biasanya akan meningkat pada hari ke-3 hingga ke-7 sebelum akhirnya kembali ke level normal dalam waktu 4–5 minggu.

- **Perubahan Komponen Darah**

Selama periode pascapersalinan, terjadi penyesuaian signifikan pada profil hematologi, termasuk lonjakan leukosit. Meskipun kadar hemoglobin dan eritrosit cenderung tidak stabil di awal, keduanya umumnya pulih dalam sepekan. Selain itu, peningkatan curah jantung yang terjadi pasca-melahirkan biasanya akan kembali ke kondisi fisiologis normal dalam kurun waktu dua minggu.

2. Perubahan Psikologis pada Ibu Nifas

a. Proses Adaptasi Psikologi Mas Nifas

Transisi menjadi seorang ibu tidak selamanya menjadi momen yang membahagiakan bagi setiap wanita. Tanggung jawab baru ini berisiko memicu gangguan pada aspek emosional, intelektual, maupun perilaku. Meski banyak wanita mampu beradaptasi dengan peran tersebut, sebagian lainnya justru mengalami kendala psikologis yang dikenal sebagai postpartum blues. Munculnya kondisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor dukungan sosial, khususnya dari sosok suami. Ketiadaan pendampingan emosional selama masa

nifas, ditambah dengan perasaan terisolasi setelah melewati masa kehamilan, sering kali menjadi pemicu utama gangguan psikologis pada ibu baru.

Menjadi orang tua bukanlah hal yang selalu membahagiakan, karena beban tanggung jawab baru dapat memicu gangguan emosional dan kognitif pada ibu. Transisi peran ini tidak selalu berjalan mulus; bagi sebagian wanita, kegagalan adaptasi dapat berujung pada *postpartum blues*. Salah satu pemicu utamanya adalah minimnya dukungan sosial, khususnya dari sosok suami. Perasaan terisolasi setelah masa kehamilan sembilan bulan sering kali memperburuk kondisi psikologis ibu selama masa nifas.

Berikut ini merupakan fase-fase yang terjadi pada ibu nifas antara lain sebagai berikut :

1) *Fase Taking In*

Fase awal pascapersalinan (hari ke-1 hingga ke-2) ditandai dengan sikap ibu yang cenderung pasif, dependen, dan sangat fokus pada pemulihan fisiknya. Pada tahap ini, ibu membutuhkan ruang untuk menceritakan pengalaman persalinannya. Dukungan emosional dari suami dan keluarga, terutama dalam bentuk empati dan waktu untuk mendengarkan, sangatlah krusial. Selain itu, pemenuhan nutrisi dan istirahat yang cukup menjadi kunci untuk meminimalisir risiko gangguan psikologis, seperti rasa kecewa, bersalah, atau tekanan akibat kritik dari lingkungan sekitar.

2) *Fase Taking Hold*

Pada rentang waktu 3 hingga 10 hari pascapersalinan, ibu biasanya memasuki fase yang penuh kecemasan terkait tanggung jawab dan kompetensinya dalam mengasuh bayi. Kondisi emosional yang cenderung sensitif membuat ibu memerlukan pendampingan serta dukungan intensif guna membangun kembali rasa percaya dirinya.

3) *Fase Letting go*

Memasuki hari kesepuluh setelah melahirkan, ibu mulai menunjukkan peningkatan kapabilitas dalam mengelola peran barunya. Pada tahapan ini, dukungan eksternal dari lingkungan terdekat tetap menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas fisik ibu. Penting untuk diperhatikan bahwa proses adaptasi terhadap tanggung jawab baru ini berdampak langsung pada kondisi psikososial ibu. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap dinamika tersebut dapat berdampak fatal bagi kesehatan mental, termasuk risiko terjadinya depresi postpartum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada saat postpartum, antara lain:

1) Dukungan dari Keluarga dan Teman

Peran lingkungan sosial, khususnya keluarga, merupakan faktor krusial bagi ibu nifas, terutama bagi primipara.

Transisi menjadi orang tua menuntut penyesuaian fisik dan mental yang besar dalam waktu singkat. Adanya dukungan yang suportif tidak hanya mempercepat masa adaptasi ibu, tetapi juga membantu bidan dalam mengoptimalkan pemberian asuhan kebidanan.

2) Pengalaman Melahirkan Terhadap Harapan dan Aspirasi

Proses persalinan memiliki kaitan erat dengan bagaimana seorang wanita memandang identitas barunya sebagai orang tua. Meskipun pengalaman melahirkan sering kali melelahkan dan menantang, hal tersebut justru memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai esensi menjadi ibu. Pascapersalinan, muncul kecenderungan kuat pada banyak wanita untuk merekonsiliasi hubungan dengan ibu kandung mereka, yang secara simultan meningkatkan kematangan diri serta dedikasi terhadap peran pengasuhan.

3) Pengalaman Membesarkan Anak Sebelumnya

Meskipun telah memiliki pengalaman persalinan sebelumnya, seorang ibu tetap memerlukan dukungan eksternal yang positif. Fokus dukungan pada tahap ini bergeser pada pemberian apresiasi serta penguatan emosional atas perjuangan yang telah dilalui pada proses kelahiran terdahulu.

4) Pengaruh Budaya

Keberhasilan ibu dalam melewati masa transisi sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya setempat. Sering kali muncul konflik akibat perbedaan antara prosedur medis dan tradisi lokal, sehingga bidan dituntut untuk bersikap diplomatis dalam memberikan perawatan tanpa mengabaikan standar kesehatan. Selain itu, pelibatan keluarga dalam pengambilan keputusan perawatan dapat menjadi strategi efektif untuk memperlancar tugas bidan di lapangan.

b. *Postpartum Blues*

Melahirkan merupakan peristiwa krusial yang umumnya diidentikkan dengan sukacita bagi seorang perempuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kebahagiaan tersebut tidak dialami secara universal; faktanya, sekitar 80% ibu baru mengalami gangguan afektif pascapersalinan. Kondisi ini sering kali manifestasi dalam bentuk rasa kecewa, keterasingan, ketakutan, hingga

hambatan dalam proses ikatan emosional dengan bayi, yang pada akhirnya memicu beban psikologis berupa rasa bersalah.

Postpartum Blues seringkali disebut dengan maternity blues ataupun sindrom ibu baru, merupakan suatu bentuk ketidaknyamanan perasaan yang bersifat ringan, yang biasanya terjadi pada fase awal masa nifas.

Tanda gejala postpartum blues diantaranya adalah :

- 1) Reaksi depresi/sedih/disforia
- 2) Sering menangis
- 3) Mudah tersinggung
- 4) Cemas
- 5) Perubahan emosi yang cepat
- 6) Tendensi untuk menyalahkan diri sendiri
- 7) Gangguan tidur dan nafsu makan
- 8) Kelelahan
- 9) Mudah merasa sedih
- 10) Mudah marah
- 11) Perubahan suasana hati yang cepat, dari sedih menjadi bahagia dan sebaliknya
- 12) Perasaan terjebak dan kemarahan terhadap pasangan dan bayi
- 13) Perasaan bersalah
- 14) Kelupaan

Gejala postpartum blues umumnya mencapai puncaknya pada hari ketiga hingga kelima setelah persalinan dan biasanya mereda dalam waktu dua minggu. Perlu dipahami bahwa kondisi ini merupakan fenomena umum dan bukan merupakan suatu penyakit. Meskipun mengalami gangguan ini, seorang ibu tetap mampu memberikan perawatan optimal bagi bayinya. Walaupun tidak berkaitan langsung dengan riwayat gangguan mental atau stres, faktor depresi sebelumnya dapat meningkatkan risiko berkembangnya kondisi ini menjadi depresi pascamelahirkan yang lebih berat. Oleh sebab itu, penanganan yang cepat dan tepat tetap diperlukan.

Penyebab terjadinya *postpartum blues* dapat bervariasi, termasuk:

- 1) Perubahan hormonal yang drastis, seperti penurunan kadar estrogen, progesteron, prolaktin, dan estriol setelah melahirkan, yang dapat memengaruhi suasana hati dan meningkatkan risiko depresi.
- 2) Ketidaknyamanan fisik pascamelahirkan, seperti rasa sakit dari luka jahitan atau bengkak pada payudara.
- 3) Kesulitan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi setelah melahirkan.

- 4) Faktor usia dan jumlah anak yang dimiliki oleh ibu.
- 5) Pengalaman dan proses kehamilan serta persalinan sebelumnya.
- 6) Latar belakang sosial dan psikologis ibu, seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, atau riwayat gangguan mental.
- 7) Dukungan sosial yang diterima dari keluarga, suami, dan orang-orang terdekat.
- 8) Stres yang dialami oleh ibu, misalnya karena kesulitan menyusui bayi atau rasa bosan terhadap rutinitas baru.
- 9) Kelelahan fisik dan mental pasca persalinan.

Beberapa cara untuk mengatasi *postpartum blues* meliputi :

- 1) Mempersiapkan diri secara mental dan emosional selama kehamilan untuk menghadapi masa nifas.
- 2) Berkomunikasi dengan orang-orang terdekat untuk menyampaikan perasaan dan permasalahan yang dialami.
- 3) Mengatasi rasa cemas dengan membicarakannya secara terbuka.
- 4) Bersikap tulus dan ikhlas dalam menghadapi peran baru sebagai seorang ibu.
- 5) Mendapatkan istirahat yang cukup.
- 6) Menghindari perubahan hidup yang terlalu drastis.
- 7) Melakukan olahraga ringan untuk meredakan stres.
- 8) Mencari dukungan dari keluarga, suami, atau saudara.
- 9) Konsultasikan perasaan dan kondisi Anda kepada tenaga kesehatan atau profesional untuk mendapatkan bantuan dan dukungan tambahan.

c. Edinburg Postnatal Depression Scale (Epds)

Pelayanan kesehatan di berbagai negara kini rutin melakukan skrining kesehatan mental bagi ibu baru. Salah satu alat bantu standarnya adalah kuesioner EPDS (*Edinburgh Postnatal Depression Scale*). Alat ini secara khusus mengukur perasaan cemas, sedih, dan rasa bersalah yang sering muncul pada masa postpartum blues dalam kurun waktu 7 hari setelah bayi lahir.

EPDS terdiri dari 10 pertanyaan mandiri dengan empat pilihan jawaban berskala yang mencakup aspek emosional seperti kecemasan, labilitas perasaan, dan rasa bersalah. Alat ini, yang telah diuji validitasnya di berbagai negara termasuk Indonesia, dapat diselesaikan dalam waktu singkat (sekitar 5 menit). Penggunaan EPDS biasanya dilakukan pada minggu pertama pascasalin, dengan kemungkinan tes ulang dua minggu kemudian untuk menjamin keakuratan diagnosis, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi yang tepat bagi ibu.

d. Kesedihan Dan Duka Cita/Depresi

Sebagian ibu baru berisiko mengalami depresi postpartum, sedangkan sebagian lainnya dapat menjalani masa adaptasi dengan emosi yang lebih stabil. Kondisi depresi ini umumnya berlangsung selama 3-6 bulan, namun pada kasus tertentu dapat berlanjut hingga bayi berusia satu tahun. Pemicunya beragam, mulai dari rasa sakit saat melahirkan, kelelahan, kurang tidur, perubahan peran, hingga tekanan dari lingkungan. Respons psikologis tersebut dapat dipahami sebagai proses berduka atas perubahan besar dalam hidup. Tingkat kehilangan yang dirasakan ibu sangat dipengaruhi oleh cara ibu memaknai situasi dan besarnya keterikatan emosional yang dialami.

Kehilangan dalam konteks menjadi seorang ibu tidak hanya soal fisik, tetapi juga emosional. Hal ini meliputi perjuangan wanita dengan infertilitas, duka akibat bayi lahir prematur atau dengan kelainan, hingga munculnya perasaan terasing dari bayi dan kurangnya perhatian yang memicu *postpartum blues*. Selain itu, ada perubahan mendasar dalam hubungan suami-istri saat mereka bertransformasi menjadi sebuah keluarga dengan kehadiran anak. Terkait penanganan medis, ibu dengan kondisi depresi berat sebaiknya dipisahkan sementara dari prosedur rawat gabung dengan bayinya untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

Beberapa gejala depresi berat yang perlu diperhatikan meliputi:

- 1) Perubahan drastis pada suasana hati.
- 2) Gangguan pola tidur dan makan yang signifikan.
- 3) Perubahan kognitif dan penurunan libido.
- 4) Munculnya fobia dan rasa takut akan melukai diri sendiri atau bayi.

Depresi berat cenderung muncul pada wanita atau keluarga dengan riwayat gangguan psikiatrik sebelumnya. Kemungkinan juga dapat terjadi pada kehamilan berikutnya.

Penanganan depresi berat meliputi :

- 1) Dukungan yang kuat dari keluarga dan lingkungan sekitar.
- 2) Terapi psikologis yang dipandu oleh psikiater.
- 3) Kolaborasi dengan dokter untuk penggunaan antidepresan (perlu diperhatikan dosis dan jenisnya, terutama pada wanita hamil dan menyusui).
- 4) Penting untuk tidak meninggalkan penderita sendirian di rumah.
- 5) Jika diperlukan, pertimbangkan perawatan di rumah sakit untuk pemantauan dan intervensi yang lebih intensif.

Proses berduka mengalami tiga tahapan sebagai berikut :

- 1) Tahap Syok
 - a) Manifestasi perilaku meliputi penyangkalan, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan.
 - b) Manifestasi fisik termasuk gelombang distress somatik, penurunan berat badan, dan gangguan tidur.
- 2) Tahap Penderitaan (Fase Realitas)
 - a) Penerimaan terhadap kenyataan kehilangan dan penyesuaian dengan lingkungan yang berubah.
 - a) Nyeri kehilangan dirasakan secara menyeluruh, dengan perasaan marah, bersalah, dan takut sering muncul.
 - b) Menangis menjadi pelepasan emosi yang umum, sementara kehidupan terus berlanjut dengan adanya kecemasan terhadap masa depan.
- 3) Tahap Resolusi (Fase Menentukan Hubungan yang Bermakna)
 - a) Individu menerima kehilangan dan kembali pada fungsinya secara penuh.
 - b) Penanaman kembali emosi pada hubungan yang bermakna membantu dalam proses resolusi.
 - c) Perilaku individu kembali menjadi pilihan yang bebas, dengan nilai-nilai sosial atau kegelisahan internal tidak lagi mendominasi.

Peran bidan dalam mendampingi proses berduka adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendengarkan.
- 2) Memfasilitasi ventilasi perasaan negatif dan permusuhan yang mungkin muncul.
- 3) Memberikan penjelasan yang jujur kepada keluarga tentang kehilangan yang dialami.
- 4) Memastikan bahwa orang-orang terdekat dirumah merasa didukung dan dipahami.
- 5) Berbagi informasi dengan keluarga untuk memantau kesejahteraan mereka dan memberikan dukungan jika diperlukan.
- 6) Menjadi sumber informasi yang jujur dan realistis pada peristiwa kematian, membantu ibu dalam memahami situasi dengan baik.

C. Simpulan

1. Perubahan Fisiologis (Fisik)

Masa nifas berlangsung selama kurang lebih 6 minggu (42 hari), di mana tubuh ibu mengalami pemulihan pascapersalinan.

Beberapa perubahan utama meliputi :

- a. Involusi Uterus : Proses pengerutan rahim kembali ke ukuran semula (berat ± 60 gram) yang didukung oleh kontraksi otot dan hormon oksitosin.
 - b. Pengeluaran Lokia: Cairan sekret uterus yang keluar dalam beberapa tahapan, mulai dari Lokia *Rubra* (merah, hari 1-3) hingga Lokia *Alba* (putih pucat, minggu 2-6).
 - c. Sistem Endokrin: Penurunan drastis hormon plasenta (*estrogen* dan *progesteron*) yang memicu produksi ASI (*laktogenesis*).
 - d. Sistem Lainnya: Terjadi pemulihan pada kandung kemih, sistem pencernaan (risiko konstipasi), serta perubahan tanda-tanda vital seperti suhu tubuh dan nadi yang cenderung meningkat sementara setelah melahirkan.
2. Perubahan Psikologis (Mental)
- Transisi menjadi orang tua membawa dampak emosional yang signifikan dan terbagi dalam tiga fase adaptasi:
- a. *Fase Taking In* (Hari 1-2): Ibu cenderung pasif, fokus pada diri sendiri, dan butuh menceritakan pengalaman persalinannya.
 - b. *Fase Taking Hold* (Hari 3-10): Muncul kecemasan mengenai kemampuan merawat bayi, sehingga memerlukan dukungan intensif.
 - c. *Fase Letting Go* (Hari 10 ke atas): Ibu mulai menerima tanggung jawab dan peran barunya secara penuh.
3. Gangguan Psikologis yang Perlu Diwaspadai Sebagian besar ibu (sekitar 80%) mengalami gangguan emosional pascamelahirkan :
- a. *Postpartum Blues* : Kondisi ringan yang ditandai dengan mudah menangis, cemas, dan sensitif. Biasanya muncul di hari ke-3 hingga ke-5 dan hilang dalam dua minggu.
 - b. *Depresi Postpartum* : Kondisi lebih berat (dialami $\pm 10\%$ ibu) yang memerlukan penanganan medis atau psikologis intensif karena dapat berlangsung berbulan-bulan.

Referensi

- Astuti, S., Judistiani, T. D., Rahmiati, L., & Susanti, A. I. (2017). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Erlangga.
- Cox, J. L. (2019). The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): 30 years on. *The British Journal of Psychiatry*, 214(3), 127-129.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Spong, C. Y., & Casey, B. M. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). New York: McGraw Hill.
- Dira, I. K. P., & Wahyuni, A. S. (2016). Prevalensi Postpartum Blues dan Faktor-faktor Terkait di Wilayah Kerja Puskesmas di Bali. *E-Jurnal Medika Udayana*.
- Ganjoo, M., dkk. (2021). Social Support and Postpartum Depression: A Systematic Review. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK): Tata Laksana Gangguan Depresi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2023). *Maternity & Women's Health Care* (13th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Maghfiroh, S., & Rahmawati, A. (2024). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas (Dilengkapi Evidence Based Practice)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Purwanti, S. (2021). *Fisiologi Masa Nifas: Reorientasi Involusi Uterus dan Sistem Organ*. Jakarta: EGC.
- Reeder, S. J., Martin, L. L., & Griffin, D. K. (2019). *Maternity Nursing: Family, Newborn, and Women's Health Care* (18th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Walyani, E. S. (2019). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience*. Geneva: World Health Organization.
- Yuliana, W., & Hakim, B. N. (2020). *Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas*. Sidoarjo: Yayasan Forum Kader Kesehatan Masyarakat (FKQM).

Glosarium

WUS : Singkatan dari Wanita Usia Subur.

Masa Nifas (Puerperium) : Masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berlanjut hingga organ reproduksi kembali ke keadaan sebelum hamil, biasanya berlangsung sekitar enam minggu atau 42 hari.

Involusi Uterus : Proses di mana rahim (uterus) kembali ke kondisi dan ukuran semula seperti sebelum hamil.

Lokia (Lokia) : Cairan sekret uterus yang keluar melalui vagina selama masa nifas, terdiri dari darah dan sisa jaringan rahim.

Lokia Rubra : Cairan berwarna merah segar yang keluar pada hari ke-1 hingga ke-3 pascapersalinan.

Lokia Sanguinolenta : Cairan berwarna merah kecokelatan yang keluar pada hari ke-4 hingga ke-7.

Lokia Serosa : Cairan berwarna kekuningan atau coklat muda yang muncul pada hari ke-7 hingga hari ke-14.

Lokia Alba : Tahap akhir lokia berwarna pucat atau putih kekuningan yang terjadi pada minggu ke-2 hingga minggu ke-6.

Autolysis : Proses penghancuran sel oleh enzimnya sendiri yang terjadi di dalam otot rahim.

Postpartum Blues : Gangguan suasana hati atau ketidaknyamanan perasaan bersifat ringan yang dialami ibu pada fase awal masa nifas.

Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) : Alat bantu berupa kuesioner yang digunakan untuk melakukan skrining kesehatan mental (seperti kecemasan dan kesedihan) pada ibu baru.

Laktogenesis : Proses dimulainya produksi air susu ibu (ASI).

Fase Taking In : Tahap awal masa nifas (hari 1–2) di mana ibu cenderung pasif, dependen, dan fokus pada pemulihan fisik diri sendiri.

Fase Taking Hold : Tahap masa nifas (hari 3–10) di mana muncul kecemasan terkait kompetensi ibu dalam mengasuh bayinya.

Fase Letting Go : Tahap (setelah hari ke-10) di mana ibu mulai menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola peran barunya.



CHAPTER 3



PENGKAJIAN KEBIDANAN PADA IBU POSTPARTUM

Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.

Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, yang berlangsung kira-kira 6 minggu (Walyani & Purwoastuti, 2021). Dalam masa kritis ini, ibu mengalami adaptasi fisiologis dan psikologis yang masif. Peran bidan sangat krusial dalam mendampingi dan memantau kesejahteraan ibu dan bayi.

Pengkajian kebidanan pada ibu postpartum bukan sekadar rutinitas tanya-jawab dan pemeriksaan fisik. Ini adalah proses sistematis, holistik, dan berkesinambungan untuk mengumpulkan data, menganalisis status kesehatan, dan mendeteksi dini komplikasi (Lowdermilk et al., 2020).

A. Konsep Dasar Pengkajian Postpartum

Pengkajian kebidanan dilakukan dengan mengumpulkan data subjektif (melalui anamnesis) dan data objektif (melalui pemeriksaan fisik dan penunjang). Menurut pedoman Kementerian Kesehatan RI dan standar WHO terbaru, kunjungan nifas (KF) wajib dilakukan minimal 4 kali (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2023):

KF 1: 6 jam - 2 hari setelah persalinan. Fokus pada pencegahan perdarahan, pemantauan involusi, dan inisiasi menyusui.

KF 2: 3 - 7 hari setelah persalinan. Fokus pada memastikan involusi berjalan baik, evaluasi nutrisi, dan menyusui.

KF 3: 8 - 28 hari setelah persalinan. Evaluasi asuhan secara menyeluruh.

KF 4: 29 - 42 hari setelah persalinan. Evaluasi kesiapan ibu kembali ke peran ganda dan konseling keluarga berencana (KB).

B. Pengkajian Data Subjektif (Anamnesis)

Anamnesis memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman, keluhan, serta kebutuhan ibu yang tidak dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan fisik (Irawati & Yuliani, 2020). Melalui wawancara, tenaga kesehatan dapat mengetahui keluhan nyeri, permasalahan yang dialami ibu, rasa lelah, kesulitan menyusui, kondisi emosional seperti cemas atau postpartum blues, pola istirahat,

serta dukungan keluarga yang dialami ibu (Irawati & Yuliani, 2020; Wulan et al., 2023).

1. Identitas

- a. Nama: Untuk mengidentifikasi dan memanggil ibu dengan tepat, mencegah kesalahan antar pasien, serta menjaga keamanan identifikasi dalam dokumentasi klinis. Jika diperlukan, berikan nama panggilan sehari-hari agar tidak keliru dalam memberikan perawatan (Susanto, 2018).
- b. Umur: Umur ibu termasuk indikator krusial dalam mendeteksi adanya gangguan psikososial atau pergeseran adaptasi dalam merawat bayi dan memerankan perannya sebagai ibu, terutama bagi yang berusia ekstrem (remaja atau lanjut usia), umur kurang dari 20 tahun alat reproduksi belum matang, kesehatan mental dan mental belum siap, dan lebih dari 35 tahun rentan sekali terjadi perdarahan selama nifas (Arifin & Putri, 2021; Anggita Sari et al., 2018). Data usia ibu membantu bidan dalam memberikan edukasi kesehatan yang sesuai, seperti panduan nutrisi, istirahat, konseling menyusui, dan rencana kontrasepsi, sehingga intervensi menjadi terfokus, relevan, dan efektif dalam mendukung pemulihan ibu pasca persalinan (Arifin & Putri, 2021).
- c. Agama: Untuk mengetahui keyakinan pasien, sebagai sumber daya psikososial yang meningkatkan ketahanan mental ibu, dan menurunkan risiko depresi postpartum (Kemenkes RI, 2020).
- d. Pendidikan: Informasi vital yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, edukasi kesehatan, dan adaptasi ibu terhadap peran baru sebagai orang tua. Level pendidikan berperan sebagai penentu dalam menyesuaikan metode penyampaian informasi, apakah dibutuhkan penjelasan sederhana, visualisasi, atau diskusi lebih mendalam serta membantu bidan memetakan kesiapan ibu menerima edukasi seperti teknik menyusui, perawatan diri, KB pasca-persalinan, dan pengenalan tanda bahaya. Selain itu, data pendidikan menjadi indikator dalam memahami latar belakang psikososial ibu, termasuk kapasitas literasi kesehatan dan preferensi belajar (Ratnaningsih et al., 2025).
- e. Suku/bangsa : Mencerminkan latar belakang budaya dan adat istiadat ibu atau keluarganya, yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan dan respons terhadap intervensi bersalin atau nifas. Informasi ini memungkinkan bidan menyusun pendekatan asuhan yang sensitif terhadap kebiasaan lokal seperti pola nutrisi, praktik persalinan tradisional, maupun kepercayaan yang mendasari sehingga upaya promosi kesehatan maupun edukasi menjadi lebih efektif dan dapat diterima oleh ibu (Kemenkes RI, 2020).

- f. Pekerjaan: Untuk mengetahui dan mengukur tingkat sosial ekonomi pasien, memudahkan bidan untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi dan edukasi misalnya memilih waktu kunjungan yang sesuai dan metode penyuluhan yang bisa diakses serta memetakan risiko pekerjaannya, misalnya apakah pekerjaan tersebut fisik atau stres mental, yang dapat mempengaruhi pemulihan pasca persalinan (Novisah, 2024). Selain itu, data ini mendukung kontinuitas asuhan dan koordinasi dengan tim kesehatan lainnya, sekaligus menjadi bagian dari catatan legal dan statistik yang penting untuk evaluasi kualitas pelayanan kesehatan.
- g. Alamat: Sebagai identifikasi pasien untuk memastikan keselamatan, memudahkan tindak lanjut pasca persalinan, dan mendukung kontinuitas asuhan. Alamat yang lengkap membantu tenaga kesehatan mengatur kunjungan rumah atau intervensi masyarakat jika diperlukan, serta memudahkan koordinasi rujukan atau penanganan jika terjadi kondisi gawat darurat (Saleh et al., 2022).

2. Alasan Kedatangan

Untuk mengetahui tujuan ibu melakukan pemeriksaan, Informasi ini memungkinkan bidan memahami dengan tepat apa yang ibu rasakan baik secara fisik maupun emosional sebagai dasar untuk evaluasi kondisi, merumuskan diagnosa kebidanan yang relevan, serta merancang intervensi tepat sasaran (Prawirohardjo, 2018).

3. Keluhan utama

Untuk mengetahui masalah yang timbul karena masa nifas. Ibu yang mengalami baby blues akan mengeluhkan cemas yang berlebihan dan stres sedangkan ibu yang mengalami inkontinensia urine akan merasa tidak nyaman dikarenakan kesulitan dalam menahan buang air kecil (Irawati & Yuliani, 2020; Indrawaty et al., 2023).. Dengan catatan tersebut, bidan dapat segera melakukan penilaian lanjutan, merumuskan diagnosa kebidanan yang tepat, dan merencanakan intervensi klinis yang sesuai seperti konseling psikososial untuk dukungan emosional maupun latihan otot dasar panggul untuk inkontinensia.

4. Riwayat Menstruasi

Data ini membantu pemantauan restitusio fisiologis setelah melahirkan, identifikasi risiko anemia akibat perdarahan abnormal, serta dasar edukasi keluarga berencana untuk mencegah kehamilan dini. Informasi seperti tanggal menstruasi terakhir (LMP), durasi siklus, lama perdarahan, atau pola ketidakteraturan dapat membantu bidan memperkirakan waktu ovulasi, mendeteksi gangguan hormon, dan memahami fase amenore laktasi (LAM) yang

berpotensi berfungsi sebagai metode kontrasepsi alami selama menyusui jika terpenuhi syarat tertentu (Varney, 2017).

5. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Memberikan gambaran klinis yang jelas tentang pengalaman reproduksi ibu seperti frekuensi kehamilan, metode persalinan, komplikasi sebelumnya, serta kondisi nifas terdahulu seperti perdarahan atau infeksi yang dapat mempengaruhi manajemen kehamilan saat ini dan pemulihan pasca persalinan. Misalnya, riwayat persalinan yang lama, bayi besar, atau adanya perdarahan postpartum sebelumnya menjadi petunjuk penting untuk prediksi kebutuhan pemantauan lebih intensif atau intervensi dini dalam nifas saat ini (WHO, 2015).

6. Riwayat Kesehatan

a. Riwayat kesehatan lalu: Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan riwayat penyakit akut atau kronis seperti jantung, diabetes mellitus, hipertensi, dan asma yang dapat mempengaruhi nifas. Apabila terdapat riwayat penyakit, bidan dapat melakukan monitoring lebih ketat terhadap tanda vital dan fundus, merencanakan intervensi yang tepat, serta menyusun rujukan ke tenaga medis jika diperlukan, sehingga mendukung keselamatan ibu dan kualitas asuhan postpartum secara menyeluruh (Maritalia, 2017).

b. Riwayat kesehatan sekarang: Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan penyakit yang diderita saat ini yang terkait dengan masa nifas dan kesehatan bayi. Data ini membantu bidan mengenali risiko komplikasi pasca persalinan, seperti infeksi puerperal, preeklampsia atau gangguan metabolik yang sering terjadi dalam periode nifas. Dengan mengetahui riwayat medis mendadak atau sedang berlangsung, bidan dapat menerapkan jejaring pemantauan yang tepat termasuk pemantauan tanda vital yang lebih intens, intervensi segera, ataupun rujukan klinis bila diperlukan (Saifullah, et al 2022).

c. Riwayat kesehatan keluarga: Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan penyakit keluarga berdampak pada gangguan kesehatan pasien dan bayinya. Data mengenai penyakit seperti hipertensi, diabetes, gangguan kardiovaskular, ataupun kelainan genetik pada anggota keluarga seperti orang tua, saudara kandung, atau kakek-nenek memberi landasan bagi bidan untuk melakukan penilaian risiko dini, merancang strategi pencegahan, serta melakukan pendekatan intervensi yang personal (Maritalia, 2017).

7. Riwayat Perkawinan

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk jumlah kali menikah dan status menikah yang sah, karena melahirkan anak tanpa status yang jelas akan berdampak pada kesehatan mental, sehingga mempengaruhi proses nifas. Informasi seperti berapa kali telah menikah, usia saat menikah, status pernikahan

(resmi atau tidak), serta lama menjalin pernikahan sangat penting karena berkaitan erat dengan kondisi psikologis ibu setelah melahirkan. Misalnya, ibu yang melahirkan tanpa status pernikahan yang jelas mungkin akan mengalami stres emosional lebih tinggi, yang pada gilirannya bisa memperburuk adaptasi pasca persalinan, seperti kecenderungan munculnya baby blues (Kemenkes RI, 2020).

8. Riwayat Kontrasepsi

Untuk mengetahui jenis kontrasepsi apa yang pernah digunakan pasien selama pengobatan KB, berapa lama, adakah keluhan selama penggunaan kontrasepsi, dan rencana pengobatan KB setelah nifas ini dan kontrasepsi apa yang digunakan saat ini. Metode kontrasepsi sebelumnya dapat mempengaruhi perhitungan usia kehamilan terutama estimasi hari persalinan (EDD) dan bahkan berhubungan dengan komplikasi seperti hipertensi dalam kehamilan. Selain itu, dokumentasi jenis, durasi pemakaian, serta komplikasi terkait metode kontrasepsi sebelumnya (seperti kegagalan IUD atau efek samping hormonal) sangat penting dalam memandu pilihan metode kontrasepsi pasca nifas yang tepat dan aman bagi ibu.

9. Riwayat Laktasi

Mencatat riwayat laktasi termasuk keberhasilan menyusui sebelumnya, durasi ASI eksklusif yang pernah dilakukan, atau riwayat keterlambatan produksi ASI dapat membantu dalam memahami pola laktasi ibu saat ini dan menilai risiko keterlambatan onset laktasi (delayed lactogenesis II), yang dialami oleh 20–44% ibu dan sering dipicu oleh stres persalinan, primiparitas, atau riwayat sebelumnya. Informasi ini digunakan untuk merancang intervensi awal seperti edukasi teknik menyusui, pijat laktasi, dan inisiasi menyusui dini (IMD) yang dapat meningkatkan keberhasilan laktasi (Yanti dkk, 2023).

10. Pola Kebiasaan

- a. Nutrisi : Menjelaskan cara makan dan minum, frekuensi, banyaknya, jenis makanan, dan makanan pantangan. Untuk ibu nifas yang mengalami gangguan dalam perkemihan, disarankan untuk minum dengan cukup dan menghindari kafein (Prawirohardjo, 2018).
- b. Istirahat : Menjelaskan bagaimana pasien tidur dan tidur, berapa lama jam tidur, kebiasaan sebelum tidur seperti membaca, mendengarkan musik, mengonsumsi obat tidur, tidur siang, dan penggunaan waktu luang. Ibu yang nifas sangat membutuhkan istirahat karena istirahat yang cukup dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi stres (Nur, 2025).
- c. Eliminasi : Menjelaskan cara sekresi berfungsi. Ini termasuk kebiasaan buang air besar, yang mencakup frekuensi, jumlah, konsistensi, dan bau, serta

kebiasaan buang air kecil, yang mencakup frekuensi, wama, dan jumlah. Ibu yang mengalami inkontinensia urine akan lebih mudah besar tanpa aba-aba (Prawirohardjo, 2018).

- d. Aktivitas : Menjelaskan apa yang dilakukan pasien setiap hari. Pada pola ini, pengaruh aktivitas terhadap kesehatannya harus dipelajari. Mobilisasi awal dapat mempercepat pengembalian alat reproduksi. Apakah ibu melakukan ambulasi, seberapa sering, apakah menghadapi kesulitan, dengan bantuan atau sendiri, dan apakah ibu mengalami pusing saat melakukannya (Fitriani, 2021).
- e. Personal Hygiene : Dipelajari untuk mengetahui apakah ibu selalu menjaga kebersihan tubuhnya, terutama di area genitalia karena lokia masih dikeluarkan selama masa nifas, seberapa sering mengganti pembalut dan celana dalam apabila ibu sering buang air kecil, dan cara cebok yang benar (Hayati, 2020).

11. Sosial Budaya

Untuk mengetahui pasien dan keluarga mereka tentang kebiasaan yang baik atau buruk, terutama yang berkaitan dengan makanan yang mereka makan saat nifas. Tradisi pasca persalinan, norma keluarga, atau pengaruh spiritual bidan dapat menyesuaikan intervensi yang lebih sensitif dan efektif, membangun kepercayaan, serta mencegah ketidaknyamanan atau resistensi terhadap perawatan (Kemenkes RI, 2020).

12. Psikologis

Dipelajari untuk mengetahui bagaimana ibu dan keluarga berperilaku terhadap bayinya. Keadaan psikologis ibu nifas yang mengalami baby blues, dapat membuat ibu memiliki perasaan tidak nyaman, khawatir, hingga stres. Informasi seperti perubahan mood, gejala baby blues, kecemasan, atau tanda gangguan psikologis lainnya menjadi data dasar yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah klinis, menyusun diagnosis yang akurat dan baik bersifat mandiri maupun kolaboratif dan merencanakan tindakan intervensi yang sesuai, seperti konseling atau dukungan psikososial. Pada hari ke-7 postpartum ibu seharusnya berada dalam masa adaptasi taking hold, dimana pada fase ini ibu sudah mulai menerima peran barunya dan cenderung bisa menerima saran dari orang sekitarnya, namun pada fase ini ibu masih memerlukan dukungan psikologis dari orang-orang disekitarnya (Dewi & Oktari, 2021; Walyani & Purwoastuti, 2021).

C. Pengkajian Data Objektif (Pemeriksaan Fisik dan Penunjang)

Pemeriksaan data objektif dilakukan melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan pemeriksaan laboratorium terindikasi untuk menegakkan diagnosis (Surtinah et al., 2019).

1. Keadaan umum

Suatu keadaan dalam diri klien yang dapat diamati oleh tenaga kesehatan. Dimana kondisi tersebut mencerminkan kesehatan fisik klien. Pemeriksaan keadaan umum pada ibu nifas bertujuan untuk menilai kesehatan secara keseluruhan dengan mengukur tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernapasan, serta mendeteksi adanya komplikasi seperti infeksi. Dengan mengetahui kondisi ibu, tenaga medis dapat segera mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan merumuskan rencana perawatan yang sesuai untuk ibu. Oleh karena itu, pemeriksaan ini sangat krusial untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu serta mendukung proses pemulihan pascamelahirkan. Pemeriksaan keadaan umum meliputi:

- a. Baik : composmentis, TTV normal, bisa berkomunikasi dengan baik dan mampu mengatakan dan melakukan apa yang menjadi kebutuhannya.
- b. Cukup : kesadaran composmentis sampai apatis, TTV normal, tetapi untuk memenuhi kebutuhan memerlukan bantuan orang lain baik secara sebagian atau keseluruhan.
- c. Lemah : composmentis sampai dengan somnolen, TTV tidak normal, memenuhi kebutuhan harus dibantu secara keseluruhan, memerlukan observasi berkala dan bantuan alat medis (Surtinah et al, 2019).

2. Kesadaran

Bertujuan untuk menilai status kesadaran klien. Kesadaran yang baik adalah composmentis yang berarti klien memiliki kontrol atas dirinya dan apa yang sedang dilakukan. Sedangkan kesadaran yang buruk adalah ketika klien tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, tidak mampu berkomunikasi dan tidak memberikan respon rangsangan dengan baik. Pemeriksaan ini membantu tenaga medis mengambil tindakan cepat jika ditemukan penurunan kesadaran atau tanda bahaya lainnya, serta merencanakan asuhan yang tepat untuk mendukung pemulihan ibu. Macam-macam kesadaran diantaranya;

- a. Composmentis: kesadaran yang normal, sadar sepenuhnya, dan dapat berkomunikasi dengan baik.
- b. Apatis: kesadaran yang bersikap acuh tak acuh. Artinya memahami apa yang orang lain sampaikan, tetapi tidak ingin merespon.

- c. Delirium: kesadaran klien tidak terkontrol, dimana klien merasa gelisah, disorientasi atau tidak mengenali waktu, tempat, dan orang terkadang disertai dengan halusinasi.
- d. Somnolen: kesadaran klien menurun, respon psikomotor melambat, mudah tertidur, tidak memiliki energi untuk menjaga kesadaran, tetapi dapat kembali sadar saat diberi rangsangan.
- e. Koma: klien tidak memberikan respon apapun baik verbal maupun psikomotor dan tidak bisa dibangunkan (Surtinah et. al, 2019)

3. Antropometri

Pengukuran antropometri meliputi tinggi badan, berat badan, dan lingkaran lengan atas (LILA). Data tersebut membantu tenaga kesehatan dalam memantau kecukupan nutrisi ibu nifas, mendeteksi risiko malnutrisi atau obesitas, serta merencanakan intervensi lanjutan.

a. Tinggi Badan

Tinggi badan ibu nifas diukur untuk menentukan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum dan sesudah persalinan. Meskipun tinggi badan tidak berubah, data ini penting untuk menghitung IMT bersama dengan berat badan. IMT dapat memberikan gambaran tentang status gizi ibu, apakah termasuk kategori kurus, normal, atau kelebihan berat badan.

b. Berat Badan

Pengukuran berat badan pada ibu nifas penting untuk memantau penurunan berat badan alami setelah melahirkan. Normalnya, ibu nifas akan mengalami penurunan berat badan sekitar 5-6 kg segera setelah melahirkan, yang disebabkan oleh keluarnya bayi, plasenta, dan cairan ketuban. Penurunan berat badan ini berlanjut selama masa nifas, dengan rata-rata ibu kehilangan sekitar 4 kg lagi dalam 6 bulan pertama pasca persalinan. Penurunan berat badan yang cepat pada minggu pertama postpartum adalah hal yang normal, disebabkan oleh kehilangan cairan (diuresis) dan involusi uterus. Namun, penurunan berat badan yang berlebihan atau kenaikan berat badan yang signifikan perlu diwaspadai, karena bisa mengindikasikan masalah gizi, retensi cairan, atau komplikasi kesehatan lainnya (Institute of Medicine, 2015).

c. Lingkaran Lengan Atas (LILA)

Pengukuran ini sangat penting untuk mendeteksi Kurang Energi Kronis (KEK), yang dapat mempengaruhi produksi ASI dan pemulihan ibu. Jika LILA kurang dari 23,5 cm, ibu nifas dianggap berisiko KEK dan memerlukan intervensi gizi lebih lanjut. Pengukuran ini biasanya dilakukan secara berkala selama masa nifas untuk memantau perbaikan status gizi ibu.

4. Tanda-Tanda Vital

a. Tekanan Darah (TD)

Umumnya, tekanan darah akan kembali ke nilai sebelum hamil. Peningkatan tekanan darah, terutama di atas 140/90 mmHg, dapat menjadi tanda awal preeklampsia postpartum, suatu kondisi serius yang bisa terjadi hingga 6 minggu setelah melahirkan dan berpotensi menyebabkan kejang. Di sisi lain, penurunan tekanan darah drastis atau hipotensi yang disertai dengan peningkatan nadi bisa menjadi indikasi syok hipovolemik akibat perdarahan hebat.

b. Nadi

Denyut nadi normal pada ibu nifas berkisar antara 60-80 denyut per menit. Takikardi (nadi >100 denyut per menit) merupakan tanda bahaya yang sering muncul lebih dulu daripada tanda syok lainnya. Peningkatan denyut nadi dapat disebabkan oleh perdarahan, dehidrasi, atau infeksi.

c. Suhu Tubuh

Suhu normal pada ibu nifas adalah 36,5-37,5°C. Febris atau demam (suhu >38°C) yang terjadi setelah 24 jam pertama pasca persalinan merupakan tanda potensial adanya infeksi, seperti endometritis (infeksi pada lapisan rahim), infeksi saluran kemih, atau infeksi pada luka jahitan.

d. Pernapasan

Laju pernapasan normal pada ibu nifas berada di kisaran 16-24 kali per menit. Peningkatan laju pernapasan yang signifikan atau takipnea seringkali berhubungan dengan takikardi dan bisa menjadi indikasi awal syok atau komplikasi lain yang mempengaruhi fungsi pernapasan.

5. Pemeriksaan Fisik

a. Kepala

Pemeriksaan pada kepala meliputi wajah, mata, dan mulut. Pemeriksaan pada wajah dilakukan untuk melihat adanya edema (pembengkakan) yang bisa menjadi tanda preeklampsia postpartum. Edema pada wajah, terutama di sekitar mata, bisa menjadi tanda bahwa ginjal mengalami kesulitan dalam membuang kelebihan cairan. Selain itu, bidan juga memeriksa adanya pucat pada wajah yang dapat mengindikasikan anemia akibat kehilangan darah selama persalinan serta memeriksa konjungtiva (selaput mata). Konjungtiva yang pucat menunjukkan kadar hemoglobin yang rendah, yang merupakan tanda pasti anemia. Selain itu, bidan juga memeriksa sklera (bagian putih mata). Sklera yang berwarna kekuningan (ikterus) dapat menjadi indikasi adanya masalah pada hati, seperti hepatitis atau kerusakan hati. Bidan juga

perlu melakukan pemeriksaan pada bagian mulut untuk memeriksa kebersihan gigi.

b. Leher

Pemeriksaan leher pada ibu nifas dilakukan untuk menilai kondisi umum, status sirkulasi, dan kemungkinan adanya gangguan metabolik maupun infeksi. Bagian yang diperhatikan terutama adalah kelenjar tiroid, yang dinilai melalui inspeksi dan palpasi guna mendeteksi adanya pembesaran, nodul, atau tanda tiroiditis postpartum yang dapat menyebabkan gangguan hormonal seperti hipertiroidisme atau hipotiroidisme sementara. Selain itu, dilakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening servikal, submandibular, maupun supraklavikula untuk melihat apakah terjadi pembesaran atau nyeri tekan yang bisa menandakan adanya infeksi lokal maupun sistemik, misalnya akibat mastitis atau infeksi saluran pernapasan. Bidan juga dapat memperhatikan vena jugularis, karena distensi atau tanda-tanda peningkatan tekanan vena sentral dapat menjadi indikasi adanya gangguan sirkulasi, terutama pada ibu dengan riwayat penyakit jantung atau preeklampsia (Varney, 2004).

c. Payudara

Pada payudara, pemeriksaan meliputi inspeksi dan palpasi. Inspeksi menilai simetri, kondisi puting (menonjol, datar, atau terbenam; terdapat lesi atau perlukaan), hiperpigmentasi areola, serta keluarnya kolostrum atau ASI. Palpasi dilakukan untuk mengetahui adanya benjolan, nyeri tekan, atau tanda peradangan. Bendungan ASI biasanya ditandai dengan payudara yang tegang, nyeri, dan hangat. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa berkembang menjadi mastitis (radang payudara). Bidan juga mengevaluasi puting susu, apakah terdapat lecet atau luka yang bisa membuat ibu merasa sakit saat menyusui dan berpotensi menjadi jalan masuk bakteri (Varney, 2004).

d. Abdomen

Pemeriksaan abdomen dimulai dengan inspeksi untuk melihat bentuk, ukuran, dan kontur perut, serta adanya bekas luka operasi SC yang mungkin terlihat pada area perut bawah. Selanjutnya, palpasi dilakukan untuk menentukan posisi dan ukuran fundus uteri. Fundus yang teraba di bawah atau sejajar dengan pusar menunjukkan involusi uterus yang normal, sedangkan fundus yang lebih tinggi atau tidak simetris dapat mengindikasikan retensio plasenta atau atonia uterus yang berisiko menyebabkan perdarahan postpartum.

Tabel 3. 1 Tinggi Fundus Uteri Ibu Nifas (Azizah & Rosyida, 2019)

NO	Involusi	TFU	Berat Uterus
1	Bayi lahir	Setinggi pusat	100 gram
2	Uri lahir	2 jari bawa pusat	750 gram
3	1 minggu	Pertengahan pusat sympisis	500 gram
4	2 minggu	Tidak teraba di atas sympisis	350 gram
5	6 minggu	Bertambah kecil	50 gram
6	8 minggu	normal	30 gram

Perkusi dilakukan untuk menilai adanya cairan bebas atau distensi, misalnya pada kasus hemoperitoneum akibat perdarahan internal. Pemeriksaan auskultasi dilakukan untuk menilai aktivitas usus karena gangguan motilitas usus sering dialami pasca persalinan, terutama pada ibu yang menjalani operasi caesar atau menerima obat-obatan tertentu. Deteksi dini terhadap kelainan abdomen pada ibu nifas sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti perdarahan postpartum, infeksi, ataupun gangguan pemulihan uterus. Selain uterus, bidan juga menilai adanya diastasis rekti (pemisahan otot perut) yang kerap terjadi pada ibu dengan kehamilan multipel atau bayi besar, serta memeriksa kondisi luka operasi caesar jika ada, termasuk tanda-tanda infeksi, kelembapan, atau keterlambatan penyembuhan (Azizah & Rosyada, 2019).

e. Genetalia

Inspeksi vulva dan perineum bertujuan untuk menilai kebersihan, adanya luka, robekan, edema, hematoma, ataupun tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, keluarnya nanah, atau nyeri tekan. Pada ibu yang menjalani episiotomi atau mengalami robekan perineum, jahitan diperiksa secara teliti guna memastikan kondisi luka dalam keadaan baik, tidak terbuka kembali, serta tidak terdapat tanda-tanda infeksi yang dapat memperlambat penyembuhan atau memicu perdarahan. Pemeriksaan lochia merupakan bagian integral dari evaluasi postpartum. Lochia adalah cairan nifas yang keluar dari vagina dan menggambarkan proses involusi uterus. Perubahan warna, bau, serta jumlah lochia menjadi indikator penting dalam menilai pemulihan uterus. Lochia yang berbau busuk, berwarna hijau, atau keluar dalam jumlah berlebihan dapat menandakan adanya infeksi atau perdarahan abnormal yang membutuhkan penanganan segera. Secara fisiologis, lochia terbagi menjadi 4 tahapan (Sulfianti et al, 2021) :

- 1) Lochia rubra (hari 1–3), berwarna merah terang karena mengandung darah segar, jaringan sisa plasenta, dan desidua.
- 2) Lochia sanguinolenta (hari 4–7), berwarna merah kecokelatan dan berlendir.
- 3) Lochia serosa (hari 8–14), berwarna kuning kecokelatan dan lebih encer.
- 4) Lochia alba (hari 15–28, bahkan bisa berlangsung hingga minggu ke-6), berwarna putih kekuningan dan lebih sedikit.

Evaluasi Penyembuhan Luka Perineum (Skala REEDA). Trauma perineum, baik akibat laserasi spontan maupun episiotomi, lazim terjadi pada persalinan pervaginam. Asuhan kebidanan pada area ini berfokus pada pencegahan infeksi dan optimalisasi penyembuhan jaringan. Untuk menilai progres penyembuhan luka secara objektif dan terstandar, bidan menggunakan instrumen Skala REEDA (Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge, Approximation).

Pengkajian dilakukan dengan memposisikan ibu dalam posisi Lithotomi atau Sims (miring dengan satu kaki ditekuk), menggunakan pencahayaan yang memadai, dan mematuhi prinsip pencegahan infeksi. Setiap parameter dinilai dari rentang skor 0 hingga 3. Semakin tinggi total skor yang didapat (maksimal 15), semakin buruk proses penyembuhan luka perineum tersebut (Davidson et al., 2020).

Tabel 3. 2 Penilaian Skala REEDA

Parameter	Penjelasan Klinis	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
Redness (Kemerahan)	Mengevaluasi respon inflamasi. Kemerahan ringan di sekitar tepi luka pada hari pertama adalah normal. Kemerahan yang meluas	Tidak ada kemerahan	Kemerahan < 0,5 cm di sekitar sayatan	Kemerahan membentang 0,5 - 3 cm	Kemerahan meluas > 3 cm di luar sayatan

	menandakan infeksi.				
Edema (Pembengkakan)	Pembengkakan terjadi akibat trauma jaringan. Edema hebat dapat memicu nyeri intens dan mengganggu proses mikrokulasi darah di area luka.	Tidak ada edema	Edema < 1 cm dari sayatan	Edema 1 - 2 cm dari sayatan	Edema > 2 cm dari sayatan
Ecchymosis (Memar)	Bercak kebiruan akibat perdarahan subkutan (hematoma). Hematoma yang membesar secara progresif merupakan kondisi kegawatdaruratan.	Tidak ada ekimosis	Ekimosis < 0,25 cm di sekitar sayatan	Ekimosis 0,25 - 1 cm	Ekimosis > 1 cm di sekitar sayatan
Discharge (Sekresi Luka)	Menilai cairan yang keluar dari luka jahitan (bukan lokia). Normalnya tidak ada	Tidak ada cairan (kering)	Cairan serosa (bening/keuningan)	Cairan serosanguinosa (bercampur darah)	Cairan purulen (nanah, berbau busuk)

	cairan atau hanya serosa ringan pada awal nifas.				
Approximation (Kedekatan Tepi Luka)	Menilai apakah jaringan yang dijahit menyatu dengan baik (intak) atau justru merenggang (dehisensi luka).	Tepi luka tertutup rapat	Pemisahan kulit ≤ 3 mm	Pemisahan kulit dan lemak subkutan	Pemisahan luka secara keseluruhan (dehisensi)

Jika total skor REEDA ibu menunjukkan angka yang tinggi (terutama jika ditemukan cairan purulen atau dehisensi luka), bidan harus segera melakukan kolaborasi rujukan medis untuk penatalaksanaan infeksi nifas (Lowdermilk et al., 2020).

f. Ekstremitas

Pemeriksaan ekstremitas pada ibu nifas bertujuan untuk mendeteksi komplikasi pasca persalinan seperti trombosis vena dalam (DVT), edema, dan gangguan sirkulasi. Pemeriksaan ini meliputi inspeksi dan palpasi pada tangan dan kaki dengan fokus terhadap adanya pembengkakan (edema), perubahan warna kulit seperti kemerahan atau sianosis, luka, serta tanda-tanda inflamasi. Edema ringan pada ekstremitas bawah sering ditemukan akibat retensi cairan dan perubahan sirkulasi selama kehamilan, namun edema yang berat, unilateral, atau disertai kemerahan dan nyeri harus diwaspadai sebagai tanda DVT. Palpasi dilakukan untuk menilai suhu kulit, nyeri tekan, dan konsistensi pembengkakan, di mana nyeri tekan pada betis atau sepanjang vena dapat mengindikasikan tromboflebitis. Pemeriksaan tanda Homans juga dapat dilakukan meskipun sensitivitasnya terbatas.

Secara historis, Homan's Sign diajarkan sebagai manuver untuk mendeteksi DVT. Pemeriksaan dilakukan dengan menyangga bagian bawah lutut ibu, sedikit menekuknya, lalu secara cepat namun lembut melakukan dorsofleksi pada telapak kaki ibu (mendorong telapak kaki ke arah lutut). Jika ibu merasakan nyeri tajam di area betis atau ruang poplitea, maka Homan's Sign dinyatakan positif (+). Saat ini, manuver Homan's Sign harus dilakukan

dengan sangat hati-hati. Manipulasi fisik yang agresif atau pijatan (masase) pada betis yang dicurigai mengalami DVT sangat dilarang. Tekanan mekanis dapat melepaskan gumpalan darah (trombus) dari dinding pembuluh vena, yang kemudian bersirkulasi menjadi emboli dan berisiko mematikan jika menyumbat paru-paru (Emboli Paru) (Lowdermilk et al., 2020; Cunningham et al., 2022). Jika terdapat kecurigaan DVT, bidan harus menghentikan pemeriksaan ekstremitas, membaringkan ibu, dan segera merujuk untuk pemeriksaan Doppler Ultrasound.

6. Pemeriksaan Penunjang

Pada asuhan kebidanan nifas fisiologis, pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan secara rutin. Namun, pengkajian menjadi tajam ketika bidan mampu mengidentifikasi kapan pemeriksaan penunjang tersebut menjadi sebuah indikasi medis yang absolut (Kemenkes RI, 2020).

a. Hemoglobin (Hb)

Evaluasi kadar Hemoglobin wajib dipertimbangkan apabila pada pengkajian subjektif dan objektif ditemukan indikasi berikut:

- 1) Ibu tampak sangat pucat (pucat pada konjungtiva, bibir, dan telapak tangan).
- 2) Terdapat riwayat perdarahan masif saat persalinan (Hemorrhagic Postpartum/HPP).
- 3) Ibu mengeluh pusing hebat, lemas yang ekstrem, atau berkunang-kunang saat bangun dari tempat tidur.

Anemia postpartum (kadar Hb < 10 g/dL atau hematokrit < 30%) dapat menghambat proses involusi uterus, menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi (memperburuk skor REEDA), serta menyebabkan suplai oksigen ke jaringan payudara berkurang sehingga menghambat produksi ASI. Penatalaksanaannya meliputi KIE nutrisi kaya zat besi dan suplementasi tablet Fe, atau transfusi darah pada kasus anemia berat (Cunningham et al., 2022).

b. Protein Urine

Pemeriksaan dipstick urine untuk mendeteksi proteinuria dievaluasi secara spesifik apabila:

- 1) Tekanan Darah ibu menunjukkan persistensi hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg) baik tanpa riwayat sebelumnya maupun dengan riwayat preeklampsia saat hamil.
- 2) Disertai gejala penyerta seperti edema non-dependen yang masif (bengkak pada wajah dan tangan), sakit kepala frontal yang berdenyut, nyeri ulu hati (epigastrik), atau pandangan kabur.

Preeklampsia tidak selalu berakhir setelah plasenta lahir. Preeklampsia Postpartum dapat terjadi dalam 48 jam pertama hingga 6 minggu pascasalin. Temuan protein urine positif ($\geq +1$) yang disertai hipertensi merupakan tanda bahaya yang memerlukan stabilisasi (pemberian MgSO₄ dan antihipertensi) serta rujukan segera, karena berisiko memicu kejang (Eklampsia Postpartum) yang mengancam nyawa (Lowdermilk et al., 2020).

Referensi

- Arifin, M., & Putri, A. D. (2021). Hubungan Usia Ibu, Paritas, Dan Dukungan Keluarga Dengan Kejadian Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(2), 87–95.
- Anggita Sari, R., Dewi, N. L., & Putri, A. (2018). Hubungan Paritas Dan Usia Ibu Dengan Kejadian Postpartum Blues. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(3), 210–218.
- Azizah, N., & Rosyidah, R. (2019). *Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Umsida Press, 1-209.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw Hill.
- Davidson, M. R., London, M. L., & Ladewig, P. W. (2020). *Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan* (11th ed.). Pearson.
- Dewi Ciselia, S. S T., & Vivi Oktari, S. S T. (2021). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Jakad Media Publishing.
- Fitriani, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keterlambatan Laktogenesis II Pada Ibu Postpartum. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(4), 320–328.
- Hayati, F. (2020). Personal hygiene pada masa nifas. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 2(1), 4-8.
- Indrawaty, I., Norhapifah, H., Hadiningsih, E. F., & Hartati, D. F. (2023). Predisposisi Inkontinensia Urin pada Postpartum. *Voice of Midwifery*, 13(2), pp. 101-108.
- Institute of Medicine. (2015). Postpartum weight retention: A review of the evidence and strategies for prevention. In *Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines* (pp. 317-340). National Academies Press.
- Irawati, D., & Yuliani, F. (2020). Pengaruh Faktor Psikososial dan Cara Persalinan Terhadap Terjadinya Postpartum Blues pada Ibu Nifas. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Hospital Majapahit*, 6(1), 1–14.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., & Alden, K. R. (2020). *Maternity & Women's Health Care* (12th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Maritalia, D. (2017). *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Novisah, N. (2024). Korelasi antara Pengetahuan, Peran Tenaga Kesehatan dan Pekerjaan dengan Kejadian Mastitis pada Ibu Menyusui. *SIMFISIS: Jurnal Kebidanan Indonesia*, 4(1), 766-773.
- Nur, A. (2025). Hubungan Pola Tidur Ibu Menyusui dengan Produksi ASI di Wilayah Puskesmas Kramat Jati Jakarta Timur (Doctoral dissertation, Universitas Mohammad Husni Thamrin).
- Prawirohardjo, S. (2018). Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Ratnaningsih, D., Ida, A. S., Indrianingrum, I., & Keb, M. (2025). Buku Kebutuhan Dasar Masa Nifas. Mahakarya Citra Utama Group.
- Saifullah, A., Rahmawati, D., & Putri, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Postpartum Blues Pada Ibu Nifas. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 8(4), 210–218.
- Saleh, N. M., Riyadi, A., & Pranata, M. (2022). Asuhan Kebidanan Berkelanjutan/Continuity of Care. *Journal on Education*, 5(4), 11990–11996.
- Sulfianti, S., Nardina, E. A., Hutabarat, J., Astuti, E. D., Muyassaroh, Y., Yuliani, D. R., & Argahen, N. B. (2021). Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Surtinah, N. S. dan N. (2019). Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan. Prodi Kebidanan Magetan.
- Susanto. (2018). Dokumentasi Kebidanan Klinis. Jakarta: EGC.
- Varney, H. (2004). *Varney's Midwifery* (4th/6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Varney, H. (2017). Buku Ajar Asuhan Kebidanan. Jakarta: EGC.
- Walyani, E. S., & Purwoastuti, E. (2021). Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- World Health Organization. (2015). *WHO Recommendations On Postnatal Care Of The Mother And Newborn*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2023). *WHO Recommendations On Maternal And Newborn Care For A Positive Postnatal Experience*. Geneva: World Health Organization.
- Wulan, N., Mawati, I. P., & Sutandi, A. (2023). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Baby Blues Syndrome Pada Ibu Postpartum. *Journal of Nursing Practice and Education*, 4(1), 189-196.
- Yanti, D., Nurmala, I., & Sari, P. (2023). Hubungan Inisiasi Menyusu Dini Dan Frekuensi Menyusui Dengan Keberhasilan ASI eksklusif Pada Ibu Nifas. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 14(1), 25–34.

Glosarium

ASI : Air Susu Ibu

BB : Berat Badan

DVT : Deep Vein Thrombosis (Trombosis Vena Dalam)

Hb : Hemoglobin

HPP : Hemorrhagic Postpartum (Perdarahan Pascapersalinan)

IMD : Inisiasi Menyusu Dini

KB : Keluarga Berencana

KEK : Kurang Energi Kronis

KF : Kunjungan Nifas

KIE : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

LAM : Lactational Amenorrhea Method (Metode Amenore Laktasi)

LILA : Lingkar Lengan Atas

REEDA : Redness, Edema, Ecchymosis, Discharge, Approximation (Kemerahan, Pembengkakan, Memar, Cairan Sekresi, Kedekatan Tepi Luka)

TD : Tekanan Darah

TFU : Tinggi Fundus Uteri

TTV : Tanda-Tanda Vital

WHO : World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)



CHAPTER 4



PERAWATAN IBU NIFAS DAN DETEKSI DINI KOMPLIKASI

Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.

A. Pendahuluan

Masa nifas (puerperium) berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “peur” yang artinya bayi dan “parous” yang berarti melahirkan, masa nifas dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungannya kembali seperti keadaan sebelum hamil, biasanya berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan.

Masa nifas merupakan periode penting yang terjadi setelah ibu melahirkan. Masa ini dimulai setelah plasenta lahir dan berlangsung sampai organ reproduksi ibu kembali mendekati kondisi sebelum hamil. Secara umum, masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, meskipun pemulihan tubuh secara menyeluruh dapat berlangsung sampai 3 bulan. Pada periode ini, ibu mengalami berbagai perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan sosial yang membutuhkan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, terutama bidan.

Masa nifas menjadi fase yang krusial karena tubuh ibu sedang menjalani proses pemulihan setelah kehamilan dan persalinan. Ibu dapat mengalami perubahan fisiologis seperti involusi uterus, pengeluaran lochea, perubahan pada payudara, perubahan sistem reproduksi, gangguan sistem perkemihan, serta perubahan sistem pencernaan. Perubahan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan, seperti nyeri setelah melahirkan, kelelahan, konstipasi, gangguan berkemih, bengkak pada kaki, serta kesulitan menyusui. Jika kondisi ini tidak mendapat pemantauan dan penanganan yang tepat, ibu dapat mengalami komplikasi yang lebih serius.

Selain perubahan fisik, ibu nifas juga mengalami perubahan psikologis. Setelah melahirkan, ibu perlu menyesuaikan diri dengan peran barunya dalam merawat bayi. Proses adaptasi ini dapat menimbulkan rasa cemas, mudah lelah, perubahan suasana hati, *baby blues*, bahkan depresi pascapersalinan. Kondisi psikologis ibu perlu mendapat perhatian yang sama pentingnya dengan kondisi fisik karena dapat memengaruhi proses pemulihan, keberhasilan menyusui, hubungan ibu dan bayi, serta kualitas hidup ibu setelah melahirkan.

Perawatan ibu nifas bertujuan untuk membantu proses pemulihan, mencegah komplikasi, mendukung keberhasilan menyusui, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Pelayanan nifas dilakukan mulai 6 jam sampai 42 hari setelah persalinan. Pelayanan ini minimal dilakukan melalui empat kali kunjungan, yaitu pada 6 jam sampai 2 hari setelah persalinan, hari ke-3 sampai ke-7, hari ke-8 sampai ke-28, dan hari ke-29 sampai ke-42 setelah persalinan. Kunjungan tersebut penting untuk memantau kondisi ibu dan bayi, mendeteksi tanda bahaya, memberikan edukasi kesehatan, serta melakukan rujukan jika ditemukan masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan asuhan kebidanan masa nifas secara menyeluruh. Bidan melakukan pemantauan tanda vital, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan lochea, pemeriksaan payudara, edukasi pemberian ASI, konseling nutrisi, kebersihan diri, perawatan bayi baru lahir, keluarga berencana, serta deteksi dini komplikasi. Dengan pelayanan yang tepat, bidan dapat membantu ibu menjalani masa nifas dengan aman, nyaman, dan sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan tentang perawatan ibu nifas dan deteksi dini komplikasi sangat penting dalam asuhan kebidanan. Pemahaman yang baik mengenai masa nifas membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan sesuai kebutuhan ibu. Asuhan kebidanan yang optimal pada masa nifas diharapkan dapat menurunkan risiko komplikasi, meningkatkan kesehatan ibu, mendukung tumbuh kembang bayi, serta memperkuat kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

B. Konsep Dasar Masa Nifas

Masa nifas adalah masa yang dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir ketika alat rahim kembali ke keadaan normalnya, sekitar kurang lebih 60 gram dimulai segera setelah plasenta lahir. Periode postpartum dimulai setelah dua jam setelah persalinan sampai enam minggu setelah bayi lahir. Masa nifas akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada organ reproduksi, dan banyak memberikan ketidaknyamanan pada masa nifas.

Tahapan pertama pada masa nifas adalah immediate postpartum yaitu tahapan yang dalam waktu 24 jam pertama setelah persalinan. Tahapan kedua disebut dengan early postpartum yaitu tahapan yang terjadi setelah 24 jam persalinan sampai akhir minggu pertama postpartum. Tahapan ketiga yaitu late postpartum dimana tahapan ini terjadi pada minggu kedua sampai minggu keenam setelah persalinan.

Masa nifas merupakan fase krusial dalam perawatan ibu dan bayi baru lahir. 50% kematian ibu terjadi pada masa nifas dan terjadi 24 jam pertama. Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Peran tenaga kesehatan pada masa nifas sangat penting untuk deteksi dini tanda bahaya nifas dan mencegah terjadinya komplikasi sebagai upaya meningkatkan kesehatan fisik dan kesejahteraan mental ibu pada masa nifas.

Asuhan kebidanan masa nifas adalah perawatan yang diberikan kepada ibu mulai setelah melahirkan sampai tubuhnya pulih seperti sebelum hamil atau mendekati keadaan sebelum hamil. Menurut buku KIA edisi 2020, pelayanan kesehatan pada ibu nifas mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan dilakukan minimal empat kali kunjungan nifas. Kunjungan nifas yang pertama dilakukan pada 6 jam-2 hari setelah persalinan, kunjungan kedua dilakukan 3-7 hari setelah persalinan, kunjungan ketiga dilakukan 8-28 hari setelah persalinan dan kunjungan keempat dilakukan pada 29-42 hari setelah persalinan.

Dalam masa nifas ini, tidak sedikit ibu yang mengalami problem kesehatan seperti nyeri, bengkak pada kaki, ketidakmampuan menyusui dan nutrisi. Program nasional masa nifas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan deteksi dini infeksi dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, dengan cara melakukan kunjungan sebanyak empat kali selama periode masa nifas. Bidan mempunyai peran yang sangat penting dalam masa ini melalui pendidikan kesehatan, monitoring dan deteksi dini bahaya nifas.

Kunjungan selama nifas sering dianggap tidak penting oleh tenaga kesehatan karena sudah merasa baik dan selanjutnya berjalan dengan lancar. Konsep early ambulation dalam masa postpartum merupakan hal yang perlu diperhatikan karena terjadi perubahan hormonal. Pada masa ini, ibu membutuhkan petunjuk dan nasihat dari bidan sehingga proses adaptasi setelah melahirkan berlangsung dengan baik.

Bidan memegang peranan penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan pengertian masyarakat melalui konsep promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam standar pelayanan kebidanan, bidan memberikan pelayanan bagi ibu pada masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua dan minggu keenam setelah persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini, penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, personal hygiene, nutrisi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan keluarga berencana.

Tenaga kesehatan selalu melakukan pemantauan karena pelaksanaan yang kurang maksimal, yang dapat menyebabkan ibu mengalami berbagai masalah bahkan dapat berlanjut pada komplikasi masa nifas seperti sepsis puerperalis. Infeksi merupakan penyebab kematian terbanyak nomor dua setelah perdarahan, sehingga sangat tepat jika para tenaga kesehatan memberikan perhatian yang tinggi pada masa ini.

Pada masa nifas ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis, seperti involusi rahim, nyeri setelah melahirkan, perubahan hormon, kelelahan serta perubahan psikologis yang mencakup penyesuaian terhadap peran baru sebagai seorang ibu. Perubahan yang terjadi seringkali menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik dan emosional, yang dapat memengaruhi kualitas hidup ibu nifas jika tidak diatasi secara tepat. Kenyamanan ibu nifas merupakan indikator penting dalam keberhasilan pelayanan kebidanan karena berkaitan langsung dengan proses pemulihan fisik, kesejahteraan psikologis, serta kemampuan ibu untuk merawat diri dan bayinya.

C. Tujuan Perawatan Ibu Nifas

Pada masa nifas, ibu mengalami penyesuaian fisiologis dan psikologis yang membutuhkan perawatan optimal untuk mendukung pemulihan dan kesejahteraan ibu serta bayi. Perubahan hormonal yang drastis, khususnya penurunan hormon endorfin, estrogen dan progesteron setelah plasenta lahir, dapat mempengaruhi kondisi psikologis ibu dan meningkatkan risiko postpartum blues hingga depresi postpartum jika tidak mendapat dukungan yang memadai.

Selain itu, perdarahan, infeksi dan hipertensi juga merupakan penyebab umum kematian ibu, dengan sebagian besar terjadi selama masa nifas. Hal ini menunjukkan pentingnya perawatan masa nifas yang tepat untuk mengurangi risiko komplikasi. Perawatan yang tepat saat masa nifas sangat penting untuk mengidentifikasi rasa sakit jangka pendek dan jangka panjang serta kondisi kronis yang menyertai wanita pada masa nifas. Perawatan ini melibatkan upaya ibu, penyedia layanan kesehatan dan keluarganya untuk memastikan nutrisi yang cukup, kebersihan, perawatan payudara serta istirahat yang memadai. Langkah-langkah ini membantu mencegah tanda-tanda bahaya selama periode pascapersalinan yang dapat mengancam kesehatan ibu dan berpotensi menyebabkan komplikasi fatal.

Kurangnya perawatan diri pada ibu nifas dapat menyebabkan masalah seperti (Ulfiana et al., 2022):

1. Infeksi nifas yang terdiri dari endometritis, peritonitis, salpingitis, infeksi pada payudara, mastitis dan infeksi saluran kemih

2. Komplikasi perdarahan dan tromboembolik yang terdiri dari perdarahan postpartum, emboli paru, tromboplebotis akibat mobilisasi yang kurang dan hematoma vulva
3. Gangguan afektif postpartum yang terdiri dari depresi postpartum, postpartum blues dan psikosa nifas

D. Perubahan Fisiologi pada Ibu Nifas

1. Perubahan pada Uterus

Setelah persalinan, oksitosin disekresikan dari kelenjar hipofisis posterior dan bekerja pada otot-otot uterus untuk membantu pengeluaran plasenta, setelah pelepasan plasenta, rongga uterus yang berada didepannya menekan sisi penempelan plasenta yang baru saja terbuka dan secara efektif menutup ujung pembuluh dasar besar yang terbuka.

Rahim merupakan organ tubuh yang spesifik dan unik karena dapat mengecil serta membesar dengan menambah atau mengurangi jumlah selnya. Secara alamiah selama kehamilan, rahim makin lama makin membesar. Setelah persalinan rahim akan mengecil kembali perlahan-lahan ke bentuk semula.

Bila uterus pada ibu postpartum mengalami kegagalan dalam involusi uterus maka akan menyebabkan terjadinya subinvolusi uterus yang dapat mengakibatkan perdarahan dan berlanjut hingga kematian. Saat nifas pada uterus terjadi beberapa perubahan dimulai dari involusi uterus, kontraksi, afterpains, regenerasi tempat plasenta dan keluarnya lokia dari jalan lahir. Proses involusi uterus akan berlangsung proses penyusutan uterus hingga kembali keukuran semula atau sebelum hamil. Normalnya setelah hari kesepuluh uterus tidak lagi teraba, namun bila sampai 2 minggu pasca persalinan uterus belum juga masuk panggul perlu dicurigai adanya subinvolusi.

Involusi uteri dapat juga dikatakan sebagai proses kembalinya uterus pada keadaan semula atau keadaan sebelum hamil. Involusi uteri melibatkan reorganisasi dan penanggalan desidua/endometrium dan pengelupasan lapisan pada tempat implantasi plasenta sebagai tanda penurunan ukuran dan berat serta perubahan tempat uterus, warna dan jumlah lokia.

Dalam mengurangi dampak komplikasi yang dapat dilakukan pada ibu nifas, meliputi;

- a. Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas dan suhu)
- b. Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- c. Pemeriksaan lokia dan cairan per vaginam lain
- d. Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif

- e. Pemeriksaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana
- f. Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
- g. Kebutuhan dasar ibu nifas

Involusi uteri pada masa nifas meliputi reorganisasi dan pengeluaran desidua/endometrium dan eksfoliasi tempat perlekatan plasenta yang ditandai dengan penurunan ukuran dan berat serta perubahan lokasi uterus yang ditandai dengan warna dan jumlah lochea. Apabila terjadi kegagalan involusi uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil maka akan menyebabkan sub involusi. Penyebab sub involusi uteri yang paling sering adalah tertahannya fragmen plasenta, infeksi dan perdarahan lanjut (late postpartum haemorrhage).

2. Pengeluaran Lokia

Pada masa nifas terjadi pengeluaran cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina yang disebut sebagai lokia. Lokia adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan mempunyai reaksi basa/alkalis yang dapat membuat organisme berkembang lebih cepat dari kondisi asam yang ada pada vagina normal. Lokia mempunyai bau yang amis (anyir) meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya berbeda-beda pada setiap wanita. Lokia mengalami perubahan karena proses involusi. Pengeluaran lokia dapat dibagi berdasarkan waktu dan warnanya.

Lokia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Lokia rubra berwarna merah karena berisi darah segar dan sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, verniks caseosa, lanugo dan mekonium selama 2 hari pascapersalinan
- b. Lokia sanguilenta berwarna merah kuning berisi darah dan lendir yang keluar pada hari ke-3 sampai ke-7 pascapersalinan
- c. Lokia serosa dimulai dengan versi yang lebih pucat dari lokia rubra. Lokia ini berbentuk serum dan berwarna merah jambu kemudian menjadi kuning. Cairan tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai hari ke-14 pascapersalinan
- d. Lokia alba adalah lokia yang terakhir yaitu di hari ke-14, bentuknya seperti cairan putih berbentuk krim serta terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran lokia diantaranya bekuan darah pada serviks, uterus tidak berkontraksi, posisi ibu terlentang, robekan jalan lahir dan infeksi. Jika infeksi terjadi, ibu mengalami gejala demam tinggi dan lokia tidak keluar semestinya disertai bau busuk. Selain itu rahim bisa menjadi lembek dan tidak berkontraksi sehingga bisa terjadi perdarahan. Meski infeksi ini jarang berakibat fatal, tapi bila terjadi komplikasi bisa menyebabkan kematian pada ibu nifas.

3. Perubahan pada Payudara

Masa nifas merupakan masa pemulihan dari sembilan bulan kehamilan dan proses persalinan, yang dilalui oleh seorang ibu setelah melahirkan anaknya dan berlangsung selama kurang lebih enam minggu. ASI (Air Susu Ibu) merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu melalui proses menyusui. ASI adalah makanan yang telah disiapkan untuk calon bayi saat ibu mengalami kehamilan. Selama kehamilan, payudara akan mengalami perubahan untuk menyiapkan produksi ASI.

Pengeluaran ASI atau laktasi menjadi salah satu tanda dari perubahan fisiologis yang dialami ibu nifas pada masa ini. ASI sangat dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir sampai usia sekitar 6 bulan, karena ASI memiliki komposisi gizi yang paling lengkap dan ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Masa laktasi sudah disiapkan sejak kehamilan. ASI akan mengalami perubahan mulai dari kolostrum sampai dengan ASI matur. Kolostrum merupakan ASI yang muncul dari hari pertama sampai hari ke tiga yang berwarna kekuningan dan agak kasar karena banyak mengandung lemak dan sel-sel epitel serta mengandung kadar protein yang tinggi. Peralihan air susu ibu sudah terbentuk pada hari ke empat sampai hari ke sepuluh dan ASI matur akan dihasilkan mulai hari ke sepuluh dan seterusnya.

Dalam proses pengeluaran ASI terdapat dua hal berpengaruh yaitu reproduksi dan pengeluaran. Produksi ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan pengeluaran diproduksi oleh hormon oksitosin. Saat masa nifas ditandai oleh banyak perubahan fisiologis, salah satunya ialah perubahan payudara. Saat masa hamil, payudara akan melalui masa pembesaran akibat dari peningkatan hormon estrogen yang berfungsi untuk mempersiapkan produksi ASI dan laktasi, pembesaran payudara dapat mencapai 800 gr.

Selain itu payudara juga teraba keras dan menghitam pada areola mammae di sekitar puting susu yang menandakan akan dimulainya proses menyusui. Pembuluh darah akan membesar terisi darah sehingga menimbulkan rasa hangat, sel-sel acini yang menghasilkan ASI sudah mulai berfungsi, dan ketika bayi menghisap puting, refleks syaraf merangsang kelenjar posterior hipofisis yang berfungsi untuk mensekresi hormon oksitosin.

4. Perubahan pada Sistem Reproduksi

a. Perubahan Vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan, serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap dalam keadaan kendur. Setelah tiga minggu, vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae

dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali, sementara labia menjadi lebih menonjol.

Meskipun perineum tetap utuh pada saat melahirkan, ibu tetap mengalami memar pada jaringan vagina dan perineum selama beberapa hari pertama postpartum. Para ibu yang mengalami cedera perineum akan merasakan nyeri selama beberapa hari hingga penyembuhan terjadi.

b. Perubahan Perineum

Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Pada postpartum hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum hamil.

5. Perubahan pada Sistem Perkemihan

Salah satu penyebab kematian ibu adalah perdarahan postpartum, perdarahan postpartum dikarenakan kandung kemih yang mengembang dan mengganggu proses kontraksi uterus sehingga menghambat proses turunnya rahim pasca lahir yang seharusnya terjadi. Pada masa nifas terjadi perubahan fisiologis dan psikologis yang menyebabkan ketidaknyamanan pada masa nifas yang sering dijumpai, salah satunya yaitu perubahan sistem perkemihan termasuk infeksi saluran kemih, retensio urine, atau inkontinensia. Selama proses persalinan, trauma tidak langsung dapat terjadi pada uretra dan kandung kemih. Dinding kandung kemih dapat mengalami hiperemesis dan edema serta sering kali disertai daerah hemoragik. Rasa nyeri pada panggul yang timbul akibat dorongan kepala bayi saat persalinan serta rasa nyeri akibat laserasi vagina atau episiotomy dapat mempengaruhi proses berkemih.

Pada persalinan pervaginam, retensi urin terjadi akibat regangan kuat yang terjadi saat proses persalinan yang mengakibatkan kelemahan dan kerusakan dari otot-otot dasar panggul (*musculus levator ani*), sehingga menyebabkan berkurangnya tahanan bahkan penutupan uretra terhadap tekanan kandung kemih. Akibat dari regangan kuat tersebut juga mengenai bladder neck, otot-otot sfingter uretra dan ligamentumnya.

Gangguan pengeluaran urin dapat menyebabkan terganggunya kontraksi uterus dan dapat mengakibatkan perdarahan postpartum. Jika urin tidak segera dikeluarkan maka akan menyebabkan distensi kandung kemih yang kemudian mendorong uterus ke atas dan ke samping. Ada beberapa hal yang mengakibatkan pengeluaran urin terhambat, diantaranya trauma intra partum, reflek kejang sfingter uretra, hipotonia selama kehamilan dan nifas serta posisi tidur terlentang. Reflek kejang sfingter terjadi apabila pasien postpartum merasa

takut jika luka episiotomi terkena urin sehingga menahan keinginan untuk berkemih.

Pada masa nifas terjadi gangguan pada jaringan dan fungsi kandung kemih, dimana terjadi peningkatan kapasitas kandung kemih, kelemahan otot kandung kemih, penurunan sensitifitas uretra serta adanya efek dari trauma vulva termasuk pemberian anastesi yang mempengaruhi uretra dan kandung kemih.

Kandung kemih yang tidak terjaga frekuensi pengosongannya pada masa nifas dapat melemahkan kontraksi uterus risiko perdarahan karena gangguan kontraksi dan infeksi saluran perkemihan semakin meningkat, dikarenakan kandung kemih yang penuh akan menekan uterus sehingga terjadi kelemahan kontraksi dan gagal terjadi kompresi pembuluh darah. Kandung kemih yang penuh juga menjadi media berkembangnya mikroorganisme dan mengeluarkan toksin sehingga akhirnya terjadi infeksi saluran kemih.

6. Perubahan pada Sistem Pencernaan

Masa nifas merupakan suatu keadaan fisiologis dimana berlangsungnya pemulihan kembali yang dimulai dari persalinan selesai sampai kembali seperti sebelum hamil. Sebagian besar organ-organ tubuh ibu mengalami involusi dan penyesuaian dari masa kehamilan, bersalin dan kesiapan untuk menyusui. Beberapa hal yang berpengaruh pada masa nifas adalah penyesuaian sistem pencernaan.

Biasanya ibu mengalami konstipasi setelah persalinan. Hal ini disebabkan karena pada waktu melahirkan alat pencernaan mendapat tekanan yang menyebabkan kolon menjadi kosong, tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan awal masa pascapartum, diare sebelum persalinan, pengeluaran cairan yang berlebihan pada waktu persalinan, kurangnya asupan makanan, dehidrasi, hemoroid dan kurangnya aktivitas tubuh serta laserasi jalan lahir.

Selain itu kesulitan defekasi mungkin terjadi masalah pada puerperium awal karena kurangnya makanan padat selama persalinan dan menahan defekasi karena perineumnya mengalami perlukaan atau karena ia kurang pengetahuan dan takut akan merobek atau merusak jahitan jika ia melakukan defekasi. Beberapa cara agar ibu nifas dapat buang air besar kembali teratur, antara lain, pemberian diet/makanan yang mengandung serat, pemberian cairan yang cukup, pengetahuan tentang pola eliminasi pasca melahirkan, pengetahuan tentang perawat luka jalan lahir dan usaha terakhir adalah pemberian obat pencahar bila dalam waktu tiga hari ibu belum buang air besar untuk mencegah konstipasi berkelanjutan.

Kesulitan defekasi yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan konstipasi. Konstipasi didefinisikan sebagai frekuensi buang air besar (BAB) yang

kurang dari 3 kali seminggu dengan feses yang keras dan kecil-kecil serta disertai dengan kesulitan sampai rasa sakit saat defekasi. Konstipasi dapat menimbulkan stres berat bagi penderita akibat ketidaknyamanan. Bila konstipasi terjadi berulang dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan beberapa komplikasi, antara lain : hipertensi arterial, impaksi fekal, hemoroid, kanker kolon dan rektum, kanker kolon dan rektum merupakan kanker saluran cerna yang paling sering berisiko terjadi pada penderita konstipasi jangka panjang.

E. Perubahan Psikologi pada Ibu Nifas

1. Fase Adaptasi Psikologis Ibu Nifas

Berbagai ekspresi setelah melahirkan meliputi ibu merasa bangga karena telah mengalami kesulitan, kecemasan kesakitan, penderitaan dengan upayanya sendiri. Ibu bahagia karena telah mendapatkan relasi dengan bayi. Namun ibu juga mengalami gejala-gejala psikis seperti ibu mengalami kesenduan, kepedihan hati, kekecewaan dan penderitaan batin, contoh karena anak diluar nikah, jenis kelamin anak tidak sesuai dengan harapan, bayi cacat sehingga timbul rasa tidak cinta anaknya.

Adaptasi psikologi ibu postpartum dimulai setelah melahirkan sehingga ibu mulai peran baru melawati bayinya. Hal ini menjadi tanggung jawab baru bagi ibu dimana ibu juga harus beradaptasi terhadap kondisi fisik, dimana jika adaptasi psikologi ibu tidak bisa berjalan dengan baik maka akan menimbulkan masalah atau gangguan psikologis masa nifas seperti baby blues. Adaptasi psikologi ibu masa nifas agar tidak terjadi gangguan psikologi nifas, yaitu dengan memberikan dukungan kepada ibu, dukungan dapat diberikan oleh suami atau keluarga.

Perubahan psikologi dipengaruhi fluktuasi hormon, kelelahan pascapersalinan, perubahan pola tidur, serta tuntutan adaptasi terhadap peran baru sebagai seorang ibu. Kondisi ini menjadikan masa nifas sebagai periode yang rentan terhadap gangguan kesehatan mental.

Secara global, masalah kesehatan mental pada ibu nifas masih menjadi isu yang cukup tinggi. Berbagai kajian kesehatan menjelaskan bahwa sebagian ibu mengalami gangguan psikologis seperti baby blues syndrome, kecemasan, hingga depresi postpartum dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Apabila kondisi ini tidak terdeteksi dan ditangani secara tepat, dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup ibu, proses bonding antara ibu dan bayi, serta tumbuh kembang anak di masa depan. Oleh karena itu, kesehatan mental ibu nifas perlu mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik.

Namun, dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat pelayanan dasar seperti puskesmas, perhatian terhadap aspek psikologis masih relatif terbatas. Pelayanan nifas umumnya lebih berfokus pada pemulihan fisik ibu dan pemantauan kondisi bayi, sementara skrining dan edukasi terkait kesehatan mental belum dilakukan secara optimal. Rendahnya pengetahuan ibu mengenai perubahan psikologi yang normal maupun abnormal selama masa nifas juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini, karena ibu sering kali tidak menyadari tanda-tanda awal gangguan psikologis yang dialami.

Proses adaptasi psikologis yaitu suatu proses yang akan melewati tiga fase penyesuaian ibu terhadap perannya sebagai orang tua, yaitu fase dependen (taking in), fase dependen-mandiri (taking hold) dan fase interdependen (letting go).

2. Risiko Baby Blues

Salah satu gangguan psikologis yang umum terjadi adalah baby blues syndrome, yakni kondisi emosional yang biasanya muncul dalam dua minggu pertama pasca persalinan, ditandai dengan rasa sedih, mudah menangis dan perubahan suasana hati. Apabila tidak ditangani dengan baik, baby blues dapat berkembang menjadi depresi postpartum bahkan postpartum psychosis.

Baby blues adalah tahap awal depresi pasca persalinan yang diakibatkan dari perubahan emosional, fisik dan kelelahan ibu, sehingga sulit dalam menerima kehadiran bayinya. Kejadian Baby blues biasanya terindikasi dalam rentang hari pertama hingga keempat belas pascamelahirkan, hari kelima menjadi estimasi puncak intensitas tertinggi munculnya gejala baby blues.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian baby blues sangat beragam, meliputi aspek biologis, psikologis dan sosial. Dukungan suami menjadi salah satu faktor penting karena berperan dalam membantu ibu beradaptasi dengan kondisi pascapersalinan, baik melalui dukungan emosional, informasional, instrumental maupun appraisal. Selain itu, tingkat pengetahuan ibu mengenai perubahan psikologis setelah melahirkan juga berperan dalam meminimalkan risiko baby blues. Faktor ekonomi turut memengaruhi karena kondisi finansial keluarga dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan ketenangan psikologis ibu.

Konteks budaya juga berpengaruh, khususnya dimasyarakat dengan budaya patriarki, di mana ibu sering kali dituntut untuk mengurus bayi sekaligus pekerjaan rumah tangga. Hal ini menambah beban psikologis yang meningkatkan kerentanan terhadap baby blues. Oleh karena itu, dukungan suami dan keluarga menjadi sangat penting untuk mempercepat pemulihan ibu pada masa nifas.

Baby blues syndrome mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yang ditimbulkan mengakibatkan ibu menjadi pasif dan mengabaikan bayinya sehingga bayi akan mengalami kurang perhatian dan sentuhan dari ibu, selain itu juga akan mengalami gangguan aktifitas pada ibu dan bayi akan sering menangis, sedangkan dampak jangka panjang yaitu menimbulkan gangguan pada perkembangan kognitif, psikologi, neurologi dan motorik.

Baby blues dapat menyebabkan dampak secara langsung serta memiliki risiko jangka panjang terhadap psikologis ibu. Dampak lainnya, baby blues terhadap anak dapat mengganggu perkembangan jasmani, sosial dan mental. Strategi untuk mencegah terjadinya baby blues melalui strategi koping yang berasal dari dukungan suami. Suami yang memberi dukungan secara emosional, dukungan dan reward dapat meminimalisir gejala Baby blues, sedangkan ibu nifas yang tidak mendapatkan dukungan suami lebih rentan menunjukkan gejala baby blues.

3. Depresi Pascapersalinan

Depresi adalah gangguan kemurungan, kesedihan, patah semangat, yang ditandai dengan perasaan gelisah, menurunnya kegiatan dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebab depresi adalah : kehilangan orang yang dicintai mungkin karena kematian, peristiwa traumatis atau stressfull, misalnya mengalami kekerasan, penyakit fisik yang kronis, adanya penyakit mental yang lain, seseorang yang mempunyai orang tu atau saudara kandung yang mengalami depresi akan mengalami peningkatan risiko mengalami depresi.

Depresi postpartum merupakan gangguan psikologis ibu yang ditandai dengan adanya perasaan yang sedih, penurunan suasana hati, hilangnya minat dalam melakukan aktifitas, susah tidur, berat badan turun, suka merasa bersalah atau tidak berguna, mudah lelah dan turunnya konsentrasi dalam beraktifitas hingga timbul rasa ingin bunuh diri atau membunuh bayinya.

Salah satu komplikasi postpartum yang signifikan yaitu kesehatan mental berupa depresi postpartum, karena alasan ini, kehamilan dan persalinan cenderung lebih membuat stres daripada kondisi medis lainnya. Ibu saat hamil dan setelah melahirkan cenderung mengalami stres yang hebat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kondisi ibu yang membatasi aktivitas fisik selama adaptasi psikologis. Kondisi ini dapat bertahan selama ibu hamil dan selama masa nifas yang berlangsung 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan.

Depresi postpartum akan berdampak buruk pada ibu, bayi dan juga mempengaruhi anggota keluarga. Fase penyesuaian psikologis ibu, yang dimulai

pada masa kehamilan hingga persalinan, disertai dengan stres yang cukup besar. Saat ini, ibu mengalami perasaan sedih terkait bayinya, suatu kondisi yang dikenal sebagai postpartum blues dan infant blues. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, depresi juga dapat terjadi selama masa nifas. Ibu dengan depresi postpartum juga mengalami kesulitan melakukan atau menyelesaikan aktivitas.

Dampak pada ibu antara lain ibu menjadi disfungsi, mengganggu orang lain (keluarga dan teman) dan ketidakmampuan ibu untuk merawat dirinya sendiri dan anaknya. Dampak kesehatan ibu tidak dapat mengikuti anjuran kesehatan selama masa nifas dan dikhawatirkan dapat menimbulkan komplikasi nifas bagi ibu. Mempengaruhi bayi yaitu bayi sering menangis, sulit tidur dan gangguan makan. Dampak lain dari depresi pascamelahirkan yaitu pada kemampuan bayi untuk mengembangkan bahasa, kedekatan emosional dengan orang lain dan masalah perilaku. Efek yang paling fatal adalah ibu merasa ingin membunuh diri atau bahkan membunuh anaknya.

Beberapa faktor fisiologis dan psikologis diteliti dapat menjadi penyebab dari depresi *postpartum*. Beberapa hal yang diduga menjadi etiologi depresi *postpartum* antara lain :

- a. Neurologi *postpartum*
- b. Gangguan autoimun
- c. Gangguan tidur dan ritme sirkadian

Ibu primigravida atau ibu yang baru pertama kali melahirkan cenderung lebih rentan mengalami depresi postpartum. Kerentanan ini dapat terjadi karena kesiapan psikologis dalam menghadapi kelahiran bayi dan peran baru sebagai ibu belum terbentuk sekuat ibu multipara. Ibu multipara umumnya memiliki pengalaman sebelumnya dalam menghadapi persalinan dan perawatan bayi, sehingga proses adaptasinya dapat lebih mudah. Selain itu, depresi yang tidak tertangani selama kehamilan dapat meningkatkan risiko depresi postpartum. Karena itu, deteksi dini dan penatalaksanaan depresi antenatal menjadi bagian penting dalam pencegahan depresi pascapersalinan.

F. Simpulan

Masa nifas merupakan periode penting yang dimulai setelah plasenta lahir sampai organ reproduksi ibu kembali mendekati keadaan sebelum hamil. Masa ini umumnya berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Pada periode tersebut, ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis dan psikologis yang membutuhkan pemantauan secara teratur agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.

Perubahan fisiologis pada masa nifas meliputi involusi uterus, pengeluaran lochea, perubahan pada payudara, perubahan sistem reproduksi, sistem perkemihan, dan sistem pencernaan. Perubahan tersebut merupakan proses normal setelah persalinan, tetapi dapat menimbulkan masalah apabila tidak dipantau dengan baik. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi antara lain perdarahan postpartum, infeksi nifas, gangguan berkemih, konstipasi, mastitis, dan gangguan menyusui.

Selain perubahan fisik, ibu nifas juga mengalami perubahan psikologis akibat perubahan hormon, kelelahan, perubahan pola tidur, serta penyesuaian terhadap peran baru sebagai ibu. Kondisi ini dapat memicu gangguan psikologis seperti *baby blues* dan depresi pascapersalinan. Oleh karena itu, dukungan suami, keluarga, dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk membantu ibu beradaptasi secara sehat selama masa nifas.

Perawatan ibu nifas bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, mempercepat pemulihan, mendukung keberhasilan menyusui, memberikan edukasi kesehatan, serta mendeteksi secara dini tanda bahaya dan komplikasi. Pelayanan nifas perlu dilakukan secara komprehensif melalui pemantauan tanda vital, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan lochea, pemeriksaan payudara, edukasi personal hygiene, nutrisi, istirahat, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi, dan keluarga berencana.

Bidan memiliki peran penting dalam memberikan asuhan kebidanan masa nifas secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Melalui kunjungan nifas yang teratur, bidan dapat membantu ibu mengenali tanda bahaya, mencegah komplikasi, memberikan dukungan emosional, serta melakukan rujukan apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dengan perawatan yang tepat, masa nifas dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan mendukung kesehatan ibu serta bayi.

Referensi

- Anggriani, Y., Fara, Y. D., & Pratiwi, F. (2023). Perawatan payudara pada ibu nifas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU)*, 5(1), 79–83.
- Anwar, C., & Safitri, F. (2022). Perawatan masa nifas di rumah sakit bhayangkara banda aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kesehatan*, 4(1), 61–69.
- Apriliani, Y., Kasanah, U., & Dewi, L. P. (2026). EFEKTIVITAS KOMBINASI AROMA TERAPI BERGAMOT DAN HIPNOTERAPI TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA IBU MASA NIFAS DI PUSKESMAS SIDOREJO SUMATERA SELATAN. *Jurnal Penelitian Pendidikan Bidan (Midwife Education Research Journal)*, 4(01), 54–62.
- Astuti, E., & Dinarsi, H. (2022). Analisis proses involusi uterus pada ibu post partum hari ke tiga di praktik bidan mandiri lystiani gresik. *Jurnal Kebidanan*, 11(1), 22–26.
- Azizah, N., & Rosyidah, R. (2019). Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. *Umsida Press*, 1–209.
- Febriati, L. D., Zakiyah, Z., & Ratnaningsih, E. (2023). Hubungan dukungan keluarga dengan adaptasi perubahan psikologi pada ibu nifas. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 14(2), 48–54.
- Isnaini, Q. W., & Nuzuliana, R. (2023). Asuhan kebidanan pada ibu nifas normal. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas' Aisyiyah Yogyakarta*, 1, 308–316.
- Kusuma, F. K. D., & Handayani, D. S. (2026). Studi kasus implementasi pijat laktasi pada Ibu postpartum. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas' Aisyiyah Yogyakarta*, 4, 38–46.
- Lestari, T. R. P. (2020). Pencapaian Status Kesehatan Ibu Dan Bayi Sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu Dan Anak. *Kajian*, 25(1), 75–89.
- Lestari, U. (2016). MASSASE SIMPISIS PUBIS DAN PENGENCANGAN MUSCULUS TRANSVERSUS ABDOMINIS TERHADAP PERCEPATAN PENGELUARAN URIN PADA IBU POST PARTUM SPONTAN. *Jurnal Kebidanan*, 5(1), 35–40.
- Minarni, S., Misrawati, M., & Tampubolon, M. M. (2026). Pengalaman Ibu Dalam Menjalani Perawatan Masa Nifas Budaya Melayu Di Wilayah Kepulauan Riau. *Borneo Nursing Journal (BNJ)*, 8(2), 716–724.
- Murni, D., Harianis, S., Sari, N. I., Ernawati, E., & Oktaviani, Y. (2026). PENGARUH RELAKSASI OTOT PROGRESIF DENGAN PENDAMPINGAN KELUARGA

TERHADAP TINGKAT KENYAMANAN IBU NIFAS. *Jurnal Kesehatan Husada Gemilang*, 9(1), 61–68.

- Novembriany, Y. E. (2021). Implementasi kebijakan nasional kunjungan masa nifas pada praktik mandiri bidan Hj. Norhidayati Banjarmasin. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 6(2), 121–126.
- Nuari, I. A. W., Yuliani, I., & Kristiarini, J. J. (2026). Determinasi Faktor Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas Di Kabupaten Bantul 2025. *INVOLUSI: Jurnal Ilmu Kebidanan*, 16(1), 31–38.
- Pujiastuti, W., Yuniyanti, B., & Masini, M. (2021). Efektivitas Senam Nifas Dan Latihan Kegel Dalam Mencegah Inkontinensia Urin Masa Nifas. *Bhamada: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)*, 12(1), 78–82.
- Putri, E. R. T. (2026). Hubungan Antara Dukungan Suami Terhadap Kejadian Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Grogol Kabupaten Kediri. *Journal of Health Innovation and Practice*, 1(1), 10–20.
- Qardhawijayanti, S., Pratiwi, W. R., & Syahriani, S. (2026). PSYCHOEDUCATION TENTANG ADAPTASI PSIKOLOGIS MASA NIFAS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS AMPARITA. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(5), 2133–2138.
- Qiftiyah, M., & Ulya, K. (2018). Studi Diskriptif Tentang Mobilisasi Dini Terhadap Pengeluaran Lochea Pada Ibu Nifas Hari Ke-4. *Jurnal Midpro*, 10(1), 12–17.
- Qomariah, S., Herlina, S., & Sartika, W. (2024). Pengaruh Pemakaian Bengkung Terhadap Involusi Uterus Pada Ibu Nifas Diwilayah Kerja Puskesmas Siak Hulu Ii. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 8(1), 28–37.
- Ramadanti, F., Uberty, A., & Delpia, Y. V. (2026). ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY. I DI PMB NINDYA UTAMI A. Md. Keb KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025. *Jurnal Asuhan Kebidanan Komprehensif*, 2(1), 167–175.
- Rosdiana, R., Anggraeni, S., & Jamila, J. (2022). Pengaruh senam nifas dan mobilisasi dini terhadap involusi uterus pada ibu post partum. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 13(1), 98–105.
- Solama, W., Rivanica, R., Effendi, E., & Safitri, S. (2023). Analisis karakteristik ibu nifas tentang depresi post partum. *Jurnal'Aisyiyah Medika*, 8(1).
- Syahida, A., & Safarna, N. (2023). Edukasi kesehatan tentang pentingnya melakukan breast care pada masa nifas di Desa Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darussalam*, 2(1), 21–25.
- Ulfiana, E., Hardjanti, T. S., & Ruspita, M. (2022). Family Empowerment In Postpartum Care: Pemberdayaan Keluarga Dalam Perawatan Nifas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan*, 8(3), 287–294.

- Victoria, S. I. V. S. I., & Yanti, J. S. Y. J. S. (2021). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan Pelaksanaan Senam Nifas. *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)*, 1(1), 45–55.
- Widyastuti, H., Negoro, D. A., Kustiawan, U., & Hilmy, M. R. (2026). Analisa Faktor Eksternal dan Perencanaan Pemasaran PT Nuno Care Post Partum Depression Pusat Perawatan Pasca Melahirkan. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 12–23.
- Wojcieszek, A. M., Bonet, M., Portela, A., Althabe, F., Bahl, R., Chowdhary, N., Dua, T., Edmond, K., Gupta, S., & Rogers, L. M. (2023). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience: strengthening the maternal and newborn care continuum. *BMJ Global Health*, 8(Suppl 2), e010992.
- Yanti, R. D. (2022). EFEKTIVITAS PEMBERIAN SNACK BAR TAPE KETAN HITAM TERHADAP POLA DEFEKASI IBU NIFAS. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 6(3), 10–16.
- Zagoto, S. (2020). Gambaran Pengetahuan ibu nifas tentang adaptasi psikologis pada masa nifas di klinik pratama afiyah pekanbaru tahun 2019. *Al-Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, 9(2), 108–113.



CHAPTER 5



DUKUNGAN PEMBERIAN ASI DAN TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR

Ima Candra Kusuma, S.ST., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. ASI mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan bayi selama enam bulan pertama kehidupan serta memiliki kandungan antibodi yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi dan dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI yang adekuat. (World Health Organization WHO, 2026)

Keberhasilan pemberian ASI tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik ibu, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan yang diterima ibu dari lingkungan sekitar. Dukungan tersebut dapat berasal dari suami, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, maupun masyarakat. Ibu yang mendapatkan dukungan yang baik cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menyusui dan lebih mampu mempertahankan pemberian ASI eksklusif dibandingkan ibu yang kurang mendapatkan dukungan. (Luh et al., 2021)

Dukungan pemberian ASI menjadi penting karena masih banyak ibu yang mengalami kesulitan dalam menyusui, seperti puting lecet, ASI kurang lancar, rasa nyeri, kurangnya pengetahuan tentang teknik menyusui, hingga tekanan sosial untuk memberikan susu formula. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai berbagai bentuk dukungan yang dapat membantu keberhasilan menyusui. (Wibowo, 2016)

Keterampilan teknik menyusui merupakan kompetensi praktis yang perlu dikuasai oleh ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan. Dengan keterampilan tersebut, ibu diharapkan memiliki kemauan, kemampuan, dan kepercayaan diri untuk menyusui bayinya secara benar dan efektif. (Naintina Lisnawati et al., 2023)

Pada dasarnya, setiap perempuan memiliki potensi untuk menyusui bayinya. Namun demikian, tidak semua perempuan mampu memahami dan menghayati peran tersebut secara optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, adanya persepsi yang kurang tepat mengenai fungsi payudara dan proses menyusui, serta kurangnya pemahaman terhadap peran ibu dan manfaat

pemberian ASI. Akibatnya, sebagian ibu cenderung memilih susu formula sebagai pengganti, padahal hingga saat ini manfaat ASI belum dapat ditandingi oleh produk apapun. (Naintina Lisnawati et al., 2023)

ASI memiliki manfaat yang sangat luas, baik bagi bayi, ibu, keluarga, maupun negara. Bagi bayi, ASI merupakan sumber nutrisi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhannya, mengandung zat protektif, memberikan efek psikologis positif, mendukung pertumbuhan optimal, serta menurunkan risiko terjadinya karies gigi dan maloklusi. Bagi ibu, pemberian ASI berperan dalam mencegah perdarahan pasca persalinan, menurunkan risiko kanker payudara, membantu pengaturan jarak kehamilan, serta memberikan kepuasan emosional berupa rasa bangga dan merasa dibutuhkan. Dari sisi keluarga, ASI memberikan keuntungan secara ekonomi, psikologis, serta kemudahan dalam praktik pemberian makan bayi. Sementara itu, bagi negara, peningkatan praktik menyusui dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, mengurangi beban pembiayaan layanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. (Cathryne et al., 2023)

Pemberian ASI tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan nutrisi (hak asuh), tetapi juga mencakup pemberian kasih sayang, rasa aman, dan kenyamanan (hak asih), serta stimulasi perkembangan melalui interaksi seperti berbicara atau bernyanyi (hak asah) yang berperan dalam perkembangan kognitif dan keterampilan anak.

ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI saja sejak lahir sampai sekitar 6 bulan. Selama itu bayi diharapkan tidak mendapat tambahan cairan apapun (susu formula, madu, teh, air jeruk, air putih) dan makanan tambahan apapun (pisang, biskuit, bubur susu). Setelah usia enam bulan, bayi mulai membutuhkan makanan pendamping, namun pemberian ASI tetap dianjurkan untuk dilanjutkan hingga usia dua tahun. (Nerawati et al., 2023)

Keberhasilan menyusui sangat ditentukan oleh ketepatan posisi dan perlekatan bayi saat menyusui. Posisi dan perlekatan yang benar memungkinkan bayi mengisap areola, bukan hanya puting, sehingga aliran ASI menjadi lebih lancar dan mencegah terjadinya lecet pada puting. Setelah proses menyusui selesai, bayi perlu disendawakan untuk membantu pengeluaran udara dari lambung serta memastikan sisa ASI di saluran cerna bagian atas masuk ke lambung, sehingga dapat mencegah terjadinya muntah. Seluruh aspek tersebut merupakan bagian penting yang dilatihkan dalam keterampilan teknik menyusui. (Mamuroh et al., 2024)

B. Dukungan Pemberian ASI

Dukungan sosial merupakan suatu kondisi yang memberikan manfaat bagi individu, yang diperoleh dari orang-orang terpercaya di sekitarnya, sehingga individu merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Dalam konteks keluarga, dukungan ini merujuk pada ketersediaan bantuan yang dapat diakses oleh anggota keluarga, di mana individu meyakini bahwa anggota keluarga yang suportif akan selalu siap memberikan pertolongan ketika dibutuhkan. Dukungan keluarga dapat bersumber dari internal, seperti pasangan (suami/istri) dan saudara kandung, maupun dari eksternal, yaitu lingkungan di luar keluarga inti (Luh et al., 2021)

Secara lebih luas, dukungan sosial dapat diartikan sebagai bentuk bantuan atau dorongan yang diberikan oleh individu maupun kelompok, termasuk keluarga, teman, pasangan, atau lingkungan sosial lainnya. Bagi ibu menyusui, dukungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Dukungan yang memadai akan memengaruhi kemampuan ibu dalam membentuk perilaku positif terkait menyusui. Oleh karena itu, ibu menyusui sangat memerlukan dukungan optimal dari keluarga, terutama untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dalam menyusui bayinya. (Snyder et al., 2021)

Dukungan pemberian ASI adalah segala bentuk bantuan yang diberikan kepada ibu menyusui untuk meningkatkan keberhasilan dalam memberikan ASI kepada bayinya. Dukungan ini dapat berupa dukungan emosional, informasional, instrumental, maupun penghargaan.

Menurut teori dukungan sosial, seseorang yang memperoleh dukungan dari lingkungan akan merasa lebih dihargai, diperhatikan, dan memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi masalah. Dalam konteks menyusui, dukungan sosial membantu ibu mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan mempertahankan motivasi untuk memberikan ASI secara optimal. (Wibowo, 2016)

Keberhasilan menyusui dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan ibu tentang ASI.
2. Kondisi kesehatan ibu dan bayi.
3. Teknik menyusui yang benar.
4. Dukungan keluarga dan lingkungan.
5. Kebijakan fasilitas kesehatan dan tempat kerja.

Kurangnya dukungan dapat menyebabkan ibu menghentikan pemberian ASI lebih awal. Sebaliknya, ibu yang memperoleh dukungan positif akan lebih termotivasi untuk menyusui secara eksklusif. (Luh et al., 2021)

Bentuk dukungan sosial yang dapat diberikan kepada ibu menyusui meliputi beberapa aspek, antara lain : (Castro & Johnsson, 2025)

1. Dukungan Informasional, yaitu dukungan berupa informasi, nasihat atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh ibu untuk tetap menyusui bayinya. Beberapa informasi penting yang perlu diberikan kepada ibu menyusui adalah pentingnya ASI bagi bayi dan Ibu serta teknik menyusui yang benar. (Wibowo, 2016)

Informasi yang perlu diberikan meliputi:

- a. Manfaat ASI bagi ibu dan bayi.
- b. Teknik posisi dan pelekatan yang benar.
- c. Cara memerah dan menyimpan ASI.
- d. Tanda bayi cukup ASI.
- e. Penanganan masalah menyusui.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi sejak masa kehamilan hingga postpartum. Pendidikan kesehatan yang baik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam menyusui. (Naintina Lisnawati et al., 2023)

2. Dukungan emosional, yaitu dukungan yang berupa perhatian, motivasi, kasih sayang, serta upaya menciptakan suasana yang nyaman dan bebas dari konflik maupun stres. Ibu menyusui perlu mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan untuk meningkatkan produksi ASInya. Dengan kondisi lingkungan dan orang-orang sekitar yang memberikan kenyamanan maka ibu mampu mempertahankan pemberian ASI.

Bentuk dukungan emosional meliputi:

- a. Memberikan semangat kepada ibu untuk menyusui.
- b. Mendengarkan keluhan ibu tanpa menghakimi.
- c. Memberikan rasa nyaman dan tenang.
- d. Mengurangi tekanan psikologis ibu.

Ibu yang merasa dicintai dan didukung akan lebih rileks sehingga hormon oksitosin dapat bekerja optimal dalam pengeluaran ASI. Kondisi stres dan kecemasan dapat menghambat refleks pengeluaran ASI sehingga dukungan emosional sangat berperan terhadap kelancaran menyusui. (Ernawati & Vewawati, 2014)

Selain itu, terdapat pula bentuk dukungan lain yang tidak kalah penting yaitu dukungan dan cinta kasih dari keluarga membantu ibu sukses dalam menyusui:

1. Dukungan penghargaan, yaitu orang-orang disekitar ibu meningkatkan harga diri ibu karena mampu menyusui. Misalnya dengan memberikan apresiasi atau kebanggaan atas kemampuannya menyusui. (Priscilla & Afiyanti, 2021)

Contoh:

- a. Memberikan apresiasi kepada ibu yang berhasil menyusui.
- b. Tidak menyalahkan ibu ketika mengalami kesulitan.

c. Memberikan motivasi positif.

Dukungan penghargaan dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu dan membuat ibu merasa usahanya dihargai.

2. Dukungan instrumental, yaitu dukungan material atau fisik seperti penyediaan makanan bergizi, membantu pekerjaan rumah tangga, maupun memberikan perawatan seperti pijatan untuk meningkatkan kenyamanan ibu.

Contohnya:

- a. Membantu pekerjaan rumah tangga.
- b. Menyiapkan makanan bergizi bagi ibu menyusui.
- c. Membantu merawat bayi.
- d. Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja.
- e. Memberikan waktu istirahat kepada ibu.

Dukungan ini membantu mengurangi beban fisik ibu sehingga ibu dapat lebih fokus dalam menyusui bayinya.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk dukungan tersebut sangat dibutuhkan oleh ibu selama masa menyusui. Kehadiran dukungan sosial yang optimal dapat meningkatkan keberhasilan ibu dalam memberikan ASI eksklusif hingga usia enam bulan. Dengan demikian, keberhasilan menyusui sangat dipengaruhi oleh dukungan yang kuat, terutama dari suami dan keluarga sebagai lingkungan terdekat ibu. (Snyder et al., 2021)

C. Peran Keluarga dalam Dukungan Pemberian ASI

1. Peran Suami

Suami merupakan orang terdekat yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan menyusui. Dukungan suami dapat berupa dukungan emosional maupun bantuan langsung dalam merawat bayi. (Ogbo et al., 2020)

Beberapa bentuk dukungan suami:

- a. Memberikan motivasi kepada ibu.
- b. Membantu mengurus bayi.
- c. Membantu pekerjaan rumah.
- d. Mendampingi ibu saat kontrol kesehatan.
- e. Memberikan dukungan ketika ibu merasa lelah.

Dukungan suami merupakan salah satu faktor penting yang meningkatkan peluang keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Ibu yang merasa didampingi, dibantu, dan dihargai umumnya lebih percaya diri dalam mempertahankan praktik menyusui. (Zhou et al., 2024)

2. Peran Keluarga Besar

Keluarga besar seperti ibu kandung, mertua, dan saudara juga berperan terhadap keberhasilan menyusui. Dukungan keluarga dapat memperkuat keyakinan ibu dalam memberikan ASI. (Negin et al., 2016)

Namun demikian, keluarga juga dapat menjadi penghambat apabila memberikan informasi yang tidak tepat, misalnya menyarankan pemberian makanan tambahan terlalu dini. Oleh karena itu, edukasi mengenai ASI perlu diberikan tidak hanya kepada ibu tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga. (Naintina Lisnawati et al., 2023)

3. Peran Tenaga Kesehatan dalam Dukungan ASI

Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung keberhasilan menyusui. Dukungan dapat dilakukan sejak masa antenatal, persalinan, hingga masa nifas. (Ojantausta et al., 2023)

Peran tenaga kesehatan meliputi:

- a. Memberikan konseling menyusui.
- b. Mengajarkan teknik menyusui yang benar.
- c. Membantu ibu mengatasi masalah laktasi.
- d. Mendukung inisiasi menyusui dini (IMD).
- e. Mendorong rawat gabung ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan yang mendukung menyusui dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan perlu menerapkan kebijakan ramah ASI untuk mendukung ibu menyusui. (Sanofarizka et al., 2022)

4. Hambatan dalam Dukungan Pemberian ASI

Beberapa hambatan yang sering ditemui dalam pemberian ASI antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan ibu.
- b. Pengaruh promosi susu formula.
- c. Dukungan keluarga yang rendah.
- d. Ibu bekerja.
- e. Masalah fisik seperti puting lecet dan bendungan ASI.
- f. Faktor budaya dan mitos.

Hambatan tersebut dapat menyebabkan penghentian ASI eksklusif lebih awal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu ibu mengatasi kendala tersebut. (Salem et al., 2021)

5. Upaya Meningkatkan Dukungan Pemberian ASI

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pemberian ASI antara lain:

- a. Edukasi menyusui sejak masa kehamilan.
- b. Pembentukan kelompok pendukung ASI.

- c. Penyediaan ruang laktasi di tempat kerja.
- d. Pelatihan tenaga kesehatan tentang konseling laktasi.
- e. Keterlibatan suami dan keluarga dalam edukasi ASI.
- f. Penguatan kebijakan pemerintah tentang perlindungan ibu menyusui.

Dukungan yang komprehensif dari keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, dan masyarakat akan membantu ibu memberikan ASI secara optimal.

Dukungan pemberian ASI merupakan faktor penting dalam keberhasilan menyusui. Dukungan dapat berupa dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penghargaan. Peran suami, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membantu ibu mempertahankan pemberian ASI eksklusif. (Pakilaran et al., 2022)

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan menyusui serta dukungan lingkungan yang positif dapat membantu ibu merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menyusui. Dengan adanya dukungan yang optimal, diharapkan cakupan ASI eksklusif dapat meningkat sehingga kesehatan ibu dan bayi menjadi lebih baik.

D. Posisi menyusui yang benar

Posisi menyusui yang benar adalah bagian penting dari proses menyusui. Agar pemberian ASI lebih optimal, sebaiknya perhatikan posisi menyusui yang tepat. Menerapkan posisi menyusui yang benar bukan hanya sekadar membantu bayi agar lebih mudah saat menyusu. Di sisi lain, menemukan posisi yang nyaman juga dapat mencegah mengalami masalah ibu menyusui, pegal, dan nyeri punggung. Bahkan, posisi yang tepat bisa semakin memudahkan agar produksi ASI bisa semakin banyak. (Wakgari et al., 2024)

Teknik menyusui akan berperan terhadap kemampuan ibu dalam memberikan ASI pada bayinya, teknik menyusui diantaranya adalah memberikan posisi menyusui, perlekatan mulut bayi pada payudara yang tepat, sehingga bayi dapat dengan mudah mengisap puting susu ibu, dan cara ibu memegang bayi saat menyusui. (Wakgari et al., 2024)

Posisi ibu dan bayi yang benar saat menyusui dapat dicapai bila bayi menyusui dengan tenang dan badannya menempel betul pada ibu. Menyusui yang baik dan benar adalah ketika mulut dan dagu bayi menempel betul pada payudara dan mulut bayi membuka lebar sehingga sebagian besar areola tertutup mulut bayi. Dengan posisi itu, bayi akan leluasa mengisap ASI pelan-pelan tapi kuat dan ibu pun tidak merasa kesakitan. Sebaiknya posisi puting dan lengan bayi berada pada satu garis lurus. (Jafrizal et al., 2024)

Posisi badan ibu dan bayi pada saat menyusui yang perlu diperhatikan adalah:

1. Posisikan kepala bayi agar terjatuh di lengan bawah ibu, pegang bagian belakang kepala dan bahu bayi oleh telapak tangan ibu, sanggah seluruh punggung bayi dengan baik
2. Posisikan badan bayi hingga telinga membentuk garis lurus dengan lengan dan leher bayi, untuk menghadap pada badan ibu, dan dekap bayi di bawah payudara ibu, sehingga badan bayi dapat menempel pada dada ibu
3. Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu, sehingga muka bayi menghadap ke payudara dan hidung bayi menjauhi payudara
4. Posisikan badan dan lengan ibu untuk tetap relaks tidak tegang, bersikap alami serta lakukan kontak mata antara ibu pada bayinya

Posisi menyusui yang direkomendasikan agar menyusui dengan baik dan bayi tidak tersedak antara lain : (Wang et al., 2021)

1. Posisi Menggendong

Posisi klasik yang banyak dilakukan oleh ibu menyusui. Tapi, posisi ini memang yang paling mudah dilakukan.

- a. Gendong bayi dengan kepala bersandar pada lekuk siku tangan ibu
- b. Pegang bokong bayi dengan telapak tangan berlawanan.
- c. Arahkan badan bayi hingga wajah, perut dan lututnya menempel pada dada dan perut ibu
- d. Arahkan tangan bayi yang berada di atas merangkul badan atau payudara ibu.



Gambar 5. 1 Posisi Menggendong (Sari et al., 2022)

2. Posisi Gendong Silang

Hampir sama seperti posisi menggendong, posisi menyusui ini menggunakan teknik menggendong silang atau menggunakan tangan yang berlawanan dengan payudara yang digunakan untuk menyusui. Teknik menyusui ini bagus untuk bayi yang kesulitan menempelkan mulutnya ke puting payudara.

- a. Pegang kepala bayi dengan menggunakan tangan yang berlawanan dengan posisi payudara. Misal, jika menggunakan payudara kiri, maka ibu harus

menggunakan tangan kanan, begitu juga sebaliknya.

- b. Arahkan badan bayi hingga kepala, dada dan perutnya menghadap ke dada dan perut ibu.
- c. Arahkan mulutnya ke puting susu dengan ibu jari.
- d. Tangan ibu yang tidak digunakan untuk memegang kepala, bisa diletakkan di belakang kepala atau bawah telinga bayi. Semua dukungan ini merupakan hal yang dibutuhkan oleh Ibu pada saat ibu menyusui bayinya.



Gambar 5. 2 Posisi Gendong Silang (Sari et al., 2022)

3. Posisi Menyangga Kepala

Posisi ini sangat bagus untuk ibu yang melahirkan dengan operasi caesar dan menghindari bayi menempel pada perut ibu. Bagus juga untuk bayi dengan berat badan kecil, bayi kembar, atau payudara yang terlalu besar.

- a. Posisikan bayi diantara siku tangan ibu
- b. Gunakan tangan kanan untuk memegang kepala bayi jika ibu menggunakan payudara sebelah kanan untuk menyusui, begitu pula sebaliknya.
- c. Arahkan mulut bayi ke puting susu dimulai dari dagu, agar bayi tidak mudah menolak dengan posisi ini.



Gambar 5. 3 Posisi Menyangga Kepala (Sari et al., 2022)

4. Posisi Bersandar

Posisi yang umumnya dilakukan untuk menyusui bayi baru lahir. Ini adalah cara menyusui yang bagus untuk bersantai karena bisa meluruskan kaki, apalagi caranya juga cukup mudah. Posisi ini tepat untuk ibu yang memiliki payudara kecil, atau menyusui bayi yang memiliki perut yang sensitif.

- a. Sandarkan punggung ibu dengan bantal.
- b. Posisikan perut bayi di bawah dada, dan kepala bayi sejajar dengan payudara.
- c. Pastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk.



Gambar 5. 4 Posisi Bersandar (Sari et al., 2022)

5. Posisi Tidur Bersisian

Ibu bisa menyusui sambil berbaring. Ini adalah posisi yang tepat jika bayi bangun di malam hari meminta menyusu.

- a. Berbaring di salah satu sisi menghadap bayi.
- b. Arahkan bayi menghadap tubuh Ibu secara berlawanan.
- c. Dorong sedikit punggung bayi agar bibirnya mendekati puting payudara.
- d. Menyusui dengan posisi ini lumayan pegal, posisi bayi juga dalam kondisi miring. Pastikan bayi tidak tertidur saat menyusui.



Gambar 5. 5 Posisi Tidur Bersisian (Sari et al., 2022)

E. Teknik Menyusui yang Benar

Teknik menyusui yang benar yaitu cara ibu memberikan ASI kepada anaknya dengan memperhatikan perlekatan dan posisi yang benar, sehingga puting susu ibu tidak lecet atau luka saat menyusui dan bayi menyusui dengan nyaman dan tidak gumoh. (Mayasari et al., n.d.)

Teknik menyusui yang benar yang yaitu :

1. Membersihkan puting susu dan kulit sekitarnya (areola) dengan kapas yang sebelumnya telah dibasahi dengan air matang (jika kotor sekali gunakan handuk kecil).
2. Mengeluarkan ASI sedikit dan mengoleskannya pada puting susu dan areola sekitarnya
3. Mendekatkan bayi dan meletakkan menghadap perut ibu pada payudara sambil kepalanya disokong oleh tangan dengan posisi perlekatan yang benar.
4. Memegang payudara diantara ibu jari dan keempat jari.



Gambar 5. 6 Memegang Payudara seperti huruf C (Sari et al., 2022)

5. Memberikan rangsangan pada bayi untuk membuka mulut dengan cara menyentuh pipi bayi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut bayi.
6. Memasukkan puting susu dan sebagian besar areola ke dalam mulut bayi dan melepaskan tangan yang menyangga payudara setelah bayi mulai menghisap
7. Menyusui bayi sampai payudara terasa kosong dan perhatikan apakah ibu sudah menyusui dengan benar.
8. Melepaskan isapan bayi dengan memasukkan jari kelingking ke mulut bayi melalui sudut mulut atau menekan dagu bayi ke bawah.
9. Mengeluarkan ASI sedikit setelah menyusui dan mengoleskannya pada puting susu dan areola sekitarnya serta membiarkan kering dengan sendirinya
10. Bila bayi masih mau menyusui maka berikan ASI pada payudara sebelahnya dan lakukan seperti kegiatan di atas
11. Menggendong bayi tegak bersandar pada bahu ibu kemudian menepuk punggung bayi perlahan-lahan sampai bayi bersendawa.

12. Mengajarkan ibu untuk membiasakan diri agar selalu menyusui dengan benar dan susukanlah bayi untuk berikutnya pada payudara yang pada waktu sebelumnya terakhir kali dihisap oleh bayi

F. Perlekatan Menyusui

Menyusui merupakan proses alamiah yang memberikan manfaat besar bagi ibu dan bayi. Air Susu Ibu (ASI) mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Keberhasilan menyusui tidak hanya dipengaruhi oleh produksi ASI, tetapi juga dipengaruhi oleh teknik menyusui yang benar, terutama perlekatan (*latch on*) antara mulut bayi dan payudara ibu. (Murovaldez et al., 2023)

Perlekatan menyusui yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai masalah seperti puting lecet, bendungan ASI, mastitis, bayi tidak puas menyusu, hingga kegagalan pemberian ASI eksklusif. Sebaliknya, perlekatan yang benar dapat meningkatkan efektivitas pengeluaran ASI dan memberikan kenyamanan bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai teknik perlekatan menyusui sangat penting dimiliki oleh ibu, keluarga, maupun tenaga kesehatan. (Mayasari et al., n.d.)

Dengan demikian, teknik menyusui yang benar merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan ASI eksklusif dan pencegahan masalah laktasi. (Wakgari et al., 2024)

Perlekatan menyusui adalah proses melekatnya mulut bayi pada payudara ibu dengan posisi yang tepat sehingga bayi mampu mengisap ASI secara efektif. Pada perlekatan yang benar, bayi tidak hanya mengisap puting susu, tetapi juga sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. (Dixit & Thakur, 2023)

Perlekatan yang tepat memungkinkan lidah bayi menekan sinus laktiferus sehingga ASI dapat keluar dengan optimal. Teknik ini membantu bayi memperoleh cukup ASI dan mencegah trauma pada puting susu ibu (WHO, 2023).

1. Anatomi dan Fisiologi Payudara dalam Menyusui

Payudara adalah organ yang memiliki peranan penting dalam proses laktasi, yaitu menghasilkan dan menyalurkan air susu ibu (ASI). Secara anatomi, payudara tersusun atas alveoli yang berfungsi memproduksi ASI, duktus laktiferus sebagai saluran pengaliran ASI, serta areola dan puting susu yang membantu proses menyusui. Produksi ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin, sedangkan proses pengeluaran ASI dikendalikan oleh hormon oksitosin. Rangsangan hisapan bayi saat menyusu akan memicu pelepasan kedua hormon tersebut sehingga produksi dan pengeluaran ASI dapat berlangsung secara optimal. Frekuensi menyusui

yang sering disertai teknik perlekatan yang tepat akan membantu meningkatkan produksi ASI. Sebaliknya, perlekatan yang kurang benar dapat menyebabkan pengosongan payudara tidak maksimal, sehingga berisiko menimbulkan bendungan ASI dan menurunkan produksi ASI.(Katulski et al., 2024)

2. Tujuan Perlekatan Menyusui yang Benar

Perlekatan menyusui yang benar bertujuan untuk membantu bayi mendapatkan ASI secara optimal serta menjaga kenyamanan ibu selama menyusui. Teknik perlekatan yang tepat dapat memperlancar pengeluaran ASI, meningkatkan produksi ASI, dan mencegah terjadinya puting lecet. Selain itu, perlekatan yang baik juga membuat bayi merasa nyaman dan puas setelah menyusui sehingga mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Menurut UNICEF, posisi dan perlekatan yang tepat membantu bayi mengisap ASI lebih efektif dan mengurangi risiko masalah menyusui pada ibu. (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2026)

3. Prinsip Dasar Perlekatan Menyusui

Dalam melakukan perlekatan menyusui terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Tubuh bayi harus menghadap tubuh ibu sehingga bayi tidak perlu memutar kepala saat menyusui. Kepala, leher, dan badan bayi harus berada dalam satu garis lurus agar bayi dapat menelan ASI dengan mudah. Bayi juga harus berada dekat dengan tubuh ibu dan seluruh tubuhnya ditopang dengan baik. Saat menyusui, mulut bayi harus terbuka lebar dengan dagu menempel pada payudara ibu. Sebagian besar areola, terutama bagian bawah areola, harus masuk ke dalam mulut bayi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bayi melekat dengan benar pada payudara ibu. (Jafrizal et al., 2024)

4. Tanda-Tanda Perlekatan Menyusui yang Benar

Perlekatan menyusui yang benar dapat dinilai dari keadaan ibu dan bayi selama kegiatan menyusui berlangsung. Pada bayi, tanda perlekatan yang baik ditunjukkan dengan mulut yang terbuka lebar, bibir bawah mengarah ke luar, dagu menempel pada payudara, serta terdengar suara menelan yang pelan dan teratur. Bayi biasanya terlihat tenang dan merasa puas setelah selesai menyusui. Pada ibu, perlekatan yang tepat ditandai dengan tidak adanya rasa nyeri saat menyusui, puting susu tetap dalam kondisi baik tanpa lecet, serta payudara terasa lebih kosong atau ringan setelah bayi menyusui. Selain itu, ibu akan merasa lebih nyaman dan rileks selama proses menyusui berlangsung.(Yunita et al., 2025)

5. Tanda-Tanda Perlekatan Menyusui yang Salah

Perlekatan menyusui yang kurang tepat dapat menyebabkan berbagai dampak pada ibu maupun bayi. Bayi yang menyusui dengan posisi perlekatan yang salah umumnya hanya mengisap bagian puting susu, sehingga jumlah ASI

yang diperoleh menjadi tidak optimal. Kondisi ini ditandai dengan mulut bayi yang tidak terbuka lebar serta bayi yang sering melepaskan payudara saat menyusui. Pada ibu, perlekatan yang tidak benar dapat menimbulkan puting susu lecet, nyeri pada payudara, hingga bendungan ASI akibat pengosongan payudara yang tidak maksimal. Selain itu, bayi cenderung menjadi lebih rewel karena kebutuhan ASI belum terpenuhi dengan baik. Jika keadaan ini tidak segera diatasi, maka dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif. (Sari et al., 2022)

6. Posisi Menyusui

Terdapat beberapa posisi menyusui yang dapat digunakan ibu sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Posisi *cradle hold* merupakan posisi yang paling umum digunakan, yaitu kepala bayi berada pada lekukan siku ibu. Posisi *cross cradle hold* dilakukan dengan tangan yang berlawanan menopang kepala bayi dan sering digunakan pada bayi baru lahir. Posisi *football hold* menempatkan bayi di samping tubuh ibu seperti memegang bola dan cocok digunakan pada ibu pasca operasi sesar. Selain itu, terdapat posisi *side lying* yaitu ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan sehingga nyaman digunakan saat malam hari atau ketika ibu membutuhkan istirahat. (Wang et al., 2021)

7. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Perlekatan Menyusui

Terdapat berbagai macam posisi menyusui yang dapat dipilih ibu sesuai dengan tingkat kenyamanan dan kondisi masing-masing. Salah satu posisi yang paling sering digunakan adalah *cradle hold*, yaitu posisi ketika kepala bayi berada pada lekukan siku ibu saat menyusui. Selain itu, terdapat posisi *cross cradle hold*, di mana kepala bayi disangga menggunakan tangan yang berlawanan, dan posisi ini sering diterapkan pada bayi baru lahir untuk membantu mendapatkan perlekatan yang lebih baik. Posisi *football hold* dilakukan dengan menempatkan bayi di samping tubuh ibu menyerupai cara memegang bola, sehingga sesuai digunakan oleh ibu setelah operasi sesar. Di samping itu, ada pula posisi *side lying*, yaitu posisi ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan, yang memberikan kenyamanan terutama saat malam hari atau ketika ibu memerlukan waktu istirahat selama menyusui. (Jafrizal et al., 2024) (Sari et al., 2022)

8. Masalah yang Sering Terjadi dalam Perlekatan Menyusui

Masalah yang sering terjadi akibat perlekatan menyusui yang salah antara lain puting lecet, bendungan ASI, mastitis, dan bayi kurang mendapatkan ASI. Puting lecet biasanya terjadi karena bayi hanya mengisap puting tanpa memasukkan areola ke dalam mulut. Bendungan ASI terjadi akibat payudara tidak dikosongkan secara optimal sehingga payudara menjadi bengkak dan nyeri. Jika bendungan ASI tidak ditangani dengan baik, maka dapat berkembang menjadi mastitis atau infeksi payudara. Selain itu, bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI

dapat mengalami penurunan berat badan dan menjadi lebih rewel. (Scime et al., 2023)

9. Peran Bidan dalam Mendukung Perlekatan Menyusui

Bidan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan menyusui melalui pendidikan kesehatan, konseling, dan pendampingan ibu menyusui. Bidan dapat memberikan edukasi mengenai posisi dan teknik perlekatan menyusui yang benar sejak masa kehamilan. Selain itu, bidan juga berperan dalam membantu ibu mengatasi masalah menyusui serta memberikan dukungan emosional agar ibu lebih percaya diri dalam memberikan ASI. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dalam mendukung program ASI eksklusif melalui edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan. (Nuzula, 2024)

Perlekatan saat menyusui yang benar akan menghindarkan bayi dari rasa tidak puas dan ingin menyusui lebih sering dan lama. Selain itu, perlekatan yang benar mencegah puting susu lecet dan nyeri serta menghindarkan risiko payudara ibu membengkak. (RM, 2020)

Ciri Perlekatan yang baik :

- Areola / bagian hitam payudara di bagian atas mulut bayi lebih banyak terlihat
- Mulut bayi terbuka lebar
- Bibir bawah bayi tampak terlipat keluar (dower)
- Dagu menyentuh atau hampir menyentuh payudara
- Pipi bayi menggembung



Gambar 5. 7 Perlekatan Menyusui (Sari et al., 2022)

Cara Melakukan Perlekatan Menyusui yang Benar

- Setelah bayi berada pada posisi menyusui yang tepat, ibu dapat memegang payudara menggunakan tangan yang tidak digunakan untuk menopang bayi.

2. Letakkan ibu jari di bagian atas puting dan areola, yaitu pada area yang nantinya berdekatan dengan hidung bayi, sedangkan jari telunjuk ditempatkan di bagian bawah payudara pada area yang akan bersentuhan dengan dagu bayi.
3. Pegang dan tekan payudara secara perlahan hingga membentuk huruf C agar lebih mudah masuk ke mulut bayi.
4. Dekatkan tubuh bayi ke arah payudara, kemudian berikan rangsangan lembut pada bibir bayi agar mulut terbuka lebar seperti gerakan menguap sebelum mulai menyusui.



Gambar 5. 8 Cara Melakukan Pelekatan Menyusui yang benar (Sari et al., 2022)

Pelekatan menyusui dapat dinilai baik apabila dagu bayi menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, dan terlihat gerakan mengisap serta menelan secara teratur. Selain itu, bagian areola yang tampak di atas mulut bayi biasanya lebih banyak dibandingkan bagian bawah. Pada kondisi pelekatan yang benar, ibu juga tidak merasakan nyeri atau rasa sakit pada puting susu selama proses menyusui berlangsung.

Referensi

- Castro, B., & Johnsson, A. (2025). *A Qualitative Survey of Mothers ' Experiences of Breastfeeding Support at a Family Centre*. 1–10. <https://doi.org/10.1002/nop2.70152>
- Cathryne, J., Pangemanan, A., Nova, F., Judheliena, Hutapea, & Delima, A. (2023). *IBU BAHAGIA GENERASI SEHAT: ASI EKSKLUSIF*. 6, 3543–3553. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i9.10855>
- Dixit, D., & Thakur, N. (2023). " Breastfeeding Techniques " Assessment, Knowledge, and Intervening Proper Techniques. 12(5), 2022–2023. <https://doi.org/10.21275/SR23425171804>
- Ernawati, H., & Verawati, M. (2014). KESEHATAN IBU DAN BAYI PADA PERNIKAHAN DINI. *MEDIA ILMU KESEHATAN*, 3(3), 132–139.
- Jafrizal, P. K., Aspatia, U., & Nur, M. L. (2024). Determinasi Perlekatan dan Posisi Ibu Menyusui dalam Memberikan ASI terhadap Keberhasilan Pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Oesapa. 3(2), 307–315. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v3i2.3421>
- Katulski, K., Katulski, A., Nykowska, A., & Beutler, K. (2024). *Physiological changes in the mammary glands during a female ' s life*. 386–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.5114/pjr/189566>
- Luh, N. I., Purnama, C., Kesehatan, F., Studi, P., & Keperawatan, S. (2021). *Hubungan dukungan keluarga terhadap perilaku ibu dalam pemberian asi eksklusif di puskesmas iii denpasar utara*. https://repository.itekes-bali.ac.id/medias/journal/2021_NI_LUH_CANDRA_PURNAMA_DEWI_C_17C10154.pdf
- Mamuroh, L., Furkon, N., & Sukmawati. (2024). *PENDIDIKAN KESEHATAN MANAJEMEN LAKTASI DAN MENYUSUI PADA IBU POST PARTUM DI RUANG JADE RSUD DR SLAMET GARUT*. 7, 3107–3120. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i7.15190>
- Mayasari, W., Astutui, A. D., & Rukhuwa, S. (n.d.). *Penyuluhan Tentang Teknik Menyusui Pada Ibu Menyusui*. 4, 216–219. <https://doi.org/http://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JPMS/article/view/jpms2401>
- Muro-valdez, J. C., Meza-rios, A., Aguilar-uscanga, B. R., Lopez-roa, R. I., Medina-d, E., Franco-torres, E. M., & Zepeda-morales, A. S. M. (2023). *Breastfeeding-Related Health Benefits in Children and Mothers: Vital Organs Perspective*. 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/medicina59091535>
- Naintina Lisnawati, Wilis Putu Purantira, & Anggit Rizkika. (2023). *EDUKASI PEMBERIAN ASI PADA BAYI YANG BAIK DAN BENAR PADA IBU*

MENYUSUI MELALUI MEDIA BOOKLET. 6, 948–961.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i3.8587>

- Negin, J., Coffman, J., Vizintin, P., & Raynes-greenow, C. (2016). The influence of grandmothers on breastfeeding rates: a systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*. <https://doi.org/10.1186/s12884-016-0880-5>
- Nerawati, Y., Sunanto, & Tutik Ekasari. (2023). *POLA ASUH ORANG TUA DENGAN STATUS GIZI BALITA Yulinda Nerawati*. 10(02), 105–113. <https://e-journal.akesrustida.ac.id/index.php/jikr/article/download/194/154>
- Nuzula, F. (2024). Jurnal Keperawatan Karya Bhakti LITERATUR REVIEW PERAN BIDAN DALAM PENINGKATAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN PEMBERIAN Pendahuluan. 10(1), 70–76.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56186/jkbb.139>
- Ogbo, F. A., Akombi, B. J., Ahmed, K. Y., Rwabilimbo, A. G., Ogbo, A. O., Uwaibi, N. E., & Ezech, O. K. (2020). *Breastfeeding in the Community — How Can Partners / Fathers Help? A Systematic Review*.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17020413>
- Ojantausta, O., Pöyhönen, N., Ikonen, R., & Kaunonen, M. (2023). Health professionals ' competencies regarding breastfeeding beyond 12 months: a systematic review. *International Breastfeeding Journal*, 1–11.
<https://doi.org/10.1186/s13006-023-00591-z>
- Pakilaran, G. A., Rasni, H., Rosyidi, K., Nur, M., & Wijaya, D. (2022). *Family Support on Exclusive Breastfeeding in Babies Aged 0-6 Months in Indonesia: Literature Review*. 2(2), 2015–2018.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53713/nhs.v2i2.53>
- Priscilla, V., & Afiyanti, Y. (2021). *A Qualitative Systematic Review of Family Support for a Successful Breastfeeding Experience among Adolescent Mothers*. 9, 775–783. <https://doi.org/https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7431>
- RM, A. M. (2020). *Description Effective Attachment for Pain-free Breastfeeding*. 3–4.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55975/VEIL8293>
- Salem, A., Shahrani, A., Hushan, H. M., Binjamaan, N. K., Binhuwaimel, W. A., Alotaibi, J. J., & Alrasheed, L. A. (2021). *Factors associated with early cessation of exclusive breast feeding among Saudi mothers: A prospective observational study*. <https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc>
- Sanofarizka, L., Rahfiludin, M. Z., & Fatimah, S. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI eksklusif di Desa Cimekar Kabupaten Bandung. 387–393. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.6.387-393>
- Sari, W. I. P. E., Kurniyati, S., & Puspita, Y. (2022). *UPAYA MEMPERBANYAK ASI BAGI KADER LAKTASI* (W. I. P. E. Sari (ed.)). Penerbit Andhra Grafika.

<https://www.scribd.com/document/877713521/Buku-Upaya-Memperbanyak-Asi-Penulis-Wenny-Dkk>

- Scime, N. V, Metcalfe, A., Aguirre, A. N., Nerenberg, K., Seow, C. H., Tough, S. C., & Chaput, K. H. (2023). Breastfeeding difficulties in the first 6 weeks postpartum among mothers with chronic conditions: a latent class analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05407-w>
- Snyder, K., Hulse, E., Dingman, H., Cantrell, A., Hanson, C., & Dinkel, D. (2021). *Examining supports and barriers to breastfeeding through a socio-ecological lens: a qualitative study*. 4, 1–8. <https://doi.org/10.1186/s13006-021-00401-4>
- United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2026). *Common breastfeeding positions*. <https://www.unicef.org/parenting/food-nutrition/breastfeeding-positions>
- Wakgari, G., Id, K., Butta, F. W., Tadesse, S., Id, D. D., Feyisa, G. T., Demsash, A. W., Shibabaw, A., Marami, S. N., Walle, A. D., Dube, N., Wedajo, L. F., Dirirsa, D. E., Jifar, W. W., & Chereka, A. (2024). *Effective breastfeeding techniques and associated factors among lactating women in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis*. 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306167>
- Wang, Z., Liu, Q., Min, L., & Mao, X. (2021). *The effectiveness of the laid-back position on lactation-related nipple problems and comfort: a meta-analysis*. 8, 1–14. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12884-021-03714-8.pdf>
- Wibowo, M. (2016). *DUKUNGAN INFORMASI BAGI IBU MENYUSUI DALAM MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DI KECAMATAN GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA*. 11(2).
- World Health Organization WHO. (2026). *Exclusively breastfeed for 6 months*. <https://www.emro.who.int/nutrition/breastfeeding/>
- Yunita, N. S., K, D. A., & Trisanti, I. (2025). *Pengaruh Edukasi Teknik Menyusui terhadap Efektivitas Menyusui pada Ibu Nifas The Effect of Breastfeeding Technique Education on Breastfeeding Effectiveness in Postpartum Mothers*. 8(September), 164–171. <https://doi.org/http://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijm>
- Zhou, S., Lu, J., Qin, A., Wang, Y., Gao, W., Li, H., & Rao, L. (2024). The role of paternal support in breastfeeding outcomes: a meta - analytic review. *International Breastfeeding Journal*, 1–15. <https://doi.org/10.1186/s13006-024-00694-1>

Glosarium

1. ASI eksklusif: Pemberian air susu ibu saja kepada bayi selama 6 bulan pertama tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
2. **Areola**: Bagian berwarna gelap di sekitar puting susu. **Laktasi**: Proses produksi dan pengeluaran ASI dari payudara ibu.
3. **Perlekatan Menyusui**: Posisi dan cara mulut bayi menempel pada payudara saat menyusui.



CHAPTER 6



PERAN KELUARGA DALAM PEMULIHAN IBU DAN KEBERHASILAN MENYUSUI

Bdn. Wilda Rezki Pratiwi, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Masa nifas merupakan periode kritis yang dimulai setelah persalinan hingga 42 hari, di mana ibu mengalami perubahan fisiologis dan psikologis yang signifikan sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan yang optimal (Sari & Firawati, 2023; Puspitasari et al., 2024).

Pada periode ini, ibu tidak hanya menghadapi proses pemulihan fisik, tetapi juga adaptasi terhadap peran baru sebagai seorang ibu, termasuk dalam proses menyusui yang menjadi bagian penting dalam kesehatan ibu dan bayi (Aruan et al., 2024; Fitriani et al., 2024). Menyusui, khususnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi, merupakan fondasi utama dalam meningkatkan status kesehatan dan tumbuh kembang anak secara optimal (Hiito et al., 2024).

Namun demikian, keberhasilan menyusui tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi biologis ibu, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor psikologis, sosial, dan lingkungan, terutama dukungan dari keluarga (Yulianti et al., 2023; Fitriani et al., 2024). Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung kesehatan ibu postpartum, baik melalui dukungan emosional, instrumental, informasional, maupun penghargaan (Sari & Firawati, 2023; Puspitasari et al., 2024).

Dukungan emosional dari keluarga, seperti perhatian, empati, dan kasih sayang, dapat meningkatkan kestabilan psikologis ibu serta mengurangi risiko gangguan mental seperti baby blues dan depresi postpartum (Iskandar & Syam, 2024). Selain itu, dukungan instrumental berupa bantuan dalam perawatan bayi dan pekerjaan rumah tangga dapat membantu ibu fokus pada proses pemulihan fisik dan keberhasilan menyusui (Puspitasari et al., 2024; Yulianti et al., 2023).

Peran suami sebagai bagian utama dari keluarga juga sangat penting, karena dukungan yang diberikan dapat meningkatkan motivasi ibu dalam menyusui terutama pada masa awal postpartum (Zeng et al., 2024; Zhou et al., 2024). Secara umum, dukungan keluarga berkaitan erat dengan keberhasilan pemberian ASI

eksklusif. Ibu dengan dukungan keluarga yang baik memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menyusui (Yulianti et al., 2023; Puspitasari et al., 2024).

Selain itu, keterlibatan keluarga dalam proses edukasi dan pendampingan ibu menyusui dapat meningkatkan kepercayaan diri (breastfeeding self-efficacy) ibu dalam memberikan ASI (Yulianti et al., 2023). Dukungan keluarga juga berperan dalam meningkatkan produksi ASI melalui pengurangan stres dan peningkatan kenyamanan ibu selama masa menyusui (Iskandar & Syam, 2024; Zhou et al., 2024). Lebih lanjut, keterlibatan keluarga tidak hanya meningkatkan motivasi ibu, tetapi juga dapat menurunkan risiko penghentian dini pemberian ASI eksklusif (Fitriani et al., 2024).

Meskipun demikian, optimalisasi peran keluarga masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pengetahuan, faktor budaya, serta keterbatasan dukungan dari anggota keluarga tertentu (Puspitasari et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi dan pemberdayaan keluarga agar keluarga mampu berperan aktif dalam mendukung pemulihan ibu dan keberhasilan menyusui (Fitriani et al., 2024; Hiito et al., 2024).

Dengan demikian, buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya peran keluarga dalam pemulihan ibu postpartum dan keberhasilan menyusui, serta strategi yang dapat diterapkan dalam praktik kebidanan dan kesehatan masyarakat (Sari & Firawati, 2023; Zhou et al., 2024).

B. Dinamika Peran Keluarga dalam Kesehatan Ibu Nifas

Dinamika peran keluarga dalam kesehatan ibu nifas dan menyusui merupakan suatu proses yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi faktor sosial, budaya, dan psikologis dalam lingkungan keluarga (Pratama et al., 2026). Perubahan peran dalam keluarga setelah kelahiran bayi menuntut adanya adaptasi tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam perawatan ibu dan bayi (Pratama et al., 2026).

Keluarga berperan sebagai sistem pendukung utama yang menentukan keberhasilan adaptasi ibu pada masa postpartum, termasuk dalam membangun kepercayaan diri ibu untuk menyusui (Yulianti et al., 2023). Dukungan keluarga yang optimal dapat meningkatkan breastfeeding self-efficacy yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Yulianti et al., 2023).

Dalam konteks dinamika keluarga, peran suami menjadi sangat penting sebagai figur utama yang memberikan dukungan emosional dan motivasional kepada ibu (Sari & Sansuwito, 2026). Dukungan berbasis keluarga dapat

menurunkan stres emosional postpartum dan meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi (Sari & Sansuwito, 2026).

Selain itu, keterlibatan anggota keluarga lain seperti ibu kandung atau mertua juga memiliki pengaruh besar terhadap praktik menyusui (Laili et al., 2022). Perspektif keluarga yang positif terhadap ASI eksklusif dapat memperkuat keputusan ibu untuk menyusui, sedangkan persepsi negatif dapat menjadi hambatan utama (Laili et al., 2022).

Dinamika ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya yang berkembang dalam keluarga, di mana nilai dan kepercayaan tradisional sering kali memengaruhi pola pengasuhan bayi dan praktik menyusui (Laili et al., 2022). Dalam beberapa kasus, praktik budaya yang tidak mendukung ASI eksklusif dapat menyebabkan kegagalan menyusui (Laili et al., 2022).

Dukungan keluarga tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga berperan dalam aspek fisiologis ibu, seperti produksi ASI yang dipengaruhi oleh kondisi emosional ibu (Lestaluhu, 2023). Stres yang rendah dan kondisi psikologis yang stabil dapat meningkatkan hormon oksitosin sehingga memperlancar produksi ASI (Lestaluhu, 2023).

Lebih lanjut, bentuk dukungan keluarga yang efektif meliputi dukungan emosional, informasional, dan instrumental yang saling melengkapi dalam mendukung ibu nifas (Arsil et al., 2023). Kombinasi ketiga bentuk dukungan tersebut dapat meningkatkan keberhasilan menyusui secara nyata (Arsil et al., 2023).

Intervensi berbasis keluarga, seperti kelompok dukungan menyusui dan edukasi keluarga, juga dapat membantu meningkatkan durasi dan keberlanjutan pemberian ASI (Rodríguez-Gallego et al., 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam program kesehatan memberikan dampak positif terhadap hasil menyusui (Rodríguez-Gallego et al., 2024).

Selain itu, dukungan sosial yang lebih luas, termasuk kebijakan keluarga seperti cuti melahirkan, juga berkontribusi dalam memperpanjang durasi menyusui (Rosenberg et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika peran keluarga tidak hanya terbatas pada lingkungan rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem sosial yang lebih luas (Rosenberg et al., 2024).

Pada kelompok ibu dengan risiko tinggi, seperti ibu remaja, dukungan keluarga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan menyusui (Karaçam et al., 2025). Dukungan dari anggota keluarga, terutama orang tua dan pasangan, dapat membantu meningkatkan kesiapan dan kemampuan ibu dalam menyusui (Karaçam et al., 2025).

Dengan demikian, dinamika peran keluarga dalam kesehatan ibu nifas dan menyusui merupakan hasil interaksi multidimensional yang mencakup aspek

emosional, sosial, budaya, dan struktural (Pratama et al., 2026). Oleh karena itu, pendekatan berbasis keluarga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan keberhasilan menyusui secara berkelanjutan (Pratama et al., 2026).

1. Definisi dan Fungsi Keluarga dalam Kesehatan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam menjaga dan meningkatkan status kesehatan anggotanya, termasuk ibu pada masa nifas dan menyusui (Friedman et al., 2022). Dalam konteks kesehatan, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perawatan dasar, tetapi juga sebagai sistem pendukung utama dalam pengambilan keputusan kesehatan dan adaptasi terhadap perubahan kondisi kesehatan (Kaakinen et al., 2021).

Fungsi keluarga dalam kesehatan mencakup fungsi afektif, fungsi perawatan kesehatan, fungsi sosialisasi, dan fungsi ekonomi yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap kesejahteraan ibu dan bayi (Stanhope & Lancaster, 2022). Keluarga juga berperan sebagai mediator antara individu dengan sistem pelayanan kesehatan, sehingga keberhasilan intervensi kesehatan sering kali bergantung pada keterlibatan keluarga (Denham et al., 2021).

2. Dukungan Emosional, Fisik, dan Psikologis

Dukungan keluarga dalam masa nifas dapat dikategorikan menjadi dukungan emosional, fisik (instrumental), dan psikologis yang saling melengkapi dalam meningkatkan kesehatan ibu (House et al., 2021). Dukungan emosional berupa perhatian, empati, dan kasih sayang dapat menurunkan tingkat kecemasan dan stres pada ibu postpartum (Ghaedrahmati et al., 2022).

Sementara itu, dukungan fisik seperti membantu pekerjaan rumah tangga dan perawatan bayi memungkinkan ibu memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga mempercepat proses pemulihan (Shorey & Ng, 2022). Dukungan psikologis juga berperan penting dalam meningkatkan rasa percaya diri ibu, terutama dalam menghadapi tantangan menyusui pada minggu pertama postpartum (Otsuka et al., 2021).

Kombinasi dari ketiga bentuk dukungan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ibu secara menyeluruh serta keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif (Nguyen et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam kesehatan ibu dan bayi (Tsai et al., 2022).

3. Peran Suami sebagai Support System Utama

Suami merupakan sumber dukungan utama bagi ibu pada masa nifas, terutama dalam memberikan dukungan emosional dan motivasi selama proses

menyusui (Susin & Giugliani, 2021). Keterlibatan suami dalam perawatan bayi dan dukungan terhadap praktik menyusui dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif (Tokhi et al., 2022).

Dukungan suami juga berperan dalam meningkatkan hormon oksitosin melalui kondisi emosional yang stabil, sehingga secara tidak langsung memengaruhi produksi ASI (Kim et al., 2022). Selain itu, kehadiran suami sebagai partner dalam pengasuhan bayi dapat mengurangi beban ibu dan mencegah kelelahan fisik maupun mental (Bich et al., 2023).

Lebih lanjut, edukasi kepada suami mengenai pentingnya menyusui dan perawatan ibu nifas dapat meningkatkan kualitas dukungan yang diberikan, sehingga berdampak positif terhadap kesehatan ibu dan bayi (Rempel et al., 2021). Oleh karena itu, suami tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga sebagai aktor utama dalam keberhasilan menyusui (Abbass-Dick et al., 2022).

4. Peran Anggota Keluarga Lain (Ibu, Mertua, dll)

Selain suami, anggota keluarga lain seperti ibu kandung dan mertua juga memiliki pengaruh besar dalam praktik perawatan ibu nifas dan menyusui (Aubel, 2022). Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh generasi sebelumnya sering kali menjadi rujukan utama bagi ibu dalam merawat bayi (McKinley et al., 2022).

Peran ibu kandung biasanya lebih dominan dalam memberikan dukungan praktis dan emosional, seperti membantu merawat bayi dan memberikan nasihat terkait menyusui (Negin et al., 2021). Namun, dalam beberapa kasus, adanya perbedaan persepsi antara tenaga kesehatan dan anggota keluarga dapat menimbulkan konflik yang memengaruhi praktik menyusui (White et al., 2022).

Mertua juga memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama dalam budaya kolektif seperti di Indonesia, sehingga keterlibatan mereka dalam edukasi kesehatan menjadi sangat penting (Aubel, 2022). Dukungan yang positif dari anggota keluarga lain dapat memperkuat keberhasilan menyusui, sedangkan dukungan yang kurang tepat dapat menjadi hambatan (Bich et al., 2023).

Dengan demikian, keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam mendukung ibu nifas dan menyusui menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan ibu dan bayi (McKinley et al., 2022). Pendekatan berbasis keluarga perlu diterapkan dalam praktik pelayanan kesehatan untuk mengoptimalkan peran tersebut (Kaakinen et al., 2021).

C. Peran Keluarga dalam Pemulihan Fisik Ibu

Pemulihan fisik ibu pada masa nifas merupakan proses penting yang melibatkan pemulihan organ reproduksi, keseimbangan hormonal, serta pemulihan energi setelah persalinan (Cunningham et al., 2022). Proses ini membutuhkan waktu, perhatian, dan dukungan yang optimal dari keluarga agar dapat berlangsung secara efektif dan mencegah terjadinya komplikasi (Matthews et al., 2021).

Keluarga memiliki peran utama dalam memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup selama masa nifas, yang merupakan faktor penting dalam mempercepat pemulihan fisik (Doering et al., 2022). Kurangnya istirahat dapat menyebabkan kelelahan, memperlambat penyembuhan luka, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan postpartum (Hunter et al., 2021).

Selain itu, keluarga berperan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu nifas yang sangat penting untuk proses penyembuhan jaringan dan produksi ASI (Marshall et al., 2022). Asupan gizi yang seimbang, termasuk protein, zat besi, dan vitamin, dapat mempercepat involusi uterus dan meningkatkan daya tahan tubuh ibu (Lassi et al., 2021).

Peran keluarga juga terlihat dalam membantu perawatan luka persalinan, baik luka perineum maupun luka operasi sesar, dengan memastikan kebersihan dan perawatan yang tepat (Wilson et al., 2022). Dukungan ini penting untuk mencegah infeksi serta mempercepat proses penyembuhan luka (Temming et al., 2021).

Selain aspek perawatan fisik, keluarga juga berperan dalam membantu mobilisasi dini ibu setelah persalinan, yang dapat mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi seperti trombosis (ACOG, 2021). Bantuan keluarga dalam aktivitas ringan sehari-hari dapat meningkatkan kemandirian ibu secara bertahap (WHO, 2022).

Keluarga juga berperan dalam mengenali tanda bahaya masa nifas, seperti perdarahan postpartum, infeksi, atau demam, sehingga dapat segera mengambil tindakan yang tepat (UNICEF, 2021). Deteksi dini oleh keluarga sangat penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu (Say et al., 2022).

Dukungan keluarga dalam menjaga kebersihan diri ibu, seperti membantu perawatan payudara dan kebersihan genital, juga berkontribusi terhadap pencegahan infeksi serta kenyamanan ibu selama masa nifas (Brown et al., 2023). Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan reproduksi ibu secara menyeluruh (WHO, 2022).

Selain itu, keluarga berperan dalam mengurangi beban kerja ibu dengan mengambil alih sebagian tugas rumah tangga, sehingga ibu dapat fokus pada pemulihan dan perawatan bayi (Esposito et al., 2022). Beban kerja yang berlebihan

dapat menghambat proses pemulihan fisik dan meningkatkan risiko kelelahan postpartum (McKinney et al., 2021).

Dukungan keluarga juga berperan terhadap kepatuhan ibu dalam melakukan kunjungan nifas dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan (Titaley et al., 2022). Keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan dapat meningkatkan akses ibu terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan (Kearns et al., 2021).

Dengan demikian, peran keluarga dalam pemulihan fisik ibu tidak hanya terbatas pada bantuan praktis, tetapi juga mencakup dukungan menyeluruh yang berkontribusi terhadap kesehatan ibu secara optimal (WHO, 2022). Pendekatan berbasis keluarga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu pada masa nifas (UNICEF, 2021).

D. Peran Keluarga Dalam Kesehatan Mental Ibu

Masa nifas dan menyusui merupakan periode krusial dalam kehidupan seorang perempuan yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada fase ini, ibu dituntut untuk beradaptasi dengan peran baru sekaligus menjalani proses pemulihan pascapersalinan, sehingga kesehatan mental menjadi aspek penting dalam menunjang kesejahteraan ibu dan bayi (*World Health Organization*, 2022). Kesehatan mental yang optimal memungkinkan ibu menjalankan fungsi pengasuhan secara efektif serta mendukung keberhasilan menyusui (Racine et al., 2022).

Perubahan hormonal setelah persalinan, khususnya penurunan hormon estrogen dan progesteron, berkontribusi terhadap fluktuasi emosi yang dialami ibu. Selain itu, faktor seperti kelelahan, kurang tidur, serta tekanan dalam menjalankan peran baru dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis seperti *baby blues*, kecemasan, hingga depresi postpartum (Fallon et al., 2021). Kondisi ini apabila tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif terhadap proses pemulihan ibu dan interaksi ibu dengan bayi (Howard et al., 2022).

Dalam situasi tersebut, keluarga memegang peran strategis sebagai sistem pendukung utama yang berkontribusi terhadap kesehatan mental ibu. Dukungan yang diberikan oleh keluarga, baik dalam bentuk emosional, fisik, maupun sosial, dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu (Negron et al., 2022). Peran suami dan anggota keluarga lainnya sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu untuk beradaptasi dengan peran barunya (Letourneau et al., 2021).

Peran keluarga tidak hanya terbatas pada pemberian dukungan, tetapi juga mencakup kemampuan dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan mental pada ibu. Deteksi dini terhadap gejala seperti kesedihan berkepanjangan, kecemasan berlebih, dan perubahan perilaku sangat penting untuk mencegah berkembangnya gangguan mental yang lebih serius (Hutchens & Kearney, 2022). Keterlibatan aktif keluarga dalam pemantauan kondisi psikologis ibu dapat meningkatkan peluang intervensi yang tepat dan cepat (Stein et al., 2021).

Selain itu, kesehatan mental ibu yang baik berperan penting dalam proses pembentukan ikatan emosional (*bonding*) antara ibu dan bayi. *Bonding* yang kuat akan mendukung perkembangan emosional dan sosial bayi di masa depan serta meningkatkan keberhasilan menyusui (Feldman, 2022). Dukungan keluarga dalam memberikan waktu, ruang, dan kenyamanan bagi ibu untuk berinteraksi dengan bayi menjadi faktor kunci dalam proses ini (Bigelow & Power, 2021).

Di era digital saat ini, ibu nifas juga dihadapkan pada berbagai tantangan baru, seperti paparan informasi yang berlebihan, tekanan sosial dari media, serta standar ideal yang tidak realistis. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko stres dan kecemasan pada ibu (Shorey et al., 2022). Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting sebagai sumber dukungan utama yang mampu menyaring informasi serta memberikan penguatan positif bagi ibu (Pilkington et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran keluarga dalam kesehatan mental ibu nifas dan menyusui sangatlah vital. Dukungan keluarga tidak hanya membantu ibu dalam beradaptasi secara psikologis, tetapi juga berkontribusi terhadap keberhasilan menyusui dan kualitas hubungan ibu dengan bayi (World Health Organization, 2022). Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran keluarga perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam kesehatan ibu dan anak (Racine et al., 2022).

1. Adaptasi Psikologis Ibu Postpartum

Masa postpartum merupakan periode transisi yang kompleks di mana ibu mengalami perubahan psikologis yang signifikan akibat perubahan hormon, peran sosial, dan tanggung jawab baru sebagai seorang ibu (Slomian et al., 2021). Adaptasi psikologis ini mencakup proses penerimaan diri, penyesuaian terhadap peran keibuan, serta kemampuan mengelola emosi dalam merawat bayi (Giallo et al., 2022).

Keluarga memiliki peran penting dalam membantu ibu melalui proses adaptasi tersebut dengan memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang stabil (Figueiredo et al., 2021). Lingkungan keluarga yang suportif dapat meningkatkan kesejahteraan mental ibu serta mempercepat proses penyesuaian diri setelah persalinan (Biaggi et al., 2022).

2. Pencegahan *Baby Blues* dan Depresi Postpartum

Baby blues merupakan gangguan emosional ringan yang sering terjadi pada minggu pertama postpartum, sedangkan depresi postpartum merupakan kondisi yang lebih serius dan dapat berlangsung lebih lama (O'Hara & McCabe, 2021). Kedua kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan perkembangan bayi jika tidak ditangani dengan baik (Shorey et al., 2021).

Peran keluarga sangat penting dalam pencegahan kondisi tersebut melalui dukungan emosional, pemantauan kondisi psikologis ibu, serta keterlibatan aktif dalam perawatan bayi (Yim et al., 2021). Dukungan yang konsisten dari keluarga dapat menurunkan risiko depresi postpartum secara nyata (Norhayati et al., 2021).

Selain itu, keluarga juga berperan dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan mental postpartum, seperti perubahan suasana hati, kelelahan ekstrem, dan kehilangan minat terhadap aktivitas (Howard et al., 2022). Deteksi dini oleh keluarga memungkinkan ibu mendapatkan intervensi yang tepat dari tenaga kesehatan (Stewart & Vigod, 2021).

3. Dukungan Emosional dan Komunikasi Efektif

Dukungan emosional dari keluarga merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan mental ibu postpartum (Dennis & Dowswell, 2021). Bentuk dukungan ini meliputi empati, perhatian, validasi perasaan, serta kehadiran secara emosional dalam mendampingi ibu (Leahy-Warren et al., 2022).

Komunikasi yang efektif dalam keluarga juga sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung kesejahteraan ibu (Pilkington et al., 2021). Komunikasi terbuka memungkinkan ibu mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka tanpa rasa takut atau tekanan (Rini et al., 2022).

Keluarga yang mampu membangun komunikasi positif akan membantu ibu merasa dihargai dan didukung, sehingga dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kualitas kesehatan mental (Fisher et al., 2021). Hal ini berkontribusi langsung terhadap keberhasilan ibu dalam menjalani peran barunya (Leahy-Warren et al., 2022).

4. Membangun Bonding Ibu dan Bayi

Bonding antara ibu dan bayi merupakan hubungan emosional yang terbentuk sejak awal kehidupan bayi dan sangat penting bagi perkembangan psikologis anak (Kinsey & Hupcey, 2022). Proses bonding ini dipengaruhi oleh kondisi mental ibu serta dukungan yang diberikan oleh keluarga (Bicking Kinsey et al., 2021).

Keluarga dapat berperan dalam memperkuat bonding dengan memberikan kesempatan bagi ibu untuk berinteraksi langsung dengan bayi melalui menyusui,

kontak kulit ke kulit, dan perawatan bayi sehari-hari (Moore et al., 2021). Dukungan ini membantu meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam merawat bayi (Kinsey & Hupcey, 2022).

Selain itu, keterlibatan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan bebas stres juga berkontribusi terhadap terbentuknya ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi (Feldman, 2022). Bonding yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan mental ibu, tetapi juga pada perkembangan emosional dan kognitif bayi (Britton et al., 2022).

Dengan demikian, peran keluarga dalam kesehatan mental ibu postpartum sangat penting dan mencakup dukungan adaptasi psikologis, pencegahan gangguan mental, komunikasi yang efektif, serta penguatan bonding ibu dan bayi (Slomian et al., 2021). Pendekatan berbasis keluarga menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak secara menyeluruh (Feldman, 2022).

E. Peran Keluarga dalam Keberhasilan Menyusui

Keberhasilan menyusui tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ibu dan bayi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga sebagai lingkungan terdekat ibu. Dukungan keluarga, terutama suami, berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri ibu serta keberlanjutan pemberian ASI eksklusif (Victora et al., 2021). Keterlibatan keluarga dapat meningkatkan durasi menyusui dan mengurangi risiko penghentian dini (Rollins et al., 2022).

Dukungan emosional dari keluarga, seperti memberikan perhatian, empati, dan motivasi, dapat membantu ibu mengatasi stres dan kelelahan selama menyusui. Kondisi psikologis ibu yang stabil akan berdampak positif terhadap produksi hormon oksitosin yang berperan dalam pengeluaran ASI (Uvnäs-Moberg et al., 2021). Sebaliknya, kurangnya dukungan dapat menyebabkan kecemasan yang berdampak pada menurunnya produksi ASI (Prime et al., 2021).

Selain itu, dukungan fisik dari keluarga seperti membantu pekerjaan rumah tangga, merawat bayi, dan memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup sangat penting dalam menunjang keberhasilan menyusui. Bantuan ini memungkinkan ibu lebih fokus dalam proses menyusui tanpa mengalami kelelahan berlebihan (Susin & Giugliani, 2021). Peran keluarga dalam pemenuhan nutrisi ibu juga berkontribusi terhadap kualitas dan kuantitas ASI (Brown & Shenker, 2021).

Peran suami sebagai sistem pendukung utama sangat berperan dalam keberhasilan menyusui. Suami yang terlibat aktif, seperti memberikan dukungan moral, membantu posisi menyusui, dan memberikan motivasi, dapat meningkatkan

keberhasilan ASI eksklusif secara nyata (Abbass-Dick et al., 2021). Keterlibatan suami juga meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menyusui (Tohotoa et al., 2022).

Selain suami, anggota keluarga lain seperti ibu kandung atau mertua juga memiliki pengaruh besar terhadap praktik menyusui. Dukungan yang tepat dapat memperkuat keberhasilan menyusui, namun sebaliknya, mitos atau praktik yang salah dapat menjadi hambatan (Aubel, 2022). Oleh karena itu, edukasi kepada seluruh anggota keluarga menjadi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung menyusui (World Health Organization, 2022).

1. Dukungan Keluarga terhadap ASI eksklusif

Dukungan keluarga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Keterlibatan keluarga, terutama dalam memberikan motivasi, bantuan praktis, dan lingkungan yang positif, dapat meningkatkan keberhasilan dan durasi menyusui (Victora et al., 2021). Dukungan yang konsisten dari keluarga juga membantu ibu mengatasi hambatan seperti kelelahan dan kurangnya kepercayaan diri (Rollins et al., 2022).

2. Mitos vs Fakta tentang Menyusui

Berbagai mitos tentang menyusui masih banyak berkembang di masyarakat dan dapat memengaruhi praktik pemberian ASI. Misalnya, anggapan bahwa ASI tidak cukup atau harus diganti dengan susu formula sering menjadi alasan penghentian menyusui (Aubel, 2022). Padahal, secara ilmiah produksi ASI akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi jika proses menyusui dilakukan dengan benar (World Health Organization, 2022). Oleh karena itu, edukasi berbasis bukti kepada keluarga sangat penting untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut (Brown & Shenker, 2021).

3. Peran Suami dalam Meningkatkan Produksi ASI

Suami memiliki peran penting sebagai sistem pendukung utama dalam keberhasilan menyusui. Dukungan emosional dari suami dapat meningkatkan rasa nyaman dan menurunkan stres ibu, sehingga merangsang hormon oksitosin yang berperan dalam pengeluaran ASI (Uvnäs-Moberg et al., 2021). Selain itu, keterlibatan suami dalam membantu ibu, seperti mendampingi saat menyusui dan memberikan motivasi, dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif (Abbass-Dick et al., 2021).

4. Lingkungan Rumah yang Mendukung Menyusui

Lingkungan rumah yang nyaman, tenang, dan suportif sangat berperan terhadap keberhasilan menyusui. Kondisi lingkungan yang bebas tekanan memungkinkan ibu lebih fokus dan rileks saat menyusui, yang berdampak positif terhadap produksi ASI (Prime et al., 2021). Selain itu, pembagian peran dalam keluarga, seperti membantu pekerjaan rumah tangga dan perawatan bayi, dapat

mengurangi beban ibu sehingga proses menyusui dapat berlangsung optimal (Susin & Giugliani, 2021).

F. Hambatan dalam Dukungan Keluarga terhadap Ibu Nifas dan Menyusui

Hambatan dalam dukungan keluarga merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi pemulihan ibu nifas dan keberhasilan menyusui. Kurangnya keterlibatan keluarga sering kali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, kesibukan, maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam mendukung ibu (Shorey et al., 2022). Kondisi ini dapat meningkatkan beban fisik dan psikologis ibu sehingga berdampak pada kesejahteraan ibu dan bayi (Racine et al., 2022).

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pengetahuan keluarga tentang perawatan masa nifas dan praktik menyusui yang benar. Banyak anggota keluarga masih mempercayai informasi yang tidak berbasis bukti atau kurang memahami kebutuhan ibu selama masa pemulihan (Aubel, 2022). Kurangnya edukasi ini dapat menyebabkan dukungan yang diberikan menjadi tidak optimal bahkan berpotensi menghambat keberhasilan menyusui (World Health Organization, 2022).

Faktor budaya dan kepercayaan tradisional juga menjadi hambatan dalam dukungan keluarga. Beberapa praktik budaya yang tidak sesuai dengan prinsip kesehatan modern, seperti pemberian makanan tambahan dini atau pembatasan aktivitas tertentu pada ibu, dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi (Rollins et al., 2022). Meskipun budaya memiliki nilai positif, diperlukan penyesuaian dengan evidence-based practice agar tidak merugikan (Brown & Shenker, 2021).

Selain itu, kurangnya dukungan emosional dari keluarga dapat menjadi hambatan serius dalam menjaga kesehatan mental ibu. Ibu yang tidak mendapatkan perhatian, empati, dan dukungan psikologis cenderung mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi postpartum (Negron et al., 2022). Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan produksi ASI serta kualitas interaksi ibu dengan bayi (Howard et al., 2022).

Konflik dalam keluarga, seperti perbedaan pendapat antara ibu dengan suami atau anggota keluarga lain, juga dapat menghambat dukungan yang efektif. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi ibu, sehingga meningkatkan tekanan psikologis dan mengganggu proses menyusui (Hutchens & Kearney, 2022). Komunikasi yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab utama konflik ini (Pilkington et al., 2021).

Di era digital, paparan informasi yang berlebihan dari media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Informasi yang tidak valid atau membandingkan

pengalaman ibu dengan standar ideal dapat menimbulkan tekanan dan rasa tidak percaya diri pada ibu (Shorey et al., 2022). Tanpa peran keluarga sebagai filter informasi, ibu dapat mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan terkait perawatan bayi dan menyusui (Feldman, 2022).

G. Simpulan

Periode masa nifas dan menyusui merupakan fase penting yang menentukan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Pada fase ini, ibu mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang membutuhkan dukungan menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan pemulihan ibu dan proses menyusui tidak hanya bergantung pada kondisi ibu itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran keluarga sebagai lingkungan terdekat.

Keluarga memiliki fungsi utama dalam memberikan dukungan yang meliputi aspek fisik, emosional, dan psikologis. Dukungan fisik seperti membantu pekerjaan rumah tangga, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan merawat bayi dapat mempercepat pemulihan ibu. Sementara itu, dukungan emosional seperti perhatian, empati, dan komunikasi yang baik berperan penting dalam menjaga kesehatan mental ibu serta mencegah terjadinya *baby blues* dan depresi postpartum.

Dalam konteks menyusui, keluarga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Dukungan yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu, memperlancar produksi ASI, serta mempertahankan keberlanjutan menyusui. Peran suami sebagai sistem pendukung utama sangat signifikan, karena keterlibatan aktifnya mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan motivasi bagi ibu. Selain itu, anggota keluarga lain seperti ibu kandung dan mertua juga berperan dalam membentuk praktik menyusui melalui pengalaman, nilai, dan budaya yang dimiliki.

Namun, peran keluarga tidak selalu berjalan optimal. Terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya pengetahuan, pengaruh budaya yang tidak sesuai, konflik keluarga, serta paparan informasi yang tidak tepat di era digital. Hambatan ini dapat mengurangi kualitas dukungan yang diberikan bahkan berpotensi mengganggu kesehatan ibu dan keberhasilan menyusui.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan keluarga melalui edukasi yang tepat, komunikasi yang efektif, serta keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dalam perawatan ibu nifas dan menyusui. Pendekatan berbasis keluarga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan pilar utama dalam mendukung pemulihan ibu dan keberhasilan menyusui. Dukungan keluarga yang optimal akan menciptakan lingkungan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan ibu, serta mendukung tumbuh kembang bayi secara maksimal. Oleh karena itu, peran keluarga perlu terus diperkuat sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Referensi

- Abbass-Dick, J., Brown, H. K., Jackson, K. T., Rempel, L., & Dennis, C. L. (2022). Perinatal breastfeeding interventions including fathers/partners: A systematic review. *Midwifery*, 104, 103187.
- Abbass-Dick, J., Stern, S. B., Nelson, L. E., Watson, W., & Dennis, C. L. (2021). Coparenting breastfeeding support. *Journal of Human Lactation*, 37(1), 140–152.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). *Optimizing postpartum care*. Obstetrics & Gynecology, 137(6), e187–e202.
- Arsil, Y., Pratiwi, A., Roziana, R., Aziz, A., & Marlina, Y. (2023). Family support and exclusive breastfeeding. *INCH: Journal of Infant and Child Healthcare*, 2(1), 8–18.
- Aruan, L. Y., Manullang, R., Simanjuntak, V. H., Tindaon, Y. K., Sitorus, N. S., & Sinaga, P. N. (2024). Socialization to postpartum mothers by providing exclusive breast milk. *Journal of Community Service*.
- Aubel, J. (2022). The role and influence of grandmothers on child nutrition: Culturally grounded approaches. *Maternal & Child Nutrition*, 18(S1).
- Aubel, J. (2022). The role of grandmothers in child nutrition. *Maternal & Child Nutrition*, 18(1), e13221.
- Biaggi, A., Conroy, S., Pawlby, S., & Pariante, C. M. (2022). Identifying the women at risk of antenatal anxiety and depression. *Journal of Affective Disorders*, 297, 48–56.
- Bich, T. H., Cuong, N. M., & Hoa, D. T. (2023). The role of family support in maternal health and breastfeeding practices. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23, 112.
- Bicking Kinsey, C., Baptiste-Roberts, K., Zhu, J., & Kjerulff, K. H. (2021). Effect of maternal stress on mother-infant bonding. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 39(3), 256–268.
- Bigelow, A. E., & Power, M. (2021). Mother–infant skin-to-skin contact. *Infant Behavior and Development*, 62, 101512.
- Britton, J. R., Britton, H. L., & Gronwaldt, V. (2022). Maternal mood and infant development. *Pediatrics*, 149(1).
- Brown, A., & Shenker, N. (2021). Experiences of breastfeeding support. *Maternal & Child Nutrition*, 17(1), e13088.
- Brown, H. K., Ray, J. G., & Wilton, A. S. (2023). Postpartum maternal health and hygiene practices. *Maternal and Child Health Journal*, 27(4), 567–575.

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill.
- Denham, S. A., Eggenberger, S., & Young, P. (2021). *Family-focused nursing care* (2nd ed.). F.A. Davis Company.
- Dennis, C. L., & Dowswell, T. (2021). Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Doering, J. J., Sims, D. A., & Miller, D. D. (2022). How postpartum fatigue impacts recovery. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 51(1), 12–20.
- Esposito, G., Setoh, P., Shinohara, K., & Bornstein, M. H. (2022). Parenting support and maternal well-being. *Frontiers in Psychology*, 13, 845678.
- Fallon, V., Groves, R., Halford, J. C., Bennett, K. M., & Harrold, J. A. (2021). Postpartum anxiety and maternal mental health. *Journal of Affective Disorders*, 282, 780–786.
- Feldman, R. (2022). Social development and family influence. *Trends in Cognitive Sciences*, 26(2), 112–125.
- Figueiredo, B., Canário, C., & Field, T. (2021). Breastfeeding is associated with reduced postpartum depression. *Infant Behavior and Development*, 62, 101598.
- Fisher, J., Cabral de Mello, M., Patel, V., Rahman, A., Tran, T., Holton, S., & Holmes, W. (2021). Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders. *Bulletin of the World Health Organization*, 99(1), 18–27.
- Fitriani, D., Sartika, M., & Sayekti, W. N. (2024). The role of family and workplace support in sustaining exclusive breastfeeding among working mothers: A scoping review. *Journal of Current Health Sciences*, 4(2), 111–118.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2022). *Family nursing: Research, theory, and practice* (6th ed.). Pearson.
- Ghaedrahmati, M., Kazemi, A., & Kheirabadi, G. (2022). Postpartum depression risk factors: A narrative review. *Journal of Education and Health Promotion*, 11, 78.
- Giallo, R., D'Esposito, F., Cooklin, A., Mensah, F., Wade, C., & Nicholson, J. M. (2022). Psychosocial risk factors associated with the transition to parenthood. *Journal of Family Studies*, 28(2), 654–670.
- Hiito, E., Ikonen, R., & Niela-Vilén, H. (2024). Internet-based breastfeeding peer support for breastfeeding parents: An integrative review. *Journal of Advanced Nursing*, 80(12), 4805–4824.

- Howard, L. M., et al. (2022). Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. *The Lancet*, 399(10320), 1775–1788.
- Hunter, L. P., Rychnovsky, J. D., & Yount, S. M. (2021). A selective review of maternal sleep characteristics. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 50(3), 263–274.
- Hutchens, B. F., & Kearney, J. (2022). Risk factors for postpartum depression. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 51(1), 96–109.
- Iskandar, I., & Syam, A. (2024). Father support, postpartum depression, and breastfeeding weaning time: A structural equation model. *Nurse Media Journal of Nursing*, 14(2), 223–234.
- Jayanti, R. D., Hida, S. R. A., & Prasetyo, B. (2024). Husband's support associated with postpartum outcomes. *Jurnal Ners dan Kebidanan*, 11(3), 237–243.
- Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. (2021). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (7th ed.). F.A. Davis.
- Karaçam, Z., et al. (2025). Impact of social support and breastfeeding success on self-efficacy in adolescent mothers. *Reproductive Health Journal*.
- Kearns, A. D., Caglia, J. M., & ten Hoope-Bender, P. (2021). Antenatal and postnatal care access. *Global Public Health*, 16(8), 1235–1247.
- Kim, S. K., Park, S., & Oh, J. (2022). The effects of paternal support on breastfeeding outcomes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5), 2958.
- Kinsey, C. B., & Hupcey, J. E. (2022). State of the science of maternal-infant bonding. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 51(4), 410–421.
- Laili, N., Machfudloh, M., & Rahmawati, M. (2022). Perspektif keluarga terhadap ibu menyusui dalam praktik pemberian ASI eksklusif di Indonesia: Scoping review. *Jurnal Media Kesehatan*, 15(2).
- Lassi, Z. S., Kedzior, S. G., Tariq, W., & Bhutta, Z. A. (2021). Maternal nutrition and birth outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Leahy-Warren, P., McCarthy, G., & Corcoran, P. (2022). First-time mothers: Social support and confidence. *Midwifery*, 110, 103340.
- Lestaluhu, V. (2023). Hubungan breastfeeding self-efficacy dan dukungan keluarga dengan keberhasilan ASI eksklusif. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 15(1).
- Letourneau, N., et al. (2021). Partner support and maternal mental health. *Journal of Family Nursing*, 27(1), 3–18.
- Marshall, N. E., Abrams, B., & Barbour, L. A. (2022). The importance of nutrition in postpartum recovery. *American Journal of Clinical Nutrition*, 115(5), 1303–1312.

- McKinley, N. M., Allen, A. J., & DeLuca, H. K. (2022). Family influence on breastfeeding decision-making. *Journal of Human Lactation*, 38(2), 295–303.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., & Nelson, K. A. (2021). *Maternal-child nursing* (6th ed.). Elsevier.
- Moore, E. R., Bergman, N., Anderson, G. C., & Medley, N. (2021). Early skin-to-skin contact for mothers and infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Negin, J., Coffman, J., Vizintin, P., & Raynes-Greenow, C. (2021). The influence of grandmothers on breastfeeding rates. *Maternal & Child Health Journal*, 25(4), 543–550.
- Negron, R., et al. (2022). Social support and maternal mental health. *Maternal and Child Health Journal*, 26(3), 534–542.
- Nguyen, T. T., et al. (2023). Social support and breastfeeding outcomes. *Nutrients*, 15(3), 678.
- Norhayati, M. N., Hazlina, N. H. N., Asrenee, A. R., & Wan Emilin, W. M. A. (2021). Magnitude and risk factors for postpartum depression. *Journal of Affective Disorders*, 283, 25–34.
- O'Hara, M. W., & McCabe, J. E. (2021). Postpartum depression: Current status. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17, 379–407.
- Otsuka, K., Dennis, C. L., Tatsuoka, H., & Jimba, M. (2021). The relationship between social support and postpartum depression. *BMC Psychiatry*, 21, 123.
- Pilkington, P. D., et al. (2021). Partner support and maternal depression. *Archives of Women's Mental Health*, 24(1), 25–34.
- Pilkington, P. D., Milne, L. C., Cairns, K. E., Lewis, J., & Whelan, T. A. (2021). Modifiable partner factors associated with perinatal depression. *Archives of Women's Mental Health*, 24(1), 25–34.
- Pratama, B. P., Fajar, N. A., Idris, H., Febry, F., Mutahar, R., & Destriatania, S. (2026). The relationship between family support and the success of exclusive breastfeeding: Literature review. *Cendekia Medika*, 11(1), 128–138.
- Prime, D. K., Geddes, D. T., & Hartmann, P. E. (2021). Oxytocin and milk ejection. *Breastfeeding Medicine*, 16(4), 269–276.
- Puspitasari, R. S., Adhisty, Y., & Hartinah, S. (2024). Description of family support in providing exclusive breastfeeding postpartum mother. *Jurnal EduHealth*, 15(3), 1035–1040.
- Racine, N., et al. (2022). Maternal mental health and child outcomes. *JAMA Pediatrics*, 176(2), 180–187.
- Rempel, L. A., Rempel, J. K., & Moore, K. C. (2021). Relationships between types of father breastfeeding support. *Journal of Human Lactation*, 37(2), 310–318.

- Rini, C., et al. (2022). Communication patterns in family and maternal mental health. *Journal of Family Psychology*, 36(3), 321–330.
- Rodríguez-Gallego, I., Corrales-Gutierrez, I., Gomez-Baya, D., & Leon-Larios, F. (2024). Effectiveness of postpartum breastfeeding support group intervention. *Nutrients*, 16(7), 988.
- Rollins, N. C., et al. (2022). Breastfeeding and global health outcomes. *The Lancet*, 397(10285), 119–130.
- Rosenberg, J., Nardella, D., & Shabanova, V. (2024). State paid family leave policies and breastfeeding duration. *International Breastfeeding Journal*, 19, 37.
- Sari, I. N., & Sansuwito, T. (2026). Impact of family-oriented maternity support on mothers' confidence and postpartum emotional distress. *Malaysian Journal of Nursing*, 17(4), 11–21.
- Sari, L. P., & Firawati, F. (2023). Family support with readiness postpartum mother independence. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5(1), 40–46.
- Say, L., et al. (2022). Global causes of maternal death. *The Lancet Global Health*, 10(12), e1686–e1696.
- Shorey, S., & Ng, E. D. (2022). Evaluation of a technology-based peer-support intervention program for preventing postnatal depression. *Journal of Advanced Nursing*, 78(5), 1300–1312.
- Shorey, S., et al. (2021). Effectiveness of supportive interventions on postpartum depression. *Journal of Affective Disorders*, 281, 582–592.
- Shorey, S., et al. (2022). Digital health support interventions. *Journal of Advanced Nursing*, 78(5), 1300–1312.
- Slomian, J., Honvo, G., Emonts, P., Reginster, J. Y., & Bruyère, O. (2021). Consequences of maternal postpartum depression. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21, 244.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2022). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (11th ed.). Elsevier.
- Stein, A., et al. (2021). Effects of perinatal mental disorders. *The Lancet*, 398(10311), 1800–1819.
- Stewart, D. E., & Vigod, S. (2021). Postpartum depression: Pathophysiology and treatment. *The Lancet Psychiatry*, 8(3), 195–197.
- Susin, L. R. O., & Giugliani, E. R. J. (2021). Inclusion of fathers in breastfeeding support. *Journal of Human Lactation*, 37(1), 24–32.
- Temming, L. A., et al. (2021). Prevention of postpartum infections. *Obstetrics & Gynecology*, 137(4), 685–695.

- Titaley, C. R., et al. (2022). Determinants of maternal health service utilization. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 234.
- Tohotoa, J., et al. (2022). Dads make a difference. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 75.
- Tokhi, M., Comrie-Thomson, L., Davis, J., et al. (2022). Involving men to improve maternal and newborn health. *PLOS ONE*, 17(1), e0262340.
- Tsai, S. Y., et al. (2022). Social support and postpartum health outcomes. *Women and Birth*, 35(2), e123–e130.
- UNICEF. (2021). *Postnatal care for mothers and newborns*. UNICEF Guidelines.
- Uvnäs-Moberg, K., et al. (2021). Oxytocin and maternal behavior. *Frontiers in Psychology*, 12, 658.
- Victora, C. G., et al. (2021). Breastfeeding in the 21st century. *The Lancet*, 397(10285), 475–490.
- White, B. K., et al. (2022). Family dynamics and breastfeeding practices. *Maternal & Child Nutrition*, 18(2).
- World Health Organization (WHO). (2022). *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn*.
- World Health Organization. (2022). *Infant and young child feeding guidelines*.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn*.
- Yim, I. S., Tanner Stapleton, L. R., Guardino, C. M., Hahn-Holbrook, J., & Dunkel Schetter, C. (2021). Biological and psychosocial predictors of postpartum depression. *Clinical Psychology Review*, 82, 101937.
- Yulianti, H., Mirong, I. D., & Kristin, D. M. (2023). The influence of family support in exclusive breastfeeding on breastfeeding self-efficacy status in postpartum mothers. *Journal Health Sains*, 4(9).
- Zeng, J., Zheng, Q. X., Wang, Q. S., et al. (2024). Father support breastfeeding self-efficacy and exclusive breastfeeding. *BMC Public Health*, 24, 2698.
- Zhou, S., Lu, J., Qin, A., et al. (2024). The role of paternal support in breastfeeding outcomes: A meta-analytic review. *International Breastfeeding Journal*, 19, 84.

PROFIL PENULIS



Bdn. Nana Usnawati, S.ST., M.Keb.

Lahir di Ponorogo, 12 Maret 1979. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Pemda Ponorogo tahun 1998. Lulus Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Depkes Kediri tahun 2001. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Lulus Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014. Sejak tahun 2002 hingga saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang Kebidanan.

Beberapa buku yang sudah diterbitkan antara lain: Modul Ajar Kebidanan: Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Book Bab: Kesehatan Masyarakat di era 5.0; Book Bab: Konsep Pelayanan Kontrasepsi dan KB; Book Bab: Kesehatan Keluarga; Book Bab: Aplikasi Terapi Komplementer di Kebidanan; Buku Ajar Prakonsepsi; Monograf: Kombinasi Accupressure Points for Lactations dan Breast Massage untuk Memantau Kecukupan ASI bagi Bayi; Monograf: Aplikasi Mobile Bunda ASI Pemantauan Waktu Pengeluaran dan Kecukupan ASI bagi Bayi; Monograf: Percepatan Produksi dan Kecukupan ASI bagi Bayi dengan Teknik Breast Care dan Accupressure Point for Lactation (BREAC); Monograf: m-Health Aplikasi Bunda ASI: Solusi Meningkatkan ASI eksklusif; Buku Pemberdayaan Kelompok Pendukung ASI dan Pendampingan Menyusui; Buku Sukses UKOM D3 Bidan; Buku Prakonsepsi; Buku Asuhan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal; Buku Evidence Based Kasus Soal Kebidanan komunitas II; Monograf: Edu-Fas Deteksi Dini Depresi Postpartum Berbasis Android; Monograf: Gadget dan Perkembangan Emosional bagi Anak Usia Dini; Buku Diagnosis Bidan Perimenopause; Buku Asuhan Kebidanan Reproduksi Remaja dan Pasangan Usia Subur; Buku Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Bencana; Buku Standar Operasional Prosedur Asuhan Kebidanan Masa Persalinan; Buku OSCE Profesi Bidan; Buku Ajar Konsep Kebidanan; Monograf: Aplikasi Edu-Fas: Solusi Inovatif Berbasis Android untuk Deteksi Dini Depresi Postpartum; Book Bab: Pentingnya Nutrisi dan Bahaya Stunting. Book Bab; Ilmu Kebidanan Dasar; Monograf: "SIMANIS" (SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL) Inovasi Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk Deteksi dini Infeksi Menular Seksual Pada Remaja; Buku Bank Soal UKOM Kebidanan Terstandar Nasional & Pembahasan Mendalam; Buku: Asuhan Kebidanan Kehamilan. Penulis juga aktif sebagai anggota IBI sejak tahun 2004 sekarang.

Email Penulis: nanausnawati@gmail.com WA. 085334452192

PROFIL PENULIS



Febrina Dwi Nurcahyanti, S.ST., MPH.

Lahir di Kediri, 16 Februari 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Universitas Sebelas Maret tahun 2012. Kemudian tahun 2014 melanjutkan pendidikan S2 Prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas yang sama dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 2013 di STIKes Bhakti Mulia Kediri sampai saat ini dan mengampu beberapa mata kuliah diantaranya Komunikasi dan Konseling dalam Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, Askeb Persalinan dan Nifas, Konsep Kebidanan. Selain melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis juga berupaya untuk aktif dalam kegiatan penulisan buku, serta mengikuti seminar baik online maupun offline. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : febrina.d.nurcahyanti@gmail.com



Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.

Penulis dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 7 Agustus 1990. Editor adalah dosen tetap di Program Studi Sarjana Kebidanan, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan dan D-IV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Malang. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret. Beberapa mata kuliah yang diampu yaitu Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Remaja dan Pranikah, Asuhan Kehamilan Normal, Asuhan Pada Masa Menopause, Gangguan Sistem Reproduksi Wanita, dan Asuhan Kebidanan Komunitas. Beberapa karya telah dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi diantaranya Analysis of Maternal Mortality Determinants in Bondowoso District East Java, Analisis Health Belief Model dalam Perilaku Pencegahan Covid-19 pada Ibu Hamil, Minat Untuk Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks Berdasarkan Pendidikan Dan Paritas, serta beberapa judul lain yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Penulis juga aktif mengembangkan ilmu dalam bidang kesehatan ibu dan anak dengan mengikuti berbagai seminar dan pelatihan serta ikut aktif sebagai anggota dalam organisasi profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia). Penulis dapat dihubungi melalui email: ratnadiana00@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.

Lahir di Medan, 05 September 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Brawijaya, lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 di Institut Kesehatan Deli Husada. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatana Deli Husada mengampu mata kuliah Profesionalisme Kebidanan dan Gizi dalam Pelayanan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: septadwiin@gmail.com



Ima Candra Kusuma, S.ST., M.Tr.Keb.

Penulis mengawali pendidikan tinggi di bidang kebidanan dengan menempuh Program Studi Diploma III Kebidanan dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Diploma IV Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surakarta dan berhasil lulus pada tahun 2014. Untuk meningkatkan kompetensi akademik dan profesional, penulis melanjutkan pendidikan Magister Terapan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang dan menyelesaikan studi pada tahun 2017. Karier profesional penulis dimulai sebagai dosen kebidanan pada tahun 2019. Saat ini, penulis aktif mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Klaten. Dalam menjalankan profesinya, penulis memiliki minat yang besar pada bidang kesehatan ibu dan anak, kebidanan komunitas, kesehatan reproduksi, serta promosi kesehatan masyarakat. Komitmen penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan diwujudkan melalui upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kebidanan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imacandrakusuma@gmail.com

Motto: "Mengabdikan dengan ilmu, mendidik dengan ketulusan hati, dan berkarya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak."

PROFIL PENULIS



Bdn. Wilda Rezki Pratiwi, S.ST., M.Kes.

Lahir di Panincong 06 Desember 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Lulus di tahun 2017. Kemudian sekarang di tahun 2026 aktif sebagai mahasiswa pada Program Doctoral (S3) pada Universitas Strada Indonesia. Riwayat pekerjaan diawali pada 2014 sebagai dosen tetap di Program Studi Kebidanan ITKES Muhammadiyah Sidrap dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Profesi bidan ditahun 2020-2024 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kerjasama di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap.

Sebagai akademisi, saya aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karya ilmiahnya banyak berfokus pada kesehatan reproduksi, perkembangan anak, serta isu-isu kebidanan. Selain itu, juga berkontribusi sebagai penulis dan kolaborator dalam berbagai buku ajar kebidanan, seperti Asuhan Kebidanan Komplementer, Asuhan Kebidanan pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah dan Aplikasi Kelas Ibu Hamil di Era Millenials dan Senam Dismenore serta menulis buku ajar terkait kebidanan dan kesehatan ibu-anak yang digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wiildapратиwi06@gmail.com

Motto: "Living your life well" **"Berkarya dengan ilmu, menginspirasi dengan keteladanan, dan mengabdikan dengan hati sebagai perempuan dan pendidik."**

Sinopsis

Bunga rampai *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui* disusun sebagai rujukan komprehensif bagi mahasiswa, praktisi kebidanan, dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menerapkan asuhan pada masa nifas dan periode laktasi sebagai fase kritis setelah persalinan yang melibatkan pemulihan organ reproduksi, penyesuaian fisiologis, serta adaptasi psikologis dan sosial, sekaligus menentukan kesehatan ibu dan bayi melalui keberhasilan menyusui yang memerlukan dukungan berkelanjutan dan berbasis bukti; buku ini membahas secara terstruktur konsep dasar masa nifas dan laktasi sebagai landasan praktik, perubahan fisiologis dan psikologis ibu postpartum termasuk dinamika emosi dan risiko gangguan suasana hati, langkah pengkajian kebidanan yang komprehensif mencakup pemeriksaan fisik, status psikologis, penilaian laktasi, identifikasi faktor risiko, dan dokumentasi asuhan, perawatan rutin ibu nifas serta pencegahan dan deteksi dini komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi nifas, subinvolusi, tromboemboli, dan masalah lainnya, dukungan pemberian ASI melalui inisiasi menyusui dini, posisi dan pelekatan yang benar, konseling, serta penanganan masalah menyusui seperti puting lecet, bendungan ASI, mastitis, dan produksi ASI rendah, hingga penguatan peran keluarga—termasuk suami dan lingkungan terdekat—dalam dukungan emosional, informasional, dan praktis untuk mempercepat pemulihan ibu, mencegah stres, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberhasilan menyusui, sehingga pada akhirnya buku ini diharapkan memperkuat kompetensi kebidanan yang holistik, responsif, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan capaian kesehatan maternal-neonatal.

Bunga rampai Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui disusun sebagai rujukan komprehensif bagi mahasiswa, praktisi kebidanan, dan tenaga kesehatan dalam memahami serta menerapkan asuhan pada masa nifas dan periode laktasi sebagai fase kritis setelah persalinan yang melibatkan pemulihan organ reproduksi, penyesuaian fisiologis, serta adaptasi psikologis dan sosial, sekaligus menentukan kesehatan ibu dan bayi melalui keberhasilan menyusui yang memerlukan dukungan berkelanjutan dan berbasis bukti; buku ini membahas secara terstruktur konsep dasar masa nifas dan laktasi sebagai landasan praktik, perubahan fisiologis dan psikologis ibu postpartum termasuk dinamika emosi dan risiko gangguan suasana hati, langkah pengkajian kebidanan yang komprehensif mencakup pemeriksaan fisik, status psikologis, penilaian laktasi, identifikasi faktor risiko, dan dokumentasi asuhan, perawatan rutin ibu nifas serta pencegahan dan deteksi dini komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi nifas, subinvolusi, tromboemboli, dan masalah lainnya, dukungan pemberian ASI melalui inisiasi menyusui dini, posisi dan pelekatan yang benar, konseling, serta penanganan masalah menyusui seperti puting lecet, bendungan ASI, mastitis, dan produksi ASI rendah, hingga penguatan peran keluarga—termasuk suami dan lingkungan terdekat—dalam dukungan emosional, informasional, dan praktis untuk mempercepat pemulihan ibu, mencegah stres, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberhasilan menyusui, sehingga pada akhirnya buku ini diharapkan memperkuat kompetensi kebidanan yang holistik, responsif, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan capaian kesehatan maternal-neonatal.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-59-6 (PDF)



9

786347

756596